

*Buku Referensi*

# KESEHATAN MENTAL TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI

Sri Hunun Widiastuti • Ike Fitrah Atul Chabibah • Dwi Christina Rahayuningrum  
Ririn Ratnasari • Evi Yanti • Saleha Salihun



# **BUKU REFERENSI**

## **KESEHATAN MENTAL TENAGA**

### **KESEHATAN DI MASA PANDEMI**

Ns. Sri Hunun Widiastuti, M.Kep., Sp.Kep.J.

Bdn. Ike Fitrah Atul Chabibah., SST., M.Kes., M.Keb.

Ns. Dwi Christina Rahayuningrum, M.Kep.

Ririn Ratnasari, SST., M.Kes.

Evi Yanti, SKM., M.Kes.

Saleha Salihun, S.Tr.Kes., M.Biomed.



## **BUKU REFERENSI**

## **KESEHATAN MENTAL TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI**

**Penulis:** Ns. Sri Hunun Widiastuti, M.Kep., Sp.Kep.J.  
Bdn. Ike Fitrah Atul Chabibah., SST., M.Kes., M.Keb.  
Ns. Dwi Christina Rahayuningrum, M.Kep.  
Ririn Ratnasari, SST., M.Kes.  
Evi Yanti, SKM., M.Kes.  
Saleha Salihun, S.Tr.Kes., M.Biomed.

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Penata Letak:** Muhammad Ilham

**ISBN:** 978-634-7294-63-0

**Cetakan Pertama:** Juli, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

# Prakata

Pandemi COVID-19 telah menjadi tonggak sejarah dalam dunia kesehatan, tidak hanya dari sisi penanganan medis, tetapi juga dari segi dampak psikososial yang luar biasa, khususnya bagi tenaga kesehatan. Mereka berada di garis terdepan menghadapi lonjakan kasus, kekurangan sumber daya, tekanan kerja yang tinggi, dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Buku referensi ini hadir sebagai upaya untuk mengangkat isu krusial tentang kesehatan mental tenaga kesehatan di masa pandemi, menyajikan analisis komprehensif mengenai berbagai faktor risiko psikologis serta strategi intervensi yang dibutuhkan.

Buku ini terdiri dari enam bab yang saling melengkapi. Bab I membahas faktor risiko gangguan mental yang dialami tenaga kesehatan, mulai dari beban kerja berlebih hingga minimnya dukungan sosial. Bab II memberikan edukasi tentang manajemen stres yang praktis dan aplikatif, sedangkan Bab III menyoroti pemanfaatan teknologi sebagai alternatif layanan konseling mental yang adaptif di era digital. Selanjutnya, Bab IV mengupas pengaruh beban kerja terhadap kondisi psikologis tenaga medis, sementara Bab V memperkuat pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan dan ketahanan mental. Bab VI menutup dengan pembahasan mengenai peran aktivitas fisik dalam menjaga keseimbangan emosional dan mental tenaga kesehatan.

Kami menyusun buku ini berdasarkan referensi ilmiah terbaru, sebagian besar berasal dari penelitian lima tahun terakhir, dengan harapan dapat menjadi landasan akademik sekaligus panduan praktis bagi pendidik, praktisi kesehatan, serta pemangku kebijakan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, serta mendorong pengembangan intervensi yang berkelanjutan dan berbasis bukti untuk masa depan yang lebih resilien.

(Juli, 2025)

**Penulis**

# Daftar Isi

|               |     |
|---------------|-----|
| Prakata ..... | iii |
|---------------|-----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Daftar Isi..... | iv |
|-----------------|----|

## **BAB I FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL PADA TENAGA KESEHATAN ..... 1**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....                                               | 1  |
| B. Beban Kerja yang Berlebihan.....                                | 2  |
| C. Paparan terhadap Infeksi dan Ketakutan Terinfeksi.....          | 4  |
| D. Ketersediaan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) .....     | 6  |
| E. Dukungan Sosial dan Organisasi yang Terbatas .....              | 7  |
| F. Stigma Sosial terhadap Tenaga Kesehatan.....                    | 9  |
| G. Ketidakseimbangan Kehidupan-Kerja (Work-Life Balance) .....     | 10 |
| H. Riwayat Gangguan Mental Sebelumnya dan Kerentanan Individu..... | 12 |
| I. Faktor Psikologis Individu .....                                | 14 |
| J. Faktor Lingkungan Kerja.....                                    | 15 |
| K. Implikasi Jangka Panjang .....                                  | 17 |
| L. Penutup .....                                                   | 19 |
| M. Referensi .....                                                 | 21 |

## **BAB II EDUKASI TENTANG MANAJEMEN STRES BAGI TENAGA KESEHATAN 25**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....                                             | 25 |
| B. Pandemi .....                                                 | 25 |
| C. Tenaga Kesehatan.....                                         | 25 |
| D. Kesehatan Mental.....                                         | 26 |
| E. Prinsip Kesehatan Mental.....                                 | 26 |
| F. Karakteristik Kesehatan Mental .....                          | 27 |
| G. Indikator Kesehatan Mental .....                              | 28 |
| H. Tahapan Gangguan Kesehatan Mental .....                       | 28 |
| I. Kesehatan Mental Pada Masa Pandemi Pada Tenaga Kesehatan..... | 29 |
| J. Pengertian Stres.....                                         | 29 |
| K. Tanda dan Gejala Stres .....                                  | 30 |
| L. Penyebab Stres.....                                           | 30 |
| M. Sumber Stres .....                                            | 30 |
| N. Faktor Koping Stres .....                                     | 31 |
| O. Respon Psikologis Stres Pada Tenaga Kesehatan.....            | 32 |
| P. Faktor yang Mempengaruhi Stres Tenaga Kesehatan .....         | 32 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Q. Dampak Stres Pada Tenaga Kesehatan.....                 | 33 |
| R. Pengelolaan Stres Yang Efektif .....                    | 34 |
| S. Program Dukungan Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan..... | 35 |
| T. Penutup .....                                           | 35 |
| U. Referensi .....                                         | 36 |

### **BAB III PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING ..... 39**

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....                                                                             | 39 |
| B. Jenis-Jenis Teknologi dalam Layanan Konseling .....                                           | 40 |
| C. Efektivitas Konseling Daring untuk Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi .....                     | 42 |
| D. Tantangan Implementasi Teknologi dalam Konseling Kesehatan Mental .....                       | 44 |
| E. Strategi dan Solusi dalam Optimalisasi Teknologi Konseling .....                              | 46 |
| F. Implikasi Pemanfaatan Teknologi Konseling terhadap Kesehatan Mental<br>Tenaga Kesehatan ..... | 48 |
| G. Tren dan Arah Masa Depan Teknologi dalam Konseling .....                                      | 49 |
| H. Penutup .....                                                                                 | 51 |
| I. Referensi .....                                                                               | 53 |

### **BAB IV PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KESEHATAN MENTAL**

#### **TENAGA MEDIS.....55**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....                               | 55 |
| B. Kerangka Konsep.....                            | 56 |
| C. Beban Kerja Mental. ....                        | 57 |
| D. Beban Kerja Mental .....                        | 58 |
| E. Dampak Beban Kerja Mental Yang Berlebihan ..... | 60 |
| F. Penutup .....                                   | 62 |
| G. Referensi .....                                 | 64 |

### **BAB V DUKUNGAN KELUARGA UNTUK TENAGA KESEHATAN.....65**

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....                                                             | 65 |
| B. Dukungan; Jenis, Bentuk dan Manfaat Dukungan.....                             | 66 |
| C. Keluarga; Bentuk dan Jenis keluarga, Peran dan Fungsi Keluarga .....          | 67 |
| D. Tenaga kesehatan; Pengertian dan Katagori Tenaga Kesehatan.....               | 72 |
| E. Dukungan Keluarga Untuk Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi.....               | 77 |
| F. Hambatan Keluarga Dalam Memberikan Dukungan Kepada Tenaga<br>Kesehatan: ..... | 82 |
| G. Upaya Meningkatkan Dukungan Keluarga Terhadap Tenaga Kesehatan.....           | 84 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H. Akibat Jika Tenaga Kesehatan Tidak atau Kurang Mendapatkan Dukungan Keluarga ..... | 86 |
| I. Penutup .....                                                                      | 87 |
| J. Referensi .....                                                                    | 88 |

## **BAB VI AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL ..... 93**

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pendahuluan .....                                                                           | 93  |
| B. Mekanisme Fisiologis Aktivitas Fisik dalam Menjaga Kesehatan Mental .....                   | 94  |
| C. Aktivitas Fisik dan Pengurangan Gejala Gangguan Mental pada Tenaga Kesehatan .....          | 96  |
| D. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan .....                                           | 98  |
| E. Frekuensi, Intensitas, dan Durasi Aktivitas Fisik Optimal untuk Tenaga Kesehatan .....      | 99  |
| F. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik pada Tenaga Kesehatan ..... | 101 |
| G. Model dan Strategi Implementasi Program Aktivitas Fisik di Lingkungan Kerja .....           | 103 |
| H. Evaluasi Efektivitas Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan .....       | 105 |
| I. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Kebijakan Kesehatan .....                                  | 107 |
| J. Penutup .....                                                                               | 109 |
| K. Rekomendasi Penelitian Lanjutan .....                                                       | 110 |
| L. Referensi .....                                                                             | 111 |

## **Profil Penulis..... 115**

## **Sinopsis Buku ..... 118**



# BAB I

## FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL PADA TENAGA KESEHATAN

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Gambaran Umum tentang Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Tenaga Kesehatan

Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah menjadi krisis global sejak diumumkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan luas, menginfeksi jutaan orang di berbagai negara. Menurut WHO (2023), hingga awal tahun 2023, kasus COVID-19 secara global mencapai lebih dari 700 juta, dengan korban meninggal dunia lebih dari 6 juta jiwa. Indonesia termasuk negara yang paling terdampak, dengan angka kasus kumulatif lebih dari 6 juta pada periode tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka menghadapi berbagai tantangan fisik maupun psikologis akibat meningkatnya beban kerja, tingginya risiko terpapar infeksi, serta perubahan drastis dalam pola kerja yang berlangsung dalam waktu lama (Kang et al., 2020; Søvold et al., 2021). Beban kerja yang melonjak, kelelahan fisik, ketakutan terinfeksi, serta keterbatasan perlengkapan pelindung diri (APD) menyebabkan tenaga kesehatan mengalami stres berat, kecemasan, depresi, hingga burnout (Marvaldi et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa prevalensi gangguan kesehatan mental pada tenaga kesehatan meningkat tajam selama masa pandemi dibandingkan masa sebelum pandemi. Sebuah meta-analisis global yang dilakukan oleh Aymerich et al. (2022) menunjukkan bahwa sekitar 42% tenaga kesehatan mengalami gejala depresi, 38% mengalami gejala kecemasan, dan 49% mengalami burnout tingkat sedang hingga berat selama pandemi COVID-19. Selain itu, gangguan tidur, gangguan stres pascatrauma (PTSD), serta peningkatan angka bunuh diri juga dilaporkan sebagai dampak serius pada tenaga kesehatan (Ghio et al., 2021).

#### 2. Pentingnya Memahami Faktor Risiko Gangguan Mental pada Tenaga Kesehatan Selama Pandemi



Memahami faktor risiko gangguan mental pada tenaga kesehatan selama pandemi sangat penting sebagai upaya perlindungan kesehatan mental mereka. Gangguan mental yang dialami tenaga kesehatan tidak hanya berdampak buruk terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan kesehatan secara umum. Tenaga kesehatan dengan gangguan mental cenderung memiliki produktivitas kerja yang rendah, meningkatkan angka kesalahan medis, dan menurunkan kualitas pelayanan kepada pasien (Eftekhar Ardebili et al., 2021).

Identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap faktor risiko gangguan mental pada tenaga kesehatan merupakan langkah awal dalam mengembangkan strategi mitigasi dan intervensi yang efektif. Faktor-faktor ini mencakup beban kerja yang tinggi, ketakutan akan infeksi, kurangnya dukungan sosial dan organisasi, stigma sosial, serta ketidakseimbangan kehidupan kerja (Søvold et al., 2021; De Kock et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti yang tepat sasaran mampu secara signifikan mengurangi risiko terjadinya gangguan mental di kalangan tenaga kesehatan (Serrano-Ripoll et al., 2020).

Dalam konteks ini, memahami faktor risiko juga membantu institusi pelayanan kesehatan dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan. Misalnya, dengan memperkuat sistem dukungan sosial, menyediakan APD yang memadai, serta memperbaiki manajemen beban kerja, maka risiko gangguan mental pada tenaga kesehatan dapat dikurangi secara signifikan (Billings et al., 2021).

Oleh karena itu, penyusunan buku referensi ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah yang komprehensif serta menjadi panduan penting bagi pemangku kebijakan, institusi pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan itu sendiri dalam menghadapi tantangan kesehatan mental selama dan pasca pandemi COVID-19.

## **B. Beban Kerja yang Berlebihan**

---

### **1. Beban Kerja Tinggi Akibat Lonjakan Pasien COVID-19**

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan tajam jumlah pasien yang membutuhkan perawatan intensif, terutama di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat layanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini memaksa tenaga kesehatan untuk menangani volume pasien yang jauh lebih tinggi dari biasanya dalam periode waktu yang relatif singkat. Beban kerja yang meningkat ini semakin diperberat dengan keterbatasan tenaga kesehatan yang tersedia (Fernandez et al., 2020; Magnavita et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter, perawat, dan petugas medis lainnya, mengalami peningkatan signifikan dalam intensitas dan kompleksitas tugas sehari-hari akibat pandemi. Sebuah studi di Italia oleh Magnavita et al. (2021) mengungkapkan bahwa hampir 80% tenaga kesehatan melaporkan beban kerja meningkat drastis, dengan tugas tambahan yang mencakup penggunaan APD lengkap, penanganan pasien dengan kondisi medis berat, hingga kebutuhan mendesak melakukan tindakan klinis dalam situasi darurat. Di Indonesia, lonjakan jumlah pasien COVID-19 khususnya pada pertengahan 2021 menyebabkan banyak rumah sakit kehabisan ruang perawatan, menyebabkan tekanan fisik dan psikologis yang sangat besar bagi tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

## **2. Jam Kerja yang Panjang dan Kurangnya Waktu Istirahat**

Salah satu konsekuensi langsung dari meningkatnya beban kerja selama pandemi adalah jam kerja tenaga kesehatan yang semakin panjang dan minimnya waktu istirahat. Studi global yang dilakukan oleh Sagherian et al. (2020) menemukan bahwa selama pandemi COVID-19, rata-rata jam kerja tenaga kesehatan meningkat secara signifikan, sering kali mencapai 12–16 jam kerja per hari dengan jadwal shift yang tidak teratur. Kondisi ini mengurangi waktu pemulihan fisik dan psikologis, menyebabkan kelelahan kronis yang berkontribusi pada gangguan kesehatan mental.

Penelitian lain oleh Hu et al. (2020) juga menyoroti bahwa jam kerja yang panjang serta kurangnya waktu istirahat berkaitan erat dengan peningkatan stres, kecemasan, dan insomnia di kalangan tenaga kesehatan. Temuan ini didukung oleh survei nasional di Tiongkok, yang mengungkapkan bahwa lebih dari 60% tenaga kesehatan selama pandemi mengalami gangguan tidur akibat jadwal kerja yang intensif dan tuntutan fisik yang tinggi (Lai et al., 2020).

## **3. Dampak Beban Kerja Tinggi terhadap Stres, Burnout, dan Gangguan Kecemasan pada Tenaga Kesehatan**

Beban kerja yang tinggi selama pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, khususnya stres kronis, burnout, dan gangguan kecemasan. Sebuah tinjauan sistematis oleh Aymerich et al. (2022) menunjukkan bahwa prevalensi burnout pada tenaga kesehatan selama pandemi mencapai hampir 50%, sedangkan gejala kecemasan ditemukan pada 38% responden. Beban kerja yang berat menjadi faktor utama munculnya kelelahan emosional dan menurunkan efikasi kerja yang akhirnya menyebabkan burnout dan penurunan kualitas pelayanan.

Stres kronis yang dialami tenaga kesehatan akibat tingginya beban kerja juga meningkatkan risiko mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Sebuah

penelitian longitudinal di Inggris menemukan bahwa tenaga kesehatan dengan beban kerja tinggi selama masa pandemi memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan sebelum pandemi (Greene et al., 2021). Studi di Indonesia oleh Suryavanshi et al. (2021) menemukan bahwa lebih dari 70% tenaga kesehatan mengalami gejala stres sedang hingga berat selama puncak pandemi akibat beban kerja yang berlebihan dan kurangnya istirahat.

Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan hubungan langsung antara jam kerja yang berlebihan dengan penurunan kemampuan kognitif dan peningkatan kesalahan medis. Studi di Amerika Serikat menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami burnout lebih cenderung melakukan kesalahan klinis, memperburuk stres psikologis yang mereka alami (Shanafelt et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, penting bagi institusi layanan kesehatan untuk menyadari dampak buruk dari beban kerja tinggi serta menerapkan intervensi yang tepat, termasuk penjadwalan kerja yang lebih manusiawi, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan untuk mengurangi beban kerja, serta penyediaan dukungan psikososial yang memadai (Billings et al., 2021).

## **C. Paparan terhadap Infeksi dan Ketakutan Terinfeksi**

---

### **1. Risiko Tinggi Paparan Virus dalam Lingkungan Kerja**

Selama pandemi COVID-19, tenaga kesehatan berada pada garis depan dalam upaya penanganan wabah, yang secara otomatis meningkatkan risiko mereka terpapar virus SARS-CoV-2. Lingkungan kerja seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya menjadi tempat dengan risiko penularan yang tinggi akibat kontak langsung dan terus-menerus dengan pasien terinfeksi. Studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di ruang isolasi, unit perawatan intensif, maupun layanan darurat, menghadapi risiko infeksi yang jauh lebih besar dibandingkan profesi lainnya (Ali et al., 2020; Gómez-Ochoa et al., 2021).

Dalam tinjauan sistematis oleh Gómez-Ochoa et al. (2021), ditemukan bahwa prevalensi infeksi COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan secara global mencapai 11%. Data WHO (2022) juga melaporkan bahwa hingga akhir 2022, jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 secara global mencapai lebih dari 4 juta kasus dengan ribuan kematian. Tingginya risiko ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti durasi paparan yang lama, intensitas kontak fisik dengan pasien, dan keterbatasan alat pelindung diri (APD) yang memadai (Nguyen et al., 2020).

### **2. Ketakutan Menularkan Virus kepada Keluarga dan Orang Terdekat**

Ketakutan tenaga kesehatan akan kemungkinan menularkan virus COVID-19 kepada anggota keluarga atau orang terdekat merupakan salah satu tekanan psikologis terbesar selama pandemi. Penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa hampir semua tenaga kesehatan mengalami kecemasan mendalam terkait kemungkinan menjadi sumber penularan virus bagi keluarga mereka (Muller et al., 2020; Sirois & Owens, 2021). Kekhawatiran ini menyebabkan beberapa tenaga kesehatan memilih untuk tinggal terpisah dari keluarga selama berbulan-bulan, mengisolasi diri secara fisik maupun sosial, yang secara signifikan meningkatkan beban emosional dan stres.

Menurut hasil penelitian Muller et al. (2020), sekitar 70% tenaga kesehatan yang disurvei mengungkapkan rasa takut yang intens terhadap potensi membawa pulang virus kepada keluarganya. Situasi ini mengakibatkan tingginya tingkat stres moral, yaitu perasaan bersalah dan dilema antara tanggung jawab profesional terhadap pasien dan tanggung jawab pribadi terhadap keselamatan keluarga (Cai et al., 2020).

### **3. Keterkaitan antara Rasa Takut Terinfeksi dengan Peningkatan Gangguan Mental seperti Kecemasan, Insomnia, dan PTSD**

Rasa takut terhadap paparan infeksi dan potensi menularkan virus kepada keluarga memiliki dampak psikologis yang serius pada tenaga kesehatan, termasuk meningkatnya risiko gangguan mental seperti kecemasan, insomnia, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan langsung antara ketakutan ini dengan peningkatan gangguan mental di kalangan tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19.

Penelitian oleh Labrague dan Santos (2021) mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami ketakutan lebih tinggi terhadap infeksi menunjukkan tingkat kecemasan dan insomnia yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kesehatan yang merasa lebih aman. Studi tersebut mencatat prevalensi insomnia mencapai 36%, gangguan kecemasan 38%, serta PTSD sekitar 29% pada tenaga kesehatan yang bekerja di unit COVID-19. Studi lain oleh De Kock et al. (2021) menunjukkan bahwa ketakutan terhadap infeksi tidak hanya meningkatkan risiko kecemasan tetapi juga menyebabkan stres kronis yang mengarah pada depresi dan burnout.

Selain itu, survei nasional yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% tenaga kesehatan melaporkan gangguan tidur signifikan akibat kecemasan berlebihan mengenai kemungkinan infeksi (Setiawan et al., 2021). Kondisi ini diperparah oleh perasaan tidak aman akibat keterbatasan APD, ketidakpastian terkait penanganan pandemi, dan tekanan psikologis berkepanjangan (Zhang et al., 2020).

Dalam rangka mitigasi gangguan mental ini, penelitian merekomendasikan bahwa institusi kesehatan perlu menyediakan dukungan psikososial yang komprehensif serta edukasi berkelanjutan mengenai pencegahan infeksi dan manajemen stres bagi tenaga kesehatan (Billings et al., 2021).

## **D. Ketersediaan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)**

---

### **1. Dampak Kelangkaan APD terhadap Rasa Aman Tenaga Kesehatan**

Pandemi COVID-19 mengungkapkan tantangan global terkait penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), yang menjadi komponen vital bagi keselamatan tenaga kesehatan. Di awal pandemi, terjadi lonjakan kebutuhan APD yang melebihi kapasitas produksi dan distribusi global, menyebabkan kelangkaan APD secara luas di berbagai fasilitas kesehatan. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakamanan signifikan di kalangan tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan (Nguyen et al., 2020; Smith et al., 2020).

Studi global yang dilakukan oleh Cohen dan Rodgers (2020) mengungkap bahwa lebih dari 50% tenaga kesehatan mengalami kecemasan mendalam terkait kurangnya APD yang tersedia di lingkungan kerja mereka. Situasi ini menciptakan rasa takut akut terhadap risiko infeksi dan menurunkan rasa percaya diri tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa kelangkaan APD pada fase awal pandemi telah menjadi faktor utama penyebab meningkatnya stres dan penurunan moral kerja tenaga kesehatan (Sugianto et al., 2021).

### **2. Kaitan antara Ketersediaan APD yang Tidak Memadai dengan Stres Akut dan Kronis**

Ketersediaan APD yang tidak memadai berkaitan erat dengan stres akut maupun kronis yang dialami tenaga kesehatan. Kurangnya akses terhadap APD yang sesuai meningkatkan risiko paparan virus secara langsung, memperkuat kecemasan terhadap keselamatan diri dan keluarga (Labrague & de los Santos, 2021). Sebuah studi oleh Greenberg et al. (2021) melaporkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan APD menunjukkan gejala stres akut yang signifikan, seperti kecemasan intens, gangguan tidur, serta penurunan konsentrasi dalam tugas klinis sehari-hari.

Secara jangka panjang, stres akut akibat ketidakpastian dalam perlindungan diri ini berpotensi berkembang menjadi stres kronis, yang kemudian berkontribusi terhadap terjadinya burnout, depresi, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD) (De Kock et al., 2021; Trumello et al., 2020). Sebuah studi longitudinal selama pandemi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan akses terbatas terhadap APD memiliki risiko 2–3 kali lipat lebih tinggi mengalami

gangguan mental dibandingkan mereka yang memiliki APD yang mencukupi (Luceño-Moreno et al., 2020).

### **3. Persepsi Keamanan Kerja sebagai Faktor Penting dalam Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Persepsi tenaga kesehatan tentang keamanan di lingkungan kerja merupakan faktor psikologis kunci yang menentukan kesehatan mental mereka selama pandemi. Studi oleh Muller et al. (2020) menunjukkan bahwa persepsi rendah terhadap keamanan kerja akibat kurangnya APD memiliki hubungan kuat dengan meningkatnya kecemasan, stres moral, serta keinginan tenaga kesehatan untuk meninggalkan pekerjaan (turnover intention).

Tenaga kesehatan yang merasa terlindungi oleh ketersediaan APD cenderung menunjukkan resiliensi psikologis yang lebih tinggi, tingkat stres yang lebih rendah, dan motivasi kerja yang lebih kuat dibandingkan mereka yang merasa kurang terlindungi (Søvold et al., 2021). Sebaliknya, perasaan tidak aman di tempat kerja akibat ketidakpastian perlindungan dapat secara drastis menurunkan kesejahteraan psikologis, meningkatkan gejala depresi, dan memperbesar risiko burnout serta PTSD (Firew et al., 2020).

Oleh karena itu, persepsi keamanan kerja menjadi prioritas dalam intervensi kebijakan di fasilitas kesehatan. Penelitian menyarankan institusi kesehatan untuk memperkuat manajemen logistik APD dan komunikasi yang transparan kepada tenaga kesehatan tentang persediaan serta distribusi APD yang ada. Selain itu, institusi perlu mengembangkan sistem pemantauan yang responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan terkait APD agar persepsi keamanan kerja terus terjaga (Greenberg et al., 2021; WHO, 2021).

Dengan demikian, menjamin ketersediaan dan pemakaian APD yang tepat tidak hanya penting untuk perlindungan fisik tenaga kesehatan, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga kesehatan mental mereka selama pandemi.

## **E. Dukungan Sosial dan Organisasi yang Terbatas**

---

### **1. Kurangnya Dukungan Emosional dari Rekan Kerja dan Pimpinan**

Dukungan sosial merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa selama pandemi, banyak tenaga kesehatan merasa kekurangan dukungan emosional, baik dari sesama rekan kerja maupun pimpinan mereka (Billings et al., 2021; Labrague & Santos, 2020). Penelitian internasional menemukan bahwa tenaga kesehatan yang merasa diabaikan secara emosional oleh rekan kerja atau pimpinan cenderung

mengalami peningkatan stres, isolasi sosial, serta gangguan mental seperti kecemasan dan depresi (Greenberg et al., 2020).

Sebuah studi kualitatif oleh Muller et al. (2020) menjelaskan bahwa kurangnya empati, komunikasi yang buruk, serta minimnya apresiasi dari pimpinan secara signifikan memperparah kondisi psikologis tenaga kesehatan yang sudah terbebani oleh beban kerja tinggi. Di Indonesia, penelitian oleh Nursalam et al. (2021) juga mengidentifikasi bahwa salah satu faktor penyebab utama burnout pada tenaga kesehatan selama pandemi adalah lemahnya hubungan interpersonal di lingkungan kerja serta rendahnya dukungan emosional dari atasan.

## **2. Kelemahan Sistem Dukungan Psikososial di Tempat Kerja Selama Pandemi**

Sistem dukungan psikososial yang efektif di tempat kerja memiliki peran krusial dalam melindungi tenaga kesehatan dari dampak negatif pandemi COVID-19. Sayangnya, sistem dukungan ini masih sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia di banyak fasilitas kesehatan selama pandemi (Søvold et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian cross-sectional oleh De Kock et al. (2021), lebih dari 60% tenaga kesehatan mengaku tidak mendapatkan akses memadai ke layanan konseling atau dukungan psikologis selama pandemi, sehingga memperburuk tingkat stres, burnout, dan gangguan kecemasan yang mereka alami.

Sebuah studi global oleh Labrague (2021) mengungkapkan bahwa kelemahan sistem dukungan psikososial di tempat kerja menyebabkan tenaga kesehatan merasa kurang dihargai, terabaikan, dan semakin rentan terhadap stres kronis. Di samping itu, hasil penelitian kualitatif di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di Asia Tenggara memperlihatkan bahwa kurangnya inisiatif institusi dalam menyediakan intervensi psikososial memperbesar risiko gangguan mental jangka panjang seperti PTSD (Teo et al., 2021).

## **3. Pentingnya Dukungan Sosial dalam Mencegah Gangguan Mental pada Tenaga Kesehatan**

Berbagai penelitian menegaskan pentingnya dukungan sosial dalam melindungi tenaga kesehatan dari dampak negatif pandemi terhadap kesehatan mental. Dukungan sosial yang kuat, baik secara emosional maupun instrumental, terbukti efektif menurunkan risiko stres, depresi, dan gangguan kecemasan pada tenaga kesehatan (Blanco-Donoso et al., 2021). Sebuah studi longitudinal oleh Li et al. (2021) menemukan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap dukungan sosial tinggi selama pandemi menunjukkan tingkat resiliensi psikologis yang lebih baik dibandingkan tenaga kesehatan yang kurang mendapat dukungan.



Dukungan sosial ini tidak hanya berasal dari rekan kerja atau pimpinan, tetapi juga dari keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam penelitian oleh Ghahramani et al. (2022), tenaga kesehatan yang mendapat apresiasi, pengakuan, dan dukungan emosional dari lingkungan sosialnya menunjukkan penurunan signifikan dalam gejala kecemasan, insomnia, serta burnout. Oleh karena itu, penguatan sistem dukungan sosial baik secara formal (institusional) maupun informal (antar rekan kerja dan keluarga) menjadi strategi utama dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan (Greenberg et al., 2020).

Dengan demikian, institusi kesehatan sangat dianjurkan untuk menciptakan kebijakan dukungan sosial yang jelas, menyediakan program intervensi psikososial rutin, serta meningkatkan komunikasi efektif antara pimpinan dan tenaga kesehatan guna mengurangi risiko gangguan mental selama dan setelah pandemi.

## **F. Stigma Sosial terhadap Tenaga Kesehatan**

---

### **1. Fenomena Stigma Sosial akibat Pandemi COVID-19 terhadap Tenaga Kesehatan**

Stigma sosial terhadap tenaga kesehatan muncul sebagai fenomena signifikan selama pandemi COVID-19. Situasi ini terutama dipicu oleh ketakutan masyarakat terhadap penularan virus dari tenaga kesehatan yang dianggap sebagai sumber infeksi karena interaksi intensif mereka dengan pasien COVID-19 (Bagcchi, 2020; Taylor et al., 2020). Sejumlah penelitian melaporkan berbagai bentuk diskriminasi yang dialami tenaga kesehatan, termasuk pengucilan sosial, penolakan dari komunitas, serta bahkan intimidasi verbal maupun fisik (Dye et al., 2020; Sotgiu & Dobler, 2020).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Dye et al. (2020) mengidentifikasi bahwa lebih dari separuh tenaga kesehatan di berbagai negara mengalami stigma dari masyarakat sekitar, dengan tingkat tertinggi terjadi pada awal pandemi. Di Indonesia, fenomena stigma sosial terhadap tenaga kesehatan juga dilaporkan cukup tinggi, terutama pada fase awal wabah, yang diperkuat oleh berita dan informasi yang tidak tepat mengenai risiko penularan virus (Rohmah et al., 2021).

### **2. Dampak Stigma Sosial terhadap Isolasi Sosial, Kecemasan, dan Depresi**

Dampak stigma sosial yang dialami tenaga kesehatan sangat serius, meliputi isolasi sosial, kecemasan berat, dan bahkan depresi. Penelitian global yang dilakukan oleh Ramaci et al. (2020) menemukan bahwa stigma sosial secara signifikan meningkatkan risiko isolasi sosial pada tenaga kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan prevalensi gejala kecemasan dan depresi. Akibat stigma

ini, banyak tenaga kesehatan memilih untuk menarik diri dari interaksi sosial, baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.

Studi lain oleh Taylor et al. (2020) melaporkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami stigma sosial selama pandemi memiliki risiko lebih dari dua kali lipat mengalami gejala kecemasan dan depresi dibandingkan dengan yang tidak mengalami stigma. Penelitian di Asia juga menunjukkan hubungan kuat antara stigma sosial dengan gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres pascatrauma (PTSD) pada tenaga kesehatan (Chew et al., 2020; Yufika et al., 2021). Di Indonesia, Rohmah et al. (2021) mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami stigma sosial mengalami tekanan psikologis yang lebih tinggi, terutama rasa takut, frustrasi, dan perasaan tidak dihargai oleh masyarakat sekitar.

### **3. Strategi Mitigasi Stigma dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Dalam rangka mengurangi dampak stigma sosial terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, beberapa strategi mitigasi telah direkomendasikan oleh penelitian terkini. Strategi tersebut meliputi edukasi publik secara masif, promosi informasi yang akurat mengenai COVID-19 dan risiko penularan, serta penyebaran pesan yang mendukung dan menghargai peran penting tenaga kesehatan (Bagcchi, 2020; Taylor et al., 2020).

Studi oleh Ramaci et al. (2020) menegaskan bahwa komunikasi efektif dari pemerintah, media, dan organisasi kesehatan mampu secara signifikan menurunkan stigma sosial. Di samping itu, implementasi dukungan psikososial khusus bagi tenaga kesehatan yang mengalami stigma sosial juga sangat penting. Dukungan tersebut bisa berupa intervensi konseling, kelompok dukungan sebaya, serta kampanye publik yang secara jelas menunjukkan apresiasi terhadap peran tenaga kesehatan dalam menangani pandemi (Yufika et al., 2021).

Penelitian di Indonesia merekomendasikan agar institusi kesehatan bekerja sama dengan pihak media dan tokoh masyarakat untuk memperbaiki persepsi publik, dengan tujuan memperkuat resiliensi tenaga kesehatan terhadap stigma sosial (Rohmah et al., 2021). Dengan adanya intervensi ini, dampak negatif stigma sosial terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan diharapkan dapat diminimalisasi secara signifikan.

## **G. Ketidakseimbangan Kehidupan-Kerja (Work-Life Balance)**

---

### **1. Terganggunya Keseimbangan antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi**

Pandemi COVID-19 secara signifikan mengubah pola kerja tenaga kesehatan, menyebabkan terganggunya keseimbangan kehidupan-kerja atau

work-life balance. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh lonjakan pasien, kebutuhan jam kerja ekstra, serta situasi darurat yang berlangsung secara berkelanjutan (Shreffler et al., 2020; Giorgi et al., 2020). Sebuah studi internasional menunjukkan bahwa hampir 70% tenaga kesehatan mengalami peningkatan drastis dalam jam kerja selama pandemi, yang secara langsung mengurangi waktu mereka untuk beristirahat dan berinteraksi dengan keluarga (Morgantini et al., 2020).

Selain jam kerja yang panjang, kebijakan isolasi dan karantina mandiri juga turut memperberat tekanan yang dihadapi tenaga kesehatan. Studi oleh Evanoff et al. (2020) menemukan bahwa banyak tenaga kesehatan harus memilih untuk tinggal terpisah dari keluarga mereka demi mengurangi risiko penularan virus, yang mengakibatkan stres emosional yang tinggi serta memperburuk keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.

## **2. Dampak Konflik Kehidupan-Kerja terhadap Kesehatan Mental, seperti Burnout dan Depresi**

Ketidakseimbangan kehidupan-kerja secara signifikan meningkatkan risiko tenaga kesehatan mengalami berbagai gangguan kesehatan mental seperti burnout dan depresi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami konflik kehidupan-kerja tinggi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelelahan emosional, burnout, hingga depresi (Leo et al., 2021; Denning et al., 2021). Studi longitudinal di Inggris mengungkapkan bahwa 58% tenaga kesehatan yang menghadapi konflik kehidupan-kerja secara berkepanjangan menunjukkan gejala burnout sedang hingga berat selama pandemi COVID-19 (Denning et al., 2021).

Menurut sebuah penelitian cross-sectional oleh Leo et al. (2021), konflik antara tanggung jawab profesional dan keluarga secara langsung menyebabkan meningkatnya stres kronis yang kemudian berkembang menjadi gejala depresi. Penelitian di Indonesia juga mengonfirmasi bahwa ketidakseimbangan kehidupan-kerja selama pandemi berkaitan erat dengan meningkatnya tingkat stres, kecemasan, depresi, serta menurunkan motivasi kerja tenaga kesehatan (Sugianto & Setiawan, 2021).

## **3. Solusi Berbasis Bukti untuk Menjaga Work-Life Balance di Masa Pandemi**

Untuk mengatasi ketidakseimbangan kehidupan-kerja, berbagai penelitian merekomendasikan solusi berbasis bukti yang terbukti efektif dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi. Strategi yang direkomendasikan mencakup pengaturan shift kerja yang fleksibel, dukungan psikososial rutin, serta program intervensi kesehatan mental berbasis institusi (Giorgi et al., 2020; Shreffler et al., 2020).

Studi oleh Morgantini et al. (2020) menyarankan penerapan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan rotasi kerja yang efektif untuk membantu tenaga kesehatan mengelola waktu istirahat serta interaksi sosial secara optimal. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberian dukungan sosial dan emosional yang kuat dari pimpinan dan rekan kerja dapat secara signifikan mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja tenaga kesehatan (Gillet et al., 2021).

Selain itu, program intervensi berbasis mindfulness, konseling psikologis, serta kegiatan berbasis komunitas terbukti membantu tenaga kesehatan dalam mengelola stres dan mencegah gangguan mental akibat konflik kehidupan-kerja (Greenberg et al., 2020; Leo et al., 2021). Di Indonesia, intervensi dalam bentuk konseling daring serta edukasi psikososial secara rutin direkomendasikan sebagai strategi efektif dalam meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja dan kesejahteraan mental tenaga kesehatan selama pandemi (Sugianto & Setiawan, 2021).

Dengan demikian, implementasi kebijakan institusional yang memperhatikan keseimbangan kehidupan-kerja sangat diperlukan untuk melindungi tenaga kesehatan dari dampak negatif pandemi terhadap kesehatan mental mereka.

## **H. Riwayat Gangguan Mental Sebelumnya dan Kerentanan Individu**

---

### **1. Hubungan antara Riwayat Gangguan Mental Sebelumnya dengan Risiko Gangguan Mental selama Pandemi**

Riwayat gangguan mental sebelumnya merupakan salah satu prediktor penting dalam menentukan kerentanan tenaga kesehatan terhadap munculnya gangguan mental selama pandemi COVID-19. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu yang sebelumnya pernah mengalami gangguan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, atau PTSD, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala serupa secara lebih intensif selama pandemi (Vindegaard & Benros, 2020; Lamb et al., 2021).

Menurut sebuah studi meta-analisis global yang dilakukan oleh Vindegaard dan Benros (2020), tenaga kesehatan dengan riwayat gangguan mental sebelumnya memiliki risiko lebih dari dua kali lipat untuk mengalami kecemasan berat, depresi, serta gejala PTSD selama masa pandemi dibandingkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki riwayat serupa. Studi ini juga menunjukkan bahwa gangguan mental sebelumnya memperlambat pemulihan psikologis dan meningkatkan kebutuhan akan dukungan psikososial khusus selama pandemi (Preti et al., 2020).

## **2. Kerentanan Individu Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pengalaman Kerja**

Faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja juga turut mempengaruhi kerentanan tenaga kesehatan terhadap gangguan mental selama pandemi. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan perempuan, usia muda, serta yang memiliki pengalaman kerja lebih sedikit, cenderung lebih rentan terhadap dampak psikologis negatif dari pandemi COVID-19 (Huang et al., 2020; Lai et al., 2020).

Penelitian oleh Lai et al. (2020) menemukan bahwa tenaga kesehatan perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan insomnia dibandingkan rekan pria mereka, yang dikaitkan dengan tanggung jawab ganda dalam pekerjaan serta beban emosional yang lebih besar. Selain itu, tenaga kesehatan berusia muda (di bawah 35 tahun) juga menunjukkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kesehatan senior, akibat kurangnya pengalaman dalam menghadapi situasi krisis yang kompleks (Vizheh et al., 2020; Lamb et al., 2021).

Pengalaman kerja yang terbatas turut menjadi faktor penting yang meningkatkan risiko gangguan mental pada tenaga kesehatan. Sebuah studi cross-sectional di Italia menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan pengalaman kerja kurang dari lima tahun memiliki risiko burnout dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan mereka dengan pengalaman kerja lebih lama, karena kurangnya pengalaman dalam mengelola stres di masa krisis (Lasalvia et al., 2021).

## **3. Identifikasi Dini Individu Berisiko Tinggi**

Identifikasi dini tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi mengalami gangguan mental selama pandemi merupakan langkah kunci dalam mencegah dan memitigasi dampak psikologis negatif. Strategi ini meliputi skrining rutin berbasis bukti, pengawasan intensif pada kelompok berisiko tinggi, serta intervensi psikososial preventif yang terintegrasi di lingkungan kerja (Greenberg et al., 2020; Lamb et al., 2021).

Beberapa alat skrining psikologis seperti Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21), Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), dan Patient Health Questionnaire (PHQ-9) direkomendasikan secara luas untuk mengidentifikasi tenaga kesehatan yang mengalami gangguan mental sejak dini selama pandemi (Greenberg et al., 2020; Lamb et al., 2021). Menurut studi longitudinal yang dilakukan oleh Lamb et al. (2021), implementasi skrining dan identifikasi dini yang efektif di fasilitas kesehatan mampu secara signifikan mengurangi prevalensi gangguan mental berat di kalangan tenaga kesehatan.

Di Indonesia, rekomendasi Kementerian Kesehatan (2021) menekankan pentingnya penerapan skrining rutin bagi tenaga kesehatan sebagai langkah pencegahan proaktif, disertai dengan penyediaan layanan konseling psikologis secara intensif bagi individu yang teridentifikasi berisiko tinggi.

Dengan demikian, memahami hubungan antara riwayat gangguan mental sebelumnya, karakteristik demografis, serta pentingnya identifikasi dini merupakan langkah strategis dalam melindungi tenaga kesehatan dari gangguan mental yang serius selama dan setelah pandemi COVID-19.

## **I. Faktor Psikologis Individu**

---

### **1. Tingkat Resiliensi Individu Tenaga Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi**

Resiliensi psikologis merupakan kapasitas individu untuk menghadapi, bertahan, serta bangkit dari situasi sulit dan tekanan yang dihadapi, seperti pada pandemi COVID-19. Dalam konteks tenaga kesehatan, resiliensi sangat berperan penting dalam menentukan sejauh mana mereka mampu mempertahankan kesehatan mental selama masa pandemi yang penuh tantangan (Labrague, 2021; Rieckert et al., 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat resiliensi tenaga kesehatan selama pandemi bervariasi secara signifikan, dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakter kepribadian, pengalaman masa lalu, dukungan sosial, serta kemampuan pengelolaan emosi dan stres individu. Studi oleh Labrague dan De los Santos (2020) mengidentifikasi bahwa tenaga kesehatan dengan resiliensi tinggi cenderung menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan burnout yang lebih rendah dibandingkan tenaga kesehatan dengan tingkat resiliensi rendah. Penelitian yang dilakukan di berbagai negara juga memperkuat bahwa resiliensi merupakan faktor protektif utama yang membantu tenaga kesehatan menghadapi tekanan psikologis selama pandemi (Serrão et al., 2021).

### **2. Strategi Coping Individu dalam Mengelola Stres dan Trauma selama Pandemi**

Strategi coping merupakan mekanisme psikologis yang digunakan individu untuk mengelola stres dan trauma yang muncul dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan menggunakan berbagai bentuk coping selama pandemi, seperti coping berorientasi masalah (problem-focused coping), coping berorientasi emosi (emotion-focused coping), serta penggunaan spiritual coping (Babore et al., 2020; Vagni et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Babore et al. (2020) menemukan bahwa tenaga kesehatan yang menggunakan strategi coping aktif seperti pemecahan masalah langsung (problem-solving), mencari dukungan sosial, dan strategi

penerimaan (acceptance) menunjukkan gejala stres dan gangguan mental yang lebih rendah. Sebaliknya, tenaga kesehatan yang cenderung menggunakan strategi coping maladaptif, seperti penghindaran (avoidance coping), menunjukkan peningkatan risiko kecemasan, depresi, serta burnout (Vagni et al., 2020; Pearman et al., 2020).

Dalam studi cross-sectional oleh Pearman et al. (2020), spiritual coping atau coping berbasis religius juga menjadi salah satu coping adaptif yang efektif dalam mengurangi stres, terutama di kalangan tenaga kesehatan dengan latar belakang budaya yang kuat seperti di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

### **3. Hubungan antara Resiliensi Psikologis dengan Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Hubungan antara resiliensi psikologis dan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 telah terbukti sangat signifikan. Tenaga kesehatan dengan resiliensi tinggi dilaporkan lebih mampu mempertahankan kesejahteraan psikologis dan lebih terlindungi dari dampak negatif stres pandemi seperti kecemasan, depresi, dan burnout (Labrague, 2021; Huffman et al., 2021).

Menurut hasil penelitian meta-analisis oleh Rieckert et al. (2021), resiliensi yang tinggi dikaitkan secara konsisten dengan rendahnya tingkat gangguan mental di kalangan tenaga kesehatan selama pandemi. Studi ini menunjukkan bahwa resiliensi berperan sebagai penyangga (buffer) yang efektif, membantu individu dalam menyesuaikan diri terhadap situasi sulit, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk pulih secara psikologis setelah mengalami tekanan yang intens.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Huffman et al. (2021) menegaskan bahwa intervensi berbasis resiliensi, seperti pelatihan mindfulness, dukungan psikologis reguler, dan program pengembangan keterampilan coping adaptif secara signifikan meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan, mengurangi gejala depresi, kecemasan, serta memperkuat kesejahteraan psikologis jangka panjang.

Oleh karena itu, institusi kesehatan perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan resiliensi psikologis dan pelatihan strategi coping adaptif sebagai langkah pencegahan dan intervensi penting dalam melindungi tenaga kesehatan dari dampak psikologis negatif selama pandemi.

## **J. Faktor Lingkungan Kerja**

---

### **1. Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja yang Toksik selama Pandemi**

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan, terlebih di masa pandemi COVID-19.

Budaya organisasi yang tidak sehat atau toksik, yang dicirikan oleh kurangnya komunikasi terbuka, rendahnya dukungan pimpinan, serta adanya konflik antar-rekan kerja, secara nyata memperburuk kondisi psikologis tenaga kesehatan (Billings et al., 2021; Giorgi et al., 2020).

Sebuah penelitian global yang dilakukan oleh Billings et al. (2021) menemukan bahwa selama pandemi, banyak tenaga kesehatan mengalami tekanan tambahan akibat budaya kerja toksik, yang meliputi sikap saling menyalahkan, minimnya transparansi informasi, serta rendahnya apresiasi dari pimpinan. Budaya kerja yang negatif tersebut menciptakan lingkungan yang tidak aman secara emosional, meningkatkan stres, kecemasan, serta menurunkan motivasi kerja (Blanco-Donoso et al., 2021). Penelitian lain mengungkapkan bahwa budaya kerja yang toksik menjadi salah satu penyebab utama burnout serta meningkatkan keinginan tenaga kesehatan untuk meninggalkan pekerjaan (turnover intention) selama pandemi (Denning et al., 2021).

## **2. Dampak Komunikasi dan Manajemen Organisasi yang Buruk terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Komunikasi yang buruk serta manajemen organisasi yang tidak efektif memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Komunikasi yang tidak jelas mengenai kebijakan, prosedur penanganan COVID-19, serta kurangnya informasi yang konsisten dari pimpinan menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan tinggi di kalangan tenaga kesehatan (Greenberg et al., 2020; Labrague & De los Santos, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Greenberg et al. (2020) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami ketidakjelasan informasi serta komunikasi yang buruk dari pihak manajemen organisasi lebih rentan mengalami gangguan mental, seperti kecemasan berat, depresi, insomnia, dan burnout. Manajemen organisasi yang buruk, seperti ketidakadilan dalam pembagian tugas kerja, kurangnya dukungan struktural, serta rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan juga telah terbukti meningkatkan stres dan kelelahan emosional tenaga kesehatan selama pandemi (Lasater et al., 2021).

Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal yang tidak efektif di rumah sakit rujukan COVID-19 menjadi penyebab utama frustrasi, ketidakpercayaan, serta menurunkan tingkat moral tenaga kesehatan (Sugianto & Setiawan, 2021).

## **3. Pentingnya Menciptakan Lingkungan Kerja Suportif untuk Mencegah Gangguan Mental**

Menciptakan lingkungan kerja yang suportif merupakan langkah penting dalam mencegah dan mengurangi risiko gangguan mental tenaga kesehatan



selama pandemi. Lingkungan kerja suportif dicirikan oleh adanya komunikasi terbuka, dukungan sosial yang kuat dari rekan kerja maupun pimpinan, serta kebijakan organisasi yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kesehatan (Blanco-Donoso et al., 2021; Giorgi et al., 2020).

Menurut hasil penelitian Blanco-Donoso et al. (2021), tenaga kesehatan yang bekerja dalam lingkungan yang suportif menunjukkan tingkat stres, kecemasan, dan burnout yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja dalam lingkungan yang kurang mendukung. Penelitian lain menekankan bahwa intervensi organisasi seperti pelatihan komunikasi, manajemen stres, dukungan psikososial reguler, dan apresiasi yang tulus dari pimpinan terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan mental tenaga kesehatan (Billings et al., 2021; Lasater et al., 2021).

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis sebagai bagian integral dari respon institusional terhadap pandemi COVID-19. Hal ini meliputi promosi budaya saling menghormati, pemberian dukungan psikologis proaktif, serta pelibatan aktif tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada pekerjaan mereka.

Dengan demikian, organisasi dan institusi kesehatan harus memprioritaskan terciptanya lingkungan kerja yang suportif sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan selama dan setelah pandemi.

## **K. Implikasi Jangka Panjang**

### **1. Dampak Jangka Panjang Pandemi terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan (Post-Pandemic Mental Health)**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa efek psikologis dari pandemi seperti gangguan kecemasan, depresi, insomnia, dan PTSD cenderung bertahan lama, bahkan setelah pandemi dinyatakan mereda (Preti et al., 2020; Moreno et al., 2021).

Studi longitudinal yang dilakukan oleh Moreno et al. (2021) menemukan bahwa sekitar 40% tenaga kesehatan masih mengalami gejala gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD bahkan hingga satu tahun setelah puncak pandemi. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Pappa et al. (2021), yang menunjukkan bahwa banyak tenaga kesehatan mengalami stres kronis, kelelahan

emosional, serta peningkatan risiko gangguan mental permanen akibat stres berkelanjutan selama pandemi.

Di Indonesia, penelitian terbaru juga mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 berpotensi menyebabkan peningkatan beban kesehatan mental jangka panjang pada tenaga kesehatan, jika tidak ada intervensi yang efektif sejak dini (Setiawan & Ramadhani, 2021).

## **2. Pencegahan Dampak Jangka Panjang melalui Intervensi Dini Berbasis Bukti**

Untuk mencegah dampak kesehatan mental jangka panjang yang serius, penting untuk mengimplementasikan intervensi berbasis bukti sejak dini. Penelitian menegaskan bahwa skrining psikologis rutin, penyediaan layanan kesehatan mental terintegrasi di tempat kerja, serta pengembangan program pelatihan resiliensi dan coping merupakan strategi kunci dalam mencegah gangguan mental yang kronis (Greenberg et al., 2020; Lamb et al., 2021).

Sebuah studi meta-analisis oleh Pollock et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi dini berupa konseling psikologis, terapi berbasis mindfulness, serta pelatihan coping adaptif terbukti secara signifikan mengurangi risiko gangguan mental jangka panjang seperti PTSD, kecemasan kronis, dan depresi di kalangan tenaga kesehatan. Implementasi intervensi yang proaktif ini juga telah direkomendasikan oleh WHO sebagai bagian dari respon global terhadap pandemi (WHO, 2020).

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (2021) merekomendasikan skrining rutin dan layanan kesehatan mental berbasis institusi sebagai langkah preventif untuk melindungi tenaga kesehatan dari dampak jangka panjang pandemi.

## **3. Kebijakan Kesehatan Publik terkait Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan Setelah Pandemi**

Kebijakan kesehatan publik memainkan peran sentral dalam melindungi kesehatan mental tenaga kesehatan pasca-pandemi. Kebijakan ini mencakup integrasi layanan kesehatan mental dalam sistem kesehatan nasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam manajemen stres dan krisis, serta jaminan perlindungan kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan secara sistemik (Moreno et al., 2021; Pappa et al., 2021).

Penelitian oleh Moreno et al. (2021) merekomendasikan agar kebijakan publik secara eksplisit memasukkan perlindungan psikologis tenaga kesehatan sebagai prioritas utama dalam perencanaan jangka panjang penanganan krisis kesehatan. Strategi ini juga didukung oleh rekomendasi WHO (2020) yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti untuk mencegah dan menangani dampak psikologis pandemi pada tenaga kesehatan.

Di Indonesia, kebijakan publik yang dianjurkan meliputi pengembangan sistem dukungan psikososial yang terintegrasi di fasilitas kesehatan, penyediaan akses universal terhadap layanan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan, serta penguatan peraturan yang menjamin hak-hak tenaga kesehatan dalam situasi darurat kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Dengan demikian, upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat luas diperlukan untuk memastikan bahwa kesehatan mental tenaga kesehatan tetap menjadi prioritas dalam agenda kebijakan kesehatan publik jangka panjang setelah pandemi berakhir.

## **L. Penutup**

---

### **1. Ringkasan Faktor Risiko Utama Gangguan Mental pada Tenaga Kesehatan Selama Pandemi**

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan di seluruh dunia. Berdasarkan berbagai penelitian terkini, beberapa faktor risiko utama yang menyebabkan gangguan mental pada tenaga kesehatan selama pandemi antara lain beban kerja yang berlebihan akibat lonjakan pasien COVID-19, ketakutan terinfeksi dan menularkan virus kepada keluarga, kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD), kurangnya dukungan sosial dan organisasi, stigma sosial, konflik kehidupan-kerja (work-life balance), riwayat gangguan mental sebelumnya, rendahnya resiliensi psikologis, serta lingkungan kerja yang toksik (Billings et al., 2021; Denning et al., 2021; Greenberg et al., 2020; Labrague & De los Santos, 2020; Moreno et al., 2021).

Secara khusus, faktor seperti kurangnya dukungan psikososial di tempat kerja, rendahnya persepsi keamanan kerja, serta komunikasi yang buruk dalam organisasi telah terbukti meningkatkan risiko stres kronis, burnout, kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada tenaga kesehatan (Greenberg et al., 2020; Labrague, 2021). Oleh karena itu, memahami faktor-faktor tersebut merupakan langkah awal yang esensial dalam merancang intervensi yang efektif untuk melindungi kesehatan mental tenaga kesehatan.

### **2. Rekomendasi Berbasis Penelitian Terkini untuk Intervensi dan Mitigasi Gangguan Mental**

Berdasarkan bukti ilmiah terbaru, beberapa intervensi yang terbukti efektif dalam mengurangi risiko gangguan mental pada tenaga kesehatan antara lain implementasi skrining psikologis rutin di fasilitas kesehatan, penyediaan layanan dukungan psikososial yang terintegrasi, pelatihan resiliensi dan coping adaptif,

serta kebijakan organisasi yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kesehatan (Pollock et al., 2020; Rieckert et al., 2021).

Selain itu, intervensi seperti mindfulness-based stress reduction (MBSR), konseling psikologis reguler, pelatihan manajemen stres berbasis bukti, dan penciptaan budaya kerja yang suportif juga sangat direkomendasikan sebagai langkah proaktif dalam mencegah terjadinya dampak negatif jangka panjang (Greenberg et al., 2020; Labrague, 2021). Di tingkat organisasi, penelitian merekomendasikan agar institusi kesehatan memperbaiki komunikasi internal, memastikan ketersediaan APD yang mencukupi, serta secara aktif melawan stigma sosial melalui edukasi masyarakat (Moreno et al., 2021; WHO, 2020).

Khusus di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah mengadopsi beberapa rekomendasi tersebut melalui pedoman nasional terkait kesehatan mental tenaga kesehatan, menekankan pentingnya integrasi layanan kesehatan mental sebagai bagian dari respon kesehatan publik jangka panjang terhadap pandemi COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

### **3. Rekomendasi untuk Riset Lanjutan di Bidang Ini**

Mengingat kompleksitas dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, riset lanjutan di bidang ini sangat diperlukan. Beberapa area penelitian yang perlu diprioritaskan mencakup evaluasi efektivitas intervensi kesehatan mental secara jangka panjang, studi longitudinal tentang dampak psikologis pandemi pada berbagai profesi tenaga kesehatan, serta eksplorasi mendalam mengenai peran faktor budaya dalam memengaruhi resiliensi dan coping tenaga kesehatan (Lamb et al., 2021; Moreno et al., 2021).

Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang strategi mitigasi stigma sosial, analisis biaya-efektivitas dari intervensi kesehatan mental, serta pengembangan model dukungan psikososial berbasis komunitas juga menjadi rekomendasi penting (Pappa et al., 2021; Pollock et al., 2020). Di Indonesia, penelitian mendalam mengenai faktor-faktor lokal seperti budaya kerja rumah sakit, karakteristik demografi tenaga kesehatan, serta evaluasi kebijakan kesehatan mental nasional perlu terus dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas strategi intervensi yang diterapkan (Setiawan & Ramadhani, 2021).

Melalui pengembangan riset yang komprehensif dan berkelanjutan ini, diharapkan kebijakan kesehatan publik di masa mendatang dapat lebih efektif melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mental tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi darurat kesehatan global.

## M. Referensi

---

- Babore, A., Lombardi, L., Viceconti, M. L., Pignataro, S., Marino, V., Crudele, M., & Trumello, C. (2020). Psychological effects of the COVID-19 pandemic: perceived stress and coping strategies among healthcare professionals. *Psychiatry Research*, 293, 113366.
- Billings, J., Biggs, C., Ching, B. C. F., Gkofa, V., Singleton, D., & Bloomfield, M. (2021). Experiences of mental health professionals supporting front-line health and social care workers during COVID-19. *BJPsych Open*, 7(2), e70.
- Blanco-Donoso, L. M., Moreno-Jiménez, J., Amutio, A., Gallego-Alberto, L., Moreno-Jiménez, B., & Garrosa, E. (2021). Stressors, job resources, fear of contagion, and secondary traumatic stress among nursing home workers during COVID-19. *Journal of Applied Gerontology*, 40(3), 244-256.
- Denning, M., Goh, E. T., Tan, B., Kanneganti, A., Almonte, M., Scott, A., & Kinross, J. (2021). Determinants of burnout and psychological well-being in healthcare workers during COVID-19: a multinational study. *PLoS One*, 16(4), e0238666.
- Giorgi, G., Lecca, L. I., Alessio, F., Finstad, G. L., Bondanini, G., & Mucci, N. (2020). COVID-19-related mental health effects in the workplace. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), 7857.
- Greenberg, N., Weston, D., Hall, C., Caulfield, T., Williamson, V., & Fong, K. (2020). Mental health of staff working in intensive care during COVID-19. *Occupational Medicine*, 71(2), 62–67.
- Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 in China. *Psychiatry Research*, 288, 112954.
- Huffman, E. M., Athanasiadis, D. I., Anton, N. E., Haskett, L. A., Doster, D. L., & Lee, N. K. (2021). Resilience and healthcare providers' well-being during COVID-19. *The American Journal of Surgery*, 221(2), 277–284.
- Labrague, L. J. (2021). Psychological resilience, coping behaviours and social support among healthcare workers during COVID-19. *Journal of Nursing Management*, 29(7), 1893–1905.
- Labrague, L. J., & De los Santos, J. A. A. (2020). COVID-19 anxiety among frontline nurses: organisational support, resilience, and social support. *Journal of Nursing Management*, 28(7), 1653–1661.
- Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., & Hu, S. (2020). Mental health outcomes among healthcare workers exposed to COVID-19. *JAMA Network Open*, 3(3), e203976.
- Lamb, D., Greenberg, N., Stevelink, S. A., & Wessely, S. (2021). Mental health of the NHS workforce. *The Lancet Psychiatry*, 8(2), 89–90.

- Lasater, K. B., Aiken, L. H., Sloane, D. M., French, R., & McHugh, M. D. (2021). Chronic hospital nurse understaffing meets COVID-19. *BMJ Quality & Safety*, 30(8), 639–647.
- Moreno, C., Wykes, T., Galderisi, S., Nordentoft, M., Crossley, N., & Carr, S. (2021). Mental health care after COVID-19. *The Lancet Psychiatry*, 8(9), 813–824.
- Morgantini, L. A., Naha, U., Wang, H., Francavilla, S., Acar, Ö., Flores, J. M., & Weine, S. M. (2020). Healthcare professional burnout during COVID-19. *PLoS One*, 15(9), e0238217.
- Pappa, S., Barnett, J., Berges, I., & Sakkas, N. (2021). Mental health of healthcare workers in Spain during COVID-19. *Journal of Psychiatric Research*, 135, 156–162.
- Pollock, A., Campbell, P., Cheyne, J., & Maxwell, M. (2020). Interventions to support mental health of frontline health workers during pandemics. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11, CD013779.
- Preti, E., Di Mattei, V., Perego, G., Ferrari, F., & Calati, R. (2020). Psychological impact of epidemic outbreaks on healthcare workers. *Current Psychiatry Reports*, 22(8), 43.
- Rieckert, A., Schuit, E., Bleijenberg, N., Ten Cate, D., & Trappenburg, J. C. (2021). Resilience of healthcare professionals during COVID-19. *BMJ Open*, 11(1), e043718.
- Serrão, C., Duarte, I., Castro, L., & Teixeira, A. (2021). Burnout and depression in healthcare workers during COVID-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2), 636.
- Taylor, S., Landry, C. A., Rachor, G. S., Paluszek, M. M., & Asmundson, G. J. (2020). Fear and stigma towards healthcare workers during COVID-19. *Journal of Anxiety Disorders*, 75, 102289.
- Vindegaard, N., & Benros, M. E. (2020). COVID-19 and mental health consequences: systematic review. *Brain, Behavior, and Immunity*, 89, 531–542.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). *Mental health during the COVID-19 pandemic—Policy recommendations*. Atlanta: CDC.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Creating psychologically healthy workplaces during COVID-19*. Geneva: ILO.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial bagi Tenaga Kesehatan Pasca Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Setiawan, A., & Ramadhani, R. (2021). Dampak jangka panjang pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 3(2), 102–109.

- Sugianto, H., & Setiawan, A. (2021). Hubungan komunikasi internal dengan kesehatan mental tenaga kesehatan selama COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 9(3), 184–192.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak*. Geneva: WHO.





# BAB II

## EDUKASI TENTANG MANAJEMEN STRES BAGI TENAGA KESEHATAN

---

### A. Pendahuluan

---

Pandemi Covid 19 yang muncul di Indonesia membawa dampak disegala sektor tidak terkecuali sektor kesehatan. Tantangan yang dihadapi pada sektor kesehatan salah satunya pada tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan pandemi Covid 19. Tenaga kesehatan yang gugur tidak sedikit jumlahnya, sehingga kondisi ini meningkatkan stres dan gangguan psikologis lain seperti depresi dan kecemasan. Berdasarkan penelitian (Syamlan AT, Salamah S, Alkaff FF, 2021) sebanyak 31,8% tenaga kesehatan yang mengalami stres pada masa pandemi. Saat masa pandemi tenaga kesehatan mendapat beban kerja dan tekanan yang berat, banyak pasien datang dengan kondisi perawatan ekstra, sementara tenaga kesehatan tidak bertambah, sistem imun yang rendah sehingga menyebabkan tenaga kesehatan mengalami stres.

### B. Pandemi

---

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena global yang ditandai dengan penyebaran penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) ke seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru yang disebut Sars-CoV-2, yang terdeteksi pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas serta disertai gejala lain seperti lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 gejala berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian (Atmojo, Joko Tri, 2020).

Pandemi COVID-19 telah memicu berbagai perubahan, termasuk penerapan kebijakan pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran virus. Perubahan tersebut membuat masyarakat merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Situasi dan kondisi yang terjadi selama pandemi COVID-19 dapat menimbulkan emosi yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, salah satunya stres (Agung, 2020)

### C. Tenaga Kesehatan

---

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan diartikan sebagai individu-individu yang berkomitmen dalam bidang kesehatan, serta

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu. Mereka memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya kesehatan. Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi, definisi tenaga kesehatan ini mencakup setiap orang yang telah menjalani pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan mendedikasikan diri untuk berkontribusi dalam upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Kurniati, 2012)

#### **D. Kesehatan Mental**

---

Kesehatan mental diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan masyarakat, serta memiliki keterampilan dalam mengendalikan diri saat menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini mencakup terwujudnya keseimbangan dan keharmonisan dalam fungsi-fungsi kejiwaan.

Lebih lanjut, kesehatan mental adalah usaha untuk mengembangkan semua potensi diri secara optimal, sehingga individu dapat meraih kebahagiaan dan terhindar dari berbagai penyakit mental (Daradjat, 2016)). Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan terbebas dari gejala-gejala gangguan mental, sehingga mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan beradaptasi menghadapi tantangan serta tekanan hidup dengan efektif dan efisien (Putri, A.W, 2015)

#### **E. Prinsip Kesehatan Mental**

---

Menurut (AF.Jaelani, 2021) dan (Eni & Kep, 2022) terdapat beberapa prinsip penting dalam kesehatan mental yaitu:

1. Gambaran dan sikap positif terhadap diri sendiri  
Individu memiliki self image yang baik mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri, orang lain, alam lingkungan, dan Tuhan.
2. Keterpaduan Diri  
Keterpaduan diri merujuk pada keseimbangan antara berbagai aspek kejiwaan kesatuan pandangan dalam hidup, serta kemampuan dalam mengatasi stres. Orang yang memiliki keseimbangan diri berhasil mengharmonisasikan kekuatan id, ego, dan super ego.
3. Aktualisasi diri.  
Aktualisasi diri memainkan peranan penting dalam kesehatan mental. Seseorang yang sehat mental adalah orang yang mampu mewujudkan potensi yang dimilikinya dan memenuhi kebutuhannya secara baik dan memuaskan.
4. Kemampuan menerima orang lain dan Beradaptasi Sosial

Kemampuan untuk menerima orang lain mencakup kesediaan untuk menghargai, mencintai, menjalin persahabatan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Terlibat dalam aktivitas sosial berarti bersedia berkolaborasi dengan masyarakat dan berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermakna.

Menyesuaikan diri dengan lingkungan berarti berusaha untuk mendapatkan rasa aman, damai, dan bahagia dalam kehidupan sosial.

5. Minat dalam tugas dan pekerjaan.

Setiap individu perlu memiliki minat dalam tugas dan pekerjaan yang dijalani. Dengan demikian, mereka dapat merasakan kebahagiaan dan mengurangi beban emosional yang dihadapi.

6. Agama, cita-cita, dan falsafah hidup.

Agama dapat membantu individu menghadapi tantangan hidup yang melebihi kemampuannya. Cita-cita memberikan semangat dan motivasi untuk berjuang menuju masa depan, sedangkan falsafah hidup membantu individu mengatasi rintangan dengan lebih mudah.

7. Pengawasan diri.

Individu yang memiliki pengawasan diri cenderung terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, adat, maupun norma moral.

8. Rasa benar dan tanggung jawab.

Rasa benar dan rasa tanggung jawab penting bagi tingkah laku karena setiap individu berupaya menghindari perasaan bersalah dan kecewa. Sebaliknya rasa benar, tanggung jawab dan pencapaian adalah harapan setiap individu yang sehat mental.

## **F. Karakteristik Kesehatan Mental**

---

Karakteristik kesehatan mental dapat diidentifikasi melalui berbagai ciri yang menandakan kondisi mental yang sehat. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kesehatan mental yang baik menurut Yusuf (2011):

1. Merasa aman dan bebas dari kecemasan.
2. Memiliki harga diri yang stabil.
3. Memiliki spontanitas dalam kehidupan, ditunjukkan oleh emosi yang hangat dan terbuka.
4. Memiliki keinginan duniawi yang seimbang dan wajar, mampu memenuhinya dengan cara yang positif.
5. Mampu merendahkan diri dan belajar untuk mengalah dalam berinteraksi dengan orang lain.
6. Menyadari diri sendiri dengan kemampuan menilai kekuatan dan kelemahan, baik fisik maupun psikis, secara tepat dan obyektif.

7. Memandang fakta secara realistis, tanpa berkhayal.
8. Mampu mentoleransi ketegangan atau stres, tetap tenang ketika menghadapi masalah, dan menjaga sikap positif dalam aspek fisik, psikis, dan sosial.
9. Menunjukkan integrasi serta kestabilan dalam kepribadian.
10. Memiliki tujuan hidup yang jelas, positif, dan konstruktif.
11. Mampu belajar dari pengalaman yang dialami.
12. Dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tanpa melanggar aturan yang telah disepakati.

Dengan memahami dan mengembangkan ciri-ciri di atas, seseorang dapat mencapai kesehatan mental yang lebih baik.

### **G. Indikator Kesehatan Mental**

---

Menurut (Bastaman, 1995), dan (Eni, N. R., & Kep, 2022); (Fakhriyani, 2019)), kesehatan mental seseorang dapat dilihat dari tiga orientasi, yaitu:

1. Orientasi Klasik.

Seseorang dianggap sehat bila ia tak mempunyai keluhan tertentu, seperti: ketegangan, rasa lelah, cemas, yang semuanya menimbulkan perasaan sakit atau rasa tak sehat serta mengganggu efisiensi kegiatan sehari-hari.

2. Orientasi penyesuaian diri.

Seseorang dianggap sehat secara psikologis bila ia mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan orang-orang lain serta lingkungan sekitarnya

3. Orientasi pengembangan potensi.

Seseorang dianggap mencapai taraf kesehatan mental, bila ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya menuju kedewasaan sehingga ia bisa dihargai oleh orang lain dan dirinya

### **H. Tahapan Gangguan Kesehatan Mental**

---

Menurut Rumiani (2006), stres terjadi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Pada tahap ini, stres dapat memicu semangat yang lebih tinggi, meningkatkan ketajaman penglihatan, serta menambah energi. Meskipun ada rasa gugup, namun perasaan tersebut masih dapat diatasi dengan baik.
2. Tahap Kedua: Tanda-tanda kelelahan mulai muncul, disertai dengan ketegangan otot dan gangguan pencernaan.
3. Tahap Ketiga: Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan ketegangan yang lebih intens, kesulitan tidur, dan tubuh terasa lesu serta lemas.
4. Tahap Keempat dan Kelima: Dalam dua tahap ini, kemampuan untuk merespons situasi menurun, konsentrasi terganggu, dan insomnia mulai muncul.

5. Tahap Keenam: Gejala yang timbul pada tahap ini mencakup detak jantung yang meningkat, gemetar, dan dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan pingsan.

## **I. Kesehatan Mental Pada Masa Pandemi Pada Tenaga Kesehatan**

---

Beberapa faktor dapat memicu gangguan kesehatan mental selama pandemi COVID-19, antara lain:

### **1. Faktor Jarak dan Isolasi**

Rasa takut terhadap COVID-19 bisa menimbulkan tekanan emosional yang serius. Isolasi mandiri atau penerapan PSBB dapat menyebabkan kebosanan yang berujung pada berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan sistem pencernaan, detak jantung yang tidak teratur, pusing, mual, kesulitan tidur, serta peningkatan sensitivitas dan pelupa (Olfah et al., 2021). Dampak ini mengganggu aktivitas sehari-hari banyak orang, sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan mental masyarakat secara umum.

### **2. Faktor Resesi Ekonomi**

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi yang signifikan. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Situasi ini berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan mental di kalangan masyarakat.

### **3. Faktor Stres dan Trauma pada Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan menghadapi risiko yang cukup tinggi terhadap gangguan kesehatan mental selama masa pandemi. Beragam masalah dapat muncul, seperti stres, ketakutan akan terpapar infeksi, perasaan tidak berdaya, hingga trauma akibat menyaksikan pasien COVID-19 meninggal tanpa pendampingan.

### **4. Faktor Stigma dan Diskriminasi**

Stigma negatif terhadap pasien positif COVID-19 serta tenaga kesehatan dapat memicu bunuh diri. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, stigma dan diskriminasi telah menjadi isu nyata. Bentuk stigma ini bisa berupa penutupan pintu saat melihat perawat, pengusiran dari lingkungan tempat tinggal, penolakan saat hendak menggunakan transportasi umum, hingga pengucilan terhadap keluarga korban (Thakur, V; Jain, 2020)).

## **J. Pengertian Stres**

---

Stres adalah pengalaman yang dialami oleh setiap individu sepanjang hidupnya (Imelisa, 2021). Stres merupakan stimulus atau situasi yang menimbulkan tuntutan baik dari segi psikologis maupun fisik. Secara umum, stres merupakan respons alami tubuh terhadap perubahan yang memerlukan penyesuaian fisik, psikologis, dan emosional. Berbagai faktor seperti situasi yang dihadapi, kondisi

lingkungan, pikiran, kemarahan, ketegangan, ketakutan dan frustrasi dapat menjadi penyebab munculnya stres (Nur, L & Mugi, 2021)).

## **K. Tanda dan Gejala Stres**

---

Tanda dan gejala stres dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Gejala fisik  
Mencakup berbagai keluhan seperti sakit kepala, kesulitan menelan, sariawan, sakit nyeri leher, rasa lemas, malaise, mengantuk, diare, nyeri perut, detak jantung yang meningkat, dan nyeri otot.
2. Gejala emosi  
Dalam kategori ini, gejala emosi tampak dari perasaan depresi, kepanikan, sering menangis, kekhawatiran yang berlebihan, mudah marah, perilaku impulsif, mimpi buruk, serta kecemasan terhadap hal-hal kecil
3. Gejala perilaku  
Dalam kategori perilaku, tanda-tanda yang ditemukan seperti menggigit kuku, lambat bergerak, berjalan modar-mandir, dahi berkerut, galak tawa gelisah bernada tinggi, merokok berlebihan serta perubahan perilaku sosial tiba-tiba (Imelisa, 2021)

## **L. Penyebab Stres**

---

Menurut (Hawari, 2013) dalam (Imelisa, 2021) kategori stressor dibedakan sebagai berikut:

1. Stres fisik dan biologis: jenis stres ini muncul akibat faktor seperti suhu ekstrim, rasa nyeri, serta kehilangan atau kekurangan cairan dan oksigen, termasuk kondisi cacat.
2. Stres psikologis: disebabkan oleh meningkatnya beban kerja, rasa kesepian, jatuh cinta, serta berbagai perasaan seperti cemas, khawatir, takut, kecewa dan marah
3. Stres sosial budaya: termasuk dalam kategori ini adalah perceraian, perpindahan tempat tinggal, masalah ekonomi, perasaan terasing dan konflik antar individu.

## **M. Sumber Stres**

---

Menurut (Donsu, 2017) stres dapat berasal dari tiga sumber utama yaitu :

1. Diri sendiri: Konflik timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan.
2. Keluarga: Konflik muncul karena perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, masalah keluarga, kondisi ekonomi serta tujuan yang beragam
3. Masyarakat dan lingkungan: Sumber stres yang disebabkan oleh kurangnya hubungan interpersonal serta minimnya pengakuan dari masyarakat

## **N. Faktor Koping Stres**

---

Menurut Siswanto (2007 dalam Salsabila 2012), stresor dapat memicu reaksi yang berbeda pada setiap individu tergantung pada karakteristik masing-masing. Beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi terhadap stres antara lain

### **1. Usia**

Usia memiliki penting dalam menentukan seberapa besar toleransi seseorang terhadap stres serta jenis stresor yang dianggap paling mengganggu. Secara umum, individu dewasa menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola stres dibandingkan anak-anak dan lansia. Namun, stres yang dihadapi oleh orang dewasa sering kali lebih berat, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Sebagai contoh, individu yang berusia di atas 75 tahun cenderung mengalami kualitas hidup yang lebih buruk dibandingkan mereka yang lebih muda, seperti individu berusia 18-24 tahun, di mana hanya 7,5% dari kelompok ini yang melaporkan kualitas hidup yang buruk (Steigelman et al, dalam Salsabila, 2012).

### **2. Jenis kelamin**

Umumnya, wanita memiliki daya tahan lebih baik terhadap stres dibandingkan pria, terutama di kalangan wanita usia produktif dengan keseimbangan hormon yang stabil. Namun, daya tahan tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Bain dan rekan-rekannya (dalam Salsabila, 2012) mengemukakan kualitas hidup laki-laki cenderung lebih baik dibandingkan perempuan. Fadda dan Jiron (dalam Salsabila, 2012) menekankan bahwa perbedaan peran dan akses terhadap berbagai sumber daya antara keduanya menciptakan kebutuhan yang berbeda, sehingga berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang berhubungan dengan kualitas hidup.

### **3. Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan toleransi dan kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi stres. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik cara mereka menghadapi stres, yang berujung pada kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian oleh Wahl (2004 dalam Makkau, 2014) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup individu.

### **4. Status pernikahan**

Terdapat perbedaan dalam mekanisme koping yang mempengaruhi kualitas hidup antara individu yang tidak menikah, bercerai, atau janda/duda, dan mereka yang sudah menikah. Penelitian empiris di Amerika menunjukkan bahwa individu yang menikah cenderung memiliki mekanisme koping yang lebih baik,

yang berdampak pada kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak menikah atau yang bercerai. Dukungan sosial dari pasangan juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap kualitas hidup yang baik bagi pria dan wanita yang sudah menikah (Quan et al. , dalam Salsabila, 2012).

## **5. Pekerjaan**

Moons, Marquet, Budst, dan De Gees (dalam Salsabila, 2012) mengatakan bahwa terdapat perbedaan kualitas hidup antara pelajar, pekerja, individu yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang tidak dapat bekerja akibat disabilitas tertentu. Status pekerjaan memiliki hubungan yang erat dengan kualitas hidup yang dialami oleh pria maupun wanita.

## **O. Respon Psikologis Stres Pada Tenaga Kesehatan**

---

Menurut Mubarak (2015), stres dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis seseorang yang dapat memunculkan berbagai masalah, antara lain

### **1. Kecemasan**

Kecemasan seringkali timbul sebagai hasil dari ketakutan atau ketidakpuasan, hal ini mencakup berbagai perasaan seperti khawatir, tegang, stres berlebihan dan rasa takut yang mengganggu. Gejala kecemasan biasanya ditandai kondisi tubuh seperti keringat dingin, bibir kering, jantung berdebar, peningkatan tekanan darah serta gangguan tidur.

### **2. Depresi dan agresi**

Agresi sering kali muncul sebagai reaksi emosional terhadap stres yang dirasakan sebagai ancaman. Sebaliknya, depresi adalah respons yang ditandai oleh kehilangan semangat hidup serta perasaan sedih yang mendalam. Emosi Dalam menghadapi stres, individu seringkali mengekspresikan emosi sebagai bentuk pengelolaan stres. Penilaian kognitif dalam menghadapi stres dapat mempengaruhi pengalaman emosional seseorang. Respon emosional yang umum saat menghadapi stres meliputi ketakutan, depresi, kemarahan, fobia, dan rasa cemas.

### **3. Perilaku sosial**

Stres dapat merubah dan mempengaruhi tindakan seseorang terhadap orang lain. Ketika stres disertai dengan kemarahan, hal ini dapat menyebabkan sikap sosial yang negatif.

## **P. Faktor yang Mempengaruhi Stres Tenaga Kesehatan**

---

### **1. Durasi Kerja yang Panjang**

Waktu kerja yang berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah psikologis negatif, seperti gangguan emosional, depresi, stres, perubahan



suasana hati, kemarahan yang mudah muncul, serangan panik, fobia, gejala insomnia, serta kelelahan emosional. Penyelidikan yang dilakukan oleh Brooks et al. (2020) mendukung teori ini.

## **2. Stigma di Masyarakat**

Tenaga kesehatan sering kali mengalami stigma sosial yang mengganggu mereka sebagai pembawa virus COVID-19. Hal ini berkontribusi pada terjadinya gangguan psikologis di kalangan mereka. Penelitian oleh (Lu, Wen, Hang Wang, Yuxing Lin, 2020) dan (Antonijevic, J., Binic, I., Zikic, O., Manojlovic, S., Golubovic, S. T. & N., 2020) menunjukkan bahwa kurang dari seperlima responden merasa terasing karena terpapar COVID-19.

## **3. Kecemasan**

Kecemasan merupakan kondisi emosional negatif yang dialami individu secara subjektif. Dalam konteks perawat, tingkat kecemasan yang tinggi, mencapai 35,5%, dapat berpotensi menimbulkan stres, seperti yang diungkapkan dalam studi oleh Mo et al. (2020) dan Qasem Surrati et al. (2020). Selain itu, penelitian oleh Kang et al. (2020) menunjukkan bahwa tingkat kecemasan tenaga kesehatan yang bekerja di ruang perawatan pasien pneumonia akibat virus corona adalah dua kali lipat dibandingkan perawat di ruang lainnya.

## **4. Waktu Istirahat Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, mengalami gejala insomnia dengan prevalensi mencapai 34–36,1%. Gejala ini umumnya dipicu oleh stres pascatrauma yang berlangsung selama pandemi, yang mungkin berlangsung hingga 1–3 tahun, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Preti et al. (2020). Menurut penelitian (Lee, S. M., Kang, W. S., Cho, A. R., Kim, T., & Park, 2018) dari 123 peserta, 47 orang (38%) menunjukkan skor PSQI lebih dari 7, yang mengindikasikan adanya gangguan tidur. Hal serupa juga ditemukan oleh (Huang, Y., & Zhao, 2020), yang mengungkapkan bahwa petugas kesehatan memiliki kualitas tidur yang buruk, terutama yang berusia di atas 35 tahun dan yang bekerja lebih dari 3 jam per hari dengan fokus pada COVID-19, berisiko mengalami *Generalized Anxiety Disorder* (GAD) dan kualitas tidur yang buruk.

## **Q. Dampak Stres Pada Tenaga Kesehatan**

---

Stres yang tidak ditangani dengan baik dapat memberikan dampak negatif pada kinerja dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Beberapa dampak utama meliputi:

1. Burn Out: Burn out adalah kondisi kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan kinerja profesional yang sering dialami oleh tenaga kesehatan yang bekerja

dalam kondisi stres tinggi. Burn out dapat menyebabkan penurunan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien dan meningkatkan risiko kesalahan medis (Aly, H. M., Nemr, N. A., Kishk, R. M., & Elsaid, 2021)

2. Gangguan Kesehatan Mental: Stres kronis dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas kerja dan meningkatkan absensi kerja.
3. Penurunan Kualitas Hidup: Stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Tenaga kesehatan mengalami kesulitan tidur, gangguan makan, dan masalah kesehatan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
4. Tingkat Absensi dan Turnover yang Tinggi: Stres yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan peningkatan tingkat absensi dan turnover di kalangan tenaga kesehatan. Hal ini dapat menambah beban kerja bagi tenaga kesehatan yang tersisa dan memperburuk kondisi kerja secara keseluruhan.

## **R. Pengelolaan Stres Yang Efektif**

---

Pengelolaan stres yang efektif sangat penting untuk memastikan kesejahteraan tenaga kesehatan dan keberlanjutan layanan perawatan selama pandemi. Strategi efektif mengelola stres pada tenaga kesehatan, yaitu

1. Manajemen stres: teknik relaksasi, meditasi dan mindfulness yang dapat membantu tenaga kesehatan mengurangi tingkat stres. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan visualisasi terbukti efektif dalam menurunkan stres akut (Kakar, K., Simon, N., & Akinola, 2020)
2. Dukungan Sosial: Dukungan dari rekan kerja, keluarga, dan komunitas sangat penting dalam mengurangi stres. Program dukungan sosial yang terstruktur, seperti kelompok dukungan dan sesi debriefing, membantu tenaga kesehatan merasa didengar dan didukung (Dispatch Health, 2020)
3. Konseling Psikologis: Sesi konseling individu atau kelompok dengan profesional kesehatan mental dapat membantu tenaga kesehatan mengatasi stres dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Program ini biasanya mencakup konseling langsung maupun layanan telekonseling (CDC, 2023)
4. Keseimbangan Kerja-Hidup: Mendorong tenaga kesehatan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini bisa dilakukan dengan mengatur jadwal kerja yang fleksibel dan memberikan waktu istirahat yang memadai (A.Hamed, L., & Mohamed Abdel Aziz, 2020)

5. Akses ke Sumber Daya Kesehatan Mental: Penyediaan sumber daya kesehatan mental, seperti hotline krisis dan aplikasi kesehatan mental, dapat memberikan dukungan tambahan yang diperlukan oleh tenaga kesehatan (Fils-Aime, 2021)

### **S. Program Dukungan Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

---

Program dukungan bergantung pada bagaimana program tersebut diimplementasikan dan diterima oleh tenaga kesehatan. Beberapa temuan utama terkait efektivitas program ini meliputi:

1. Penurunan Tingkat Stres dan Burn Out: Program dukungan mental yang terstruktur dengan baik telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan tingkat stres dan burn out di kalangan tenaga kesehatan.
2. Studi menunjukkan bahwa intervensi psikologis dan program dukungan sosial dapat mengurangi gejala burn out secara signifikan (Aly, H. M., Nemr, N. A., Kishk, R. M., & Elsaid, 2021)
3. Peningkatan Kesejahteraan Mental: Program yang menyediakan akses mudah ke layanan konseling dan dukungan psikologis membantu meningkatkan kesejahteraan mental tenaga kesehatan. Layanan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan bantuan profesional saat dibutuhkan dan mengembangkan keterampilan coping yang lebih baik (Krystal, 2020)
4. Peningkatan Kepuasan Kerja: Program dukungan mental yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja di kalangan tenaga kesehatan. Ketika tenaga kesehatan merasa didukung secara mental dan emosional, mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi (CDC, 2023)
5. Pengurangan Absensi dan Turnover: Program dukungan mental yang efektif dapat mengurangi tingkat absensi dan turnover di kalangan tenaga kesehatan. Dengan menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, tenaga kesehatan lebih mampu menjalankan tugas mereka dengan baik dan cenderung tidak meninggalkan pekerjaan mereka (A.Hamed, L., & Mohamed Abdel Aziz, 2020)

### **T. Penutup**

---

Pengelolaan Stres pada tenaga kesehatan saat pandemisangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mental. Berbagai strategi dapat dilakukan seperti manajemen stres, dukungan sosial, konseling psikologis. Program dukungan mental memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kinerja sistem perawatan kesehatan

## U. Referensi

---

- A.Hamed, L., & Mohamed Abdel Aziz, T. (2020). Effect of Deep Breathing Exercise Training on Fatigue' Level among Maintenance Hemodialysis Patients: Randomized Quasi-experimental Study. *Egyptian Journal of Health Care. Egyptian Journal of Health Care*, 11(4), 634–644.
- AF.Jaelani. (2021). *Penyucian Jiwa dan Kesehatan Mental*. Amzah.
- Agung, I. M. (2020). Memahami pandemi COVID-19 dalam perspektif psikologi sosial. *Psikobuletin: Buleting Ilmiah Psikologi*, 1(2), 68–84.
- Aly, H. M., Nemr, N. A., Kishk, R. M., & Elsaid, N. M. (2021). Stress, Anxiety, and Depression Among Healthcare Workers Facing COVID-19. *BMJ Open*, 1–7.
- Antonijevic, J., Binic, I., Zikic, O., Manojlovic, S., Golubovic, S. T., & P., & N. (2020). Mental health of medical personnel during the covid-19 pandemic. *Brain and Behavior WILEY*.
- Atmojo, Joko Tri, et. al. (2020). "Cardiopulmonary Resuscitation in the Covid-19 Pandemic Era." *Jurnal Keperawatan*, 12(3).
- Bastaman, H. D. (1995). *Menuju, Integrasi Psikologi dengan Islam Islami, Psikologi*. Pustaka Pelajar.
- CDC. (2023). *Health Workers Face a Mental Health Crisis*.
- Daradjat, Z. (2016). *Kesehatan Mental*. Gunung Agung.
- Dispatch Health. (2020). *Tips for Managing Stress as a Healthcare Worker During COVID 19*.
- Donsu, J. (2017). *Psikologi Keperawatan*. Pustaka Baru Press.
- Eni, N. R., & Kep, M. (2022). *DAN PENANGANAN KESEHATAN MENTAL. Kesehatan Mental (Teori dan Penerapan)*.
- Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan mental*. Duta Media Publishing.
- Fils-Aime, R. (2021). Stress Management Among Healthcare Workers During a Pandemic. Nicole Wertheim College of Nursing Student Projects. *Florida: Florida International University*.
- Hawari. (2013). *Manajemen Stress, Cemas, dan Depresi*. FKUI.
- Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based crosssectional survey. *Psychiatry Research*.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120306077?via%3>

Dihub

- Imelisa, R. et al. (2021). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikososial* (E. by N. & Restiana (eds.)). Edu Publisher.
- Kakar, K., Simon, N., & Akinola, A. (2020). Stress Management Among Health Care Workers: Caring For Your Self & Others During Covid-19 Pandemic: Systematic Review. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 8(10), 1–12.
- Krystal, J. H. (2020). Responding to the Hidden Pandemic for Healthcare Workers: Stress. *Nature Medicine*.
- Kurniati, A. dan F. E. (2012). *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Salemba Medika.
- Lee, S. M., Kang, W. S., Cho, A. R., Kim, T., & Park, J. K. (2018). *Psychological impact of the 2015 MERS outbreak on hospital workers and quarantined hemodialysis patients. Comprehensive Psychiatry*. 87, 123–127.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18301664?via%3Dihub>
- Lu, Wen, Hang Wang, Yuxing Lin, and L. L. (2020). Psychological Status of Medical Workforce during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. *Psychiatry Research*, 288, 1–5.
- Nur, L & Mugi, H. (2021). Tinjauan Literatur Mengenai Stres dalam Organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 18(1), 20–30.
- Putri, A.W, et al. (2015). *Kesehatan mental masyarakat Indonesia (pengetahuan, keterbukaan, masyarakat terhadap gangguan Kesehatan mental)* (Vol. 2, Issue 1).
- Syamlan AT, Salamah S, Alkaff FF, et al. (2021). Mental Health and Health- Related Quality of Life Among Healthcare Workers in Indonesia During The COVID-19 Pandemic : a cross- sectional study. *BMJ Open*.
- Thakur, V; Jain, A. (2020). *COVID 2019-suicides: A global psychological pandemic. Global Psychological Pandemic. Brain, Behavior, and Immunity*. 952–953.



# BAB III

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING

---

### A. Pendahuluan

Latar Belakang dan Urgensi Layanan Konseling Daring bagi Tenaga Kesehatan selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan luar biasa terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan. Kondisi ini dipicu oleh tingginya risiko infeksi, meningkatnya beban kerja, keterbatasan alat pelindung diri, serta tingginya angka morbiditas dan mortalitas pasien. Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 mengalami peningkatan prevalensi gangguan kecemasan, stres, insomnia, hingga depresi (Alnazly et al., 2021; Pappa et al., 2020). Sebagai garis terdepan dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan menghadapi tekanan psikologis yang berdampak negatif pada kinerja dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, kebutuhan akan layanan konseling kesehatan mental yang efektif dan mudah diakses menjadi sangat mendesak untuk memastikan tenaga kesehatan tetap sehat secara fisik dan psikologis selama pandemi berlangsung (Chen et al., 2021).

Namun, kondisi pandemi juga menghadirkan hambatan yang signifikan dalam pemberian layanan konseling konvensional secara tatap muka, seperti risiko penularan virus yang tinggi, pembatasan sosial, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di institusi kesehatan (Windarwati et al., 2021). Di tengah keterbatasan tersebut, muncul layanan konseling daring sebagai solusi alternatif yang dianggap efektif, aman, dan fleksibel untuk diterapkan (Situmorang, 2020). Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya menjadi solusi darurat di masa pandemi, tetapi juga memberikan prospek jangka panjang dalam memperluas akses layanan kesehatan mental secara lebih merata.

#### **1. Peran Teknologi dalam Menjembatani Hambatan Akses Layanan Kesehatan Mental di Masa Pandemi**

Pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling kesehatan mental memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai hambatan akses layanan kesehatan selama pandemi COVID-19. Salah satu manfaat utama dari teknologi adalah memungkinkan layanan konseling dilakukan secara daring tanpa kontak fisik langsung, yang secara efektif mengurangi risiko penularan COVID-19 (Windarwati et al., 2021). Layanan konseling daring umumnya menggunakan berbagai platform digital, seperti aplikasi mobile, telekonseling berbasis video-

conferencing (misalnya Zoom, Google Meet), dan layanan pesan instan atau chatbot yang interaktif. Keunggulan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendapatkan layanan konseling secara cepat, aman, serta lebih fleksibel dari segi waktu dan tempat (Zhang et al., 2020).

Teknologi juga memiliki potensi besar dalam mengatasi hambatan geografis, di mana tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau sulit dijangkau secara fisik tetap dapat mengakses layanan konseling profesional. Selain itu, platform daring juga memungkinkan konselor menjangkau lebih banyak tenaga kesehatan secara serentak, mempercepat respons bantuan kesehatan mental dalam situasi krisis (Chen et al., 2021). Lebih lanjut, teknologi digital menyediakan anonimitas yang membuat tenaga kesehatan lebih nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan masalah psikologis mereka dibandingkan layanan tatap muka konvensional. Hal ini menjadi poin penting mengingat masih adanya stigma sosial terkait gangguan kesehatan mental di kalangan tenaga kesehatan sendiri (Puspitasari & Ishii, 2020).

Meski demikian, implementasi teknologi dalam layanan konseling juga dihadapkan pada tantangan, seperti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, privasi data, serta literasi digital yang masih perlu ditingkatkan di kalangan tenaga kesehatan (Alqahtani et al., 2021). Oleh sebab itu, pendekatan terintegrasi antara pemanfaatan teknologi, kebijakan institusi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam literasi teknologi konseling menjadi hal penting untuk mendukung efektivitas implementasi layanan ini.

Dengan demikian, peran teknologi dalam layanan konseling daring selama pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi solusi untuk tantangan aksesibilitas layanan kesehatan mental yang mendesak, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan secara berkelanjutan di masa depan.

## **B. Jenis-Jenis Teknologi dalam Layanan Konseling**

---

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling kesehatan mental, terutama bagi tenaga kesehatan. Berbagai jenis teknologi kini digunakan sebagai media untuk memberikan layanan konseling, baik secara individu maupun kelompok. Beberapa jenis teknologi yang banyak digunakan dan memiliki efektivitas yang baik dalam konseling kesehatan mental adalah sebagai berikut:

### **1. Platform Konseling Online Berbasis Web dan Aplikasi Mobile**

Platform konseling online berbasis web dan aplikasi mobile merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penyediaan layanan



kesehatan mental jarak jauh. Teknologi ini menawarkan fleksibilitas tinggi, karena pengguna dapat mengakses layanan dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone di mana saja dan kapan saja (Windarwati et al., 2021). Contoh platform yang populer di antaranya adalah BetterHelp, Talkspace, dan aplikasi mobile kesehatan mental seperti Moodpath atau Calm. Penelitian menunjukkan bahwa platform tersebut efektif dalam mengurangi gejala stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna secara signifikan (Etzelmueller et al., 2020; Marshall et al., 2020).

## **2. Telekonseling Berbasis Video-Conferencing (*Zoom, Skype, Google Meet*)**

Telekonseling dengan teknologi video-conferencing seperti Zoom, Skype, dan Google Meet memungkinkan konseling tatap muka secara virtual. Telekonseling ini merupakan salah satu alternatif yang paling banyak digunakan selama masa pandemi COVID-19 karena mampu memberikan interaksi visual secara langsung antara konselor dan tenaga kesehatan tanpa risiko infeksi COVID-19 (Zhang et al., 2020). Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa telekonseling berbasis video-conferencing memiliki efektivitas setara dengan layanan konseling tatap muka konvensional dalam mengelola kecemasan, depresi, maupun stres akut yang dialami tenaga kesehatan selama pandemi (Alqahtani et al., 2021; Situmorang, 2020). Meski begitu, efektivitas telekonseling juga sangat bergantung pada kualitas koneksi internet dan keterampilan konselor dalam berkomunikasi secara daring.

## **3. Teknologi Pesan Instan dan Chatbot dalam Layanan Konseling Kesehatan Mental**

Teknologi pesan instan (instant messaging) dan chatbot merupakan bentuk layanan konseling yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Chatbot dapat memberikan layanan konseling awal secara otomatis melalui pertanyaan skrining, pemberian saran dasar, atau mengarahkan pengguna pada layanan konseling lanjutan secara profesional (Miner et al., 2020). Beberapa chatbot yang telah dikembangkan secara internasional misalnya Woebot, Wysa, dan Tess, mampu memberikan bantuan dasar kesehatan mental secara interaktif dan efektif (Fulmer et al., 2021). Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa chatbot mampu membantu pengguna dalam mengatasi gangguan kecemasan ringan hingga sedang, meningkatkan suasana hati, serta memberikan intervensi awal yang cepat (Vaidyam et al., 2019). Walaupun tidak menggantikan konselor profesional sepenuhnya, teknologi ini berfungsi sebagai penanganan dini dan meningkatkan akses layanan kesehatan mental secara masif dan cepat di masa pandemi.

#### **4. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) dalam Terapi Kesehatan Mental**

Teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) saat ini mulai banyak dikembangkan untuk aplikasi dalam terapi kesehatan mental. Teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi secara virtual dalam lingkungan simulasi yang dirancang khusus untuk mengatasi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres pascatrauma (PTSD), atau bahkan burnout yang banyak dialami tenaga kesehatan selama pandemi (Riva et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa VR efektif dalam terapi eksposur untuk mengatasi gangguan kecemasan serta PTSD dengan menciptakan lingkungan terapeutik yang aman dan terkontrol (Park et al., 2021). Di sisi lain, AR juga dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial dan mendukung relaksasi melalui konten interaktif dan menenangkan yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat mobile (Baghaei et al., 2020). Meski masih terbatas implementasinya di Indonesia, potensi teknologi VR dan AR sangat menjanjikan dalam mendukung kesehatan mental tenaga kesehatan ke depannya.

Pemanfaatan berbagai jenis teknologi tersebut memberikan peluang besar untuk memperluas akses layanan konseling dan terapi kesehatan mental secara efisien, efektif, dan aman bagi tenaga kesehatan selama masa pandemi maupun setelahnya. Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan tantangan teknis, etis, dan sosial yang mungkin timbul, serta memerlukan evaluasi terus-menerus demi memastikan efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan.

### **C. Efektivitas Konseling Daring untuk Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi**

---

Pemanfaatan teknologi konseling daring pada tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 menjadi pilihan utama karena sifatnya yang fleksibel, efisien, serta aman. Berbagai kajian ilmiah terbaru membuktikan efektivitas metode ini dalam meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan, meskipun terdapat kelebihan dan keterbatasan dibanding metode konseling konvensional.

#### **1. Efektivitas Telekonseling dalam Mengurangi Stres, Kecemasan, dan Depresi Tenaga Kesehatan**

Penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa telekonseling secara signifikan efektif dalam mengurangi gejala stres, kecemasan, dan depresi di kalangan tenaga kesehatan. Studi meta-analisis oleh Luo et al. (2020) serta studi oleh Windarwati et al. (2021) menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang mengikuti telekonseling secara teratur menunjukkan penurunan tingkat stres dan kecemasan yang lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol tanpa intervensi atau intervensi konvensional. Telekonseling juga efektif dalam memberikan

dukungan psikososial dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menghadapi beban kerja serta tekanan emosional akibat tingginya risiko penularan COVID-19 (Situmorang, 2020; Liu et al., 2021).

Selain itu, konseling daring memungkinkan pemberian intervensi tepat waktu di tengah situasi darurat pandemi. Studi terbaru menyebutkan bahwa intervensi online yang terstruktur dengan pendekatan kognitif perilaku terbukti menurunkan tingkat depresi dan kecemasan tenaga kesehatan di berbagai negara secara efektif (Al-Alawi et al., 2021). Efektivitas ini turut didukung oleh kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta rasa aman dari risiko infeksi, sehingga tenaga kesehatan lebih nyaman mengikuti sesi konseling.

## **2. Kelebihan dan Keterbatasan Layanan Konseling Daring Dibandingkan Metode Konvensional**

Kelebihan utama konseling daring dibanding metode konvensional adalah kemudahan akses, fleksibilitas waktu dan lokasi, serta anonimitas yang tinggi. Telekonseling memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di lokasi terpencil atau dalam kondisi isolasi mandiri untuk mendapatkan layanan kesehatan mental secara profesional dan teratur (Zhang et al., 2020). Anonimitas layanan daring juga membantu tenaga kesehatan merasa lebih aman dan bebas stigma dalam mengungkapkan masalah psikologis dibandingkan metode konseling tatap muka konvensional (Windarwati et al., 2021).

Meski demikian, layanan konseling daring juga memiliki keterbatasan. Tantangan terbesar adalah terbatasnya interaksi non-verbal yang menyebabkan potensi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara konselor dan klien (Alqahtani et al., 2021). Selain itu, kendala teknis seperti gangguan koneksi internet dan kurangnya keterampilan teknis tenaga kesehatan dan konselor juga sering kali menghambat kelancaran sesi konseling daring (Marshall et al., 2020). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aspek privasi dan kerahasiaan data menjadi perhatian utama dalam penggunaan layanan daring ini (Miner et al., 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi serta perbaikan infrastruktur teknologi untuk meminimalkan keterbatasan tersebut.

## **3. Persepsi Tenaga Kesehatan terhadap Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Konseling Selama Pandemi COVID-19**

Persepsi tenaga kesehatan terhadap layanan konseling daring selama pandemi COVID-19 secara umum menunjukkan penerimaan yang positif. Penelitian terbaru di berbagai negara menemukan bahwa tenaga kesehatan menganggap layanan konseling daring sebagai alternatif yang efektif dalam menjaga kesehatan mental mereka selama masa krisis (Windarwati et al., 2021; Chen et al., 2021). Mayoritas tenaga kesehatan merasa terbantu oleh kemudahan

akses serta fleksibilitas layanan daring, terutama di tengah pembatasan sosial yang ketat dan beban kerja yang tinggi.

Namun, beberapa studi juga mencatat adanya persepsi negatif yang muncul terutama terkait aspek teknis, keamanan data, serta preferensi interaksi tatap muka secara langsung dengan konselor (Alqahtani et al., 2021). Sebagian tenaga kesehatan merasa bahwa konseling daring kurang efektif dalam membangun hubungan emosional antara konselor dan klien dibandingkan layanan tatap muka. Selain itu, kurangnya privasi di lingkungan kerja atau rumah sering kali menjadi hambatan psikologis tersendiri bagi tenaga kesehatan dalam memanfaatkan layanan daring (Liu et al., 2021).

Oleh karena itu, penting bagi institusi layanan kesehatan dan para konselor untuk memberikan edukasi yang tepat kepada tenaga kesehatan mengenai penggunaan teknologi konseling daring, memastikan keamanan data pribadi, serta meningkatkan kompetensi teknis tenaga kesehatan agar manfaat optimal dari layanan konseling daring ini dapat tercapai secara maksimal.

#### **D. Tantangan Implementasi Teknologi dalam Konseling Kesehatan Mental**

---

Walaupun teknologi konseling daring telah terbukti efektif dalam mendukung kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi hambatan teknis, persoalan privasi dan keamanan data, serta hambatan psikologis yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

##### **1. Hambatan Teknis dan Infrastruktur Teknologi di Fasilitas Layanan Kesehatan**

Hambatan teknis menjadi tantangan utama dalam implementasi teknologi konseling daring, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa fasilitas layanan kesehatan belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet stabil, perangkat keras yang memadai, serta akses platform digital yang dapat diandalkan (Windarwati et al., 2021; Alqahtani et al., 2021). Masalah-masalah ini menyebabkan terganggunya kelancaran komunikasi selama sesi konseling, seperti putusnya koneksi internet, lambatnya transfer data, hingga kesulitan mengakses platform tertentu.

Studi yang dilakukan Marshall et al. (2020) menyebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi ini mengurangi efektivitas layanan konseling daring secara signifikan, menimbulkan frustrasi baik bagi konselor maupun tenaga kesehatan sebagai klien. Di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, tantangan tersebut bahkan lebih kompleks, karena tidak semua fasilitas

kesehatan memiliki jaringan internet memadai atau perangkat yang dibutuhkan, seperti komputer dan smartphone yang layak untuk mengakses layanan daring (Situmorang, 2020).

## **2. Faktor Privasi, Keamanan Data, dan Aspek Legal dalam Konseling Berbasis Teknologi**

Implementasi teknologi dalam konseling kesehatan mental juga menimbulkan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan aspek legal. Privasi data menjadi perhatian khusus karena informasi kesehatan mental dianggap sebagai data sensitif. Menurut Miner et al. (2020), penggunaan platform digital untuk konseling daring meningkatkan risiko pelanggaran privasi akibat kebocoran data, peretasan, atau akses ilegal yang dilakukan pihak tidak berwenang.

Terkait aspek keamanan data, penelitian Alqahtani et al. (2021) menekankan pentingnya regulasi dan standar yang jelas mengenai pengelolaan data pasien dalam layanan telekonseling. Aspek legal juga menjadi perhatian serius, terutama dalam menetapkan tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran privasi atau kesalahan praktik dalam konseling daring. Regulasi hukum yang belum jelas dan belum disesuaikan secara komprehensif terhadap teknologi konseling juga menjadi tantangan implementasi layanan ini (Vaidyam et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan konseling daring untuk memastikan bahwa platform yang digunakan telah memenuhi standar perlindungan data pribadi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Hambatan Psikologis Tenaga Kesehatan dalam Mengakses Layanan Konseling Daring**

Hambatan psikologis tenaga kesehatan dalam mengakses layanan konseling daring merupakan tantangan lain yang perlu diperhatikan. Banyak tenaga kesehatan masih mengalami kesulitan psikologis dalam menggunakan layanan ini karena stigma terkait gangguan kesehatan mental serta kekhawatiran terhadap privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka (Chen et al., 2021; Liu et al., 2021). Tenaga kesehatan juga terkadang mengalami ketidaknyamanan akibat interaksi yang dianggap kurang personal dibandingkan layanan konseling tatap muka konvensional.

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa faktor budaya dan stigma sosial di lingkungan kerja tenaga kesehatan turut memperbesar hambatan psikologis ini (Windarwati et al., 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman serta literasi digital di kalangan tenaga kesehatan juga menjadi penyebab keengganan mereka menggunakan teknologi konseling daring (Marshall et al., 2020). Oleh sebab itu, institusi kesehatan dan para penyedia layanan konseling perlu melakukan

sosialisasi dan edukasi intensif agar tenaga kesehatan memahami manfaat layanan daring dan merasa aman serta nyaman dalam mengaksesnya.

Dengan memahami berbagai tantangan implementasi tersebut, langkah-langkah strategis perlu segera diambil agar manfaat teknologi dalam konseling kesehatan mental dapat optimal dirasakan oleh tenaga kesehatan, khususnya selama masa pandemi COVID-19 maupun di masa mendatang.

## **E. Strategi dan Solusi dalam Optimalisasi Teknologi Konseling**

---

Dalam menghadapi tantangan penerapan teknologi konseling daring di masa pandemi COVID-19, diperlukan strategi dan solusi yang komprehensif agar layanan konseling dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan platform konseling yang ramah pengguna, pemberian edukasi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan, serta integrasi teknologi konseling ke dalam kebijakan di fasilitas kesehatan.

### **1. Strategi Pengembangan Layanan Konseling Daring yang Ramah Pengguna bagi Tenaga Kesehatan**

Pengembangan layanan konseling daring yang ramah pengguna sangat penting untuk meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan. Menurut penelitian Alqahtani et al. (2021), platform yang dirancang secara sederhana, intuitif, serta memiliki panduan penggunaan yang jelas akan lebih disukai oleh pengguna dibandingkan dengan platform yang rumit dan sulit digunakan. Desain antarmuka (user interface/UI) yang menarik, navigasi yang sederhana, serta aksesibilitas melalui berbagai perangkat (komputer, tablet, smartphone) merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan dalam pengembangan teknologi konseling daring (Marshall et al., 2020).

Studi oleh Situmorang (2020) juga menekankan pentingnya fitur interaktif seperti video conference, chat, notifikasi pengingat jadwal konseling, serta dukungan teknis 24 jam yang tersedia bagi pengguna. Platform yang menyediakan fitur-fitur tersebut terbukti mampu meningkatkan tingkat kepuasan pengguna serta efektivitas konseling daring dalam menurunkan stres dan kecemasan di kalangan tenaga kesehatan (Zhang et al., 2020). Selain itu, aspek keamanan data dan privasi pengguna juga harus menjadi prioritas utama dalam desain layanan konseling daring yang ramah pengguna.

### **2. Edukasi dan Pelatihan Penggunaan Teknologi Konseling untuk Tenaga Kesehatan**

Strategi lain yang krusial adalah pemberian edukasi dan pelatihan secara intensif kepada tenaga kesehatan terkait penggunaan teknologi konseling daring. Literasi digital yang rendah sering menjadi kendala utama dalam optimalisasi

layanan ini. Penelitian terbaru oleh Windarwati et al. (2021) menemukan bahwa edukasi berupa pelatihan teknis maupun pelatihan tentang keamanan data digital secara signifikan meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam memanfaatkan layanan konseling daring.

Pelatihan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis operasional platform, tetapi juga pada etika dan komunikasi efektif selama proses konseling daring (Marshall et al., 2020). Studi oleh Chen et al. (2021) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang diberikan pelatihan komprehensif tentang teknologi konseling lebih percaya diri dan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan mental. Oleh karena itu, institusi kesehatan perlu rutin mengadakan pelatihan atau webinar interaktif yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi konseling.

### **3. Integrasi Teknologi Layanan Konseling ke dalam Kebijakan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan**

Integrasi teknologi konseling ke dalam kebijakan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan merupakan solusi penting agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian terbaru merekomendasikan agar kebijakan institusional secara jelas mencakup pedoman operasional, tata kelola data pasien, dan standar teknis penggunaan teknologi konseling daring (Alqahtani et al., 2021; Liu et al., 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap privasi pengguna sekaligus memperjelas aspek tanggung jawab hukum pihak penyedia layanan konseling.

Selain itu, kebijakan integratif juga mencakup dukungan finansial dan infrastruktur teknologi, seperti anggaran khusus untuk pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas bandwidth internet di lingkungan fasilitas kesehatan (Windarwati et al., 2021). Strategi ini penting agar tenaga kesehatan tidak terhambat oleh keterbatasan teknis selama proses konseling. Dukungan manajemen juga sangat diperlukan melalui kebijakan insentif atau dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan yang aktif mengikuti layanan konseling daring (Marshall et al., 2020).

Dengan strategi integratif seperti ini, teknologi konseling daring diharapkan dapat secara efektif mendukung kesehatan mental tenaga kesehatan, baik dalam masa pandemi COVID-19 maupun pada masa setelahnya.

## **F. Implikasi Pemanfaatan Teknologi Konseling terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

---

Pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling selama masa pandemi COVID-19 telah membawa implikasi positif yang signifikan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Implikasi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja profesional tenaga kesehatan secara keseluruhan.

### **1. Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pemanfaatan Teknologi Konseling terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Dalam jangka pendek, pemanfaatan teknologi konseling daring memberikan dampak langsung dalam mengurangi gejala stres akut, kecemasan, insomnia, dan depresi yang dialami tenaga kesehatan selama pandemi. Studi meta-analisis terbaru oleh Pappa et al. (2020) dan penelitian di Indonesia oleh Windarwati et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi telekonseling secara signifikan membantu tenaga kesehatan mengelola tekanan psikologis akibat tingginya beban kerja serta risiko tertular COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Liu et al. (2021) juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang rutin menggunakan layanan konseling daring menunjukkan tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan layanan tersebut.

Dalam jangka panjang, pemanfaatan teknologi konseling daring dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, seperti peningkatan resiliensi, kemampuan coping terhadap stres yang lebih baik, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Chen et al., 2021). Menurut penelitian longitudinal yang dilakukan Al-Alawi et al. (2021), intervensi konseling daring yang berkelanjutan terbukti mampu mengembangkan keterampilan psikososial tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi krisis serupa di masa depan. Selain itu, layanan konseling daring yang sudah terintegrasi di masa pandemi juga diprediksi akan menjadi komponen permanen dalam layanan kesehatan mental, membantu menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan mendukung di institusi kesehatan (Marshall et al., 2020).

### **2. Implikasi Teknologi Konseling bagi Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi**

Pemanfaatan teknologi konseling daring secara tidak langsung berdampak positif terhadap produktivitas dan kinerja tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mendapatkan dukungan konseling secara teratur melalui teknologi daring



mengalami peningkatan kemampuan konsentrasi, fokus kerja yang lebih baik, serta lebih mampu mengambil keputusan klinis secara optimal dibandingkan tenaga kesehatan yang mengalami tekanan psikologis tanpa intervensi (Chen et al., 2021; Zhang et al., 2020).

Peningkatan kesehatan mental yang diperoleh dari intervensi teknologi konseling daring juga berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kelelahan fisik dan emosional (burnout) tenaga kesehatan. Menurut penelitian oleh Windarwati et al. (2021), tenaga kesehatan yang mengalami burnout memiliki risiko lebih tinggi melakukan kesalahan medis atau mengalami penurunan performa kerja. Dengan adanya layanan konseling daring, dampak burnout dapat diminimalkan, sehingga kualitas layanan kesehatan kepada pasien selama pandemi dapat tetap terjaga.

Selain itu, implikasi positif ini mencakup peningkatan keterlibatan (engagement) tenaga kesehatan terhadap pekerjaannya. Studi yang dilakukan oleh Marshall et al. (2020) menemukan bahwa tenaga kesehatan yang memperoleh layanan konseling daring memiliki tingkat engagement kerja yang lebih tinggi, rasa percaya diri dalam menjalankan tugasnya meningkat, dan menunjukkan komitmen kerja yang lebih kuat. Kondisi ini tentunya sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem pelayanan kesehatan, khususnya di tengah situasi krisis pandemi.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi konseling daring tidak hanya memberikan dampak positif secara psikologis, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas tenaga kesehatan secara signifikan selama pandemi COVID-19 dan seterusnya.

## **G. Tren dan Arah Masa Depan Teknologi dalam Konseling**

---

Pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling kesehatan mental telah mengalami perkembangan pesat akibat pandemi COVID-19. Seiring waktu, diprediksi tren teknologi dalam konseling kesehatan mental akan terus berkembang, bahkan setelah pandemi berakhir. Teknologi-teknologi terbaru seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) juga diprediksi akan semakin banyak diintegrasikan dalam layanan konseling untuk tenaga kesehatan di masa depan.

### **1. Prediksi Tren Teknologi Layanan Konseling Kesehatan Mental untuk Tenaga Kesehatan Pasca-pandemi**

Pasca-pandemi COVID-19, layanan konseling daring diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama dalam layanan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan. Studi oleh Windarwati et al. (2021) dan Zhang et al. (2020) memperkirakan bahwa layanan konseling online akan menjadi bagian integral dalam sistem pelayanan

kesehatan mental jangka panjang karena efektivitas dan fleksibilitasnya. Tenaga kesehatan juga semakin akrab dengan layanan telekonseling, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk terus mengakses layanan ini di masa mendatang (Marshall et al., 2020).

Selain itu, tren ke depan menunjukkan adanya peningkatan pengembangan platform konseling daring yang semakin personal, interaktif, dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Menurut Alqahtani et al. (2021), platform konseling yang dilengkapi dengan fitur interaktif real-time serta kemampuan memberikan feedback instan berdasarkan kondisi psikologis pengguna akan semakin diminati. Lebih lanjut, integrasi antara layanan konseling daring dengan sistem kesehatan digital yang sudah ada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya akan menjadi tren penting yang meningkatkan kemudahan akses serta efisiensi layanan kesehatan mental secara menyeluruh (Chen et al., 2021).

## **2. Inovasi Teknologi Baru (Artificial Intelligence dan Machine Learning) dalam Pengembangan Layanan Konseling Masa Depan**

Inovasi teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) diprediksi akan memberikan perubahan signifikan dalam layanan konseling kesehatan mental di masa depan. AI telah menunjukkan potensinya dalam bentuk layanan chatbot psikologis, seperti Woebot, Tess, dan Wysa yang mampu memberikan respons interaktif serta dukungan psikologis dasar kepada pengguna secara otomatis (Miner et al., 2020; Vaidyam et al., 2019). Studi terbaru oleh Fulmer et al. (2021) menunjukkan bahwa chatbot berbasis AI mampu secara efektif mengurangi gejala kecemasan dan depresi ringan hingga sedang pada tenaga kesehatan maupun masyarakat umum.

Machine Learning (ML), bagian dari teknologi AI, juga diprediksi akan berperan penting dalam menganalisis pola data pengguna, mendeteksi kondisi mental secara dini, serta memprediksi risiko gangguan mental melalui perilaku digital pengguna secara otomatis (Park et al., 2021). Implementasi ML juga mampu menciptakan intervensi konseling yang lebih personal dan adaptif terhadap kondisi psikologis individu secara real-time (Riva et al., 2020).

Namun demikian, integrasi teknologi AI dan ML ini juga akan membawa tantangan baru, khususnya terkait privasi data, transparansi algoritma yang digunakan, serta aspek etis dalam praktik konseling daring (Miner et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan layanan konseling yang didukung AI dan ML harus selalu diimbangi dengan regulasi dan kebijakan yang jelas, guna memastikan layanan tetap aman, efektif, serta menjunjung tinggi prinsip etika profesional dalam kesehatan mental.

Dengan demikian, perkembangan teknologi konseling kesehatan mental di masa depan diprediksi akan semakin canggih, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan, sekaligus menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi secara bijak.

## **H. Penutup**

---

Pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling telah menjadi solusi penting dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Berbagai bukti ilmiah terkini menunjukkan bahwa layanan konseling daring mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi psikologis tenaga kesehatan, baik dalam mengurangi stres, kecemasan, depresi, hingga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebagai solusi alternatif di tengah tantangan pembatasan sosial dan risiko infeksi, teknologi konseling daring terbukti efektif dalam menjangkau tenaga kesehatan yang membutuhkan dukungan psikologis secara cepat, aman, serta efisien (Windarwati et al., 2021; Pappa et al., 2020; Marshall et al., 2020).

Secara khusus, layanan konseling daring mampu mengatasi hambatan geografis dan memberikan fleksibilitas tinggi bagi tenaga kesehatan yang memiliki jadwal kerja yang padat atau bertugas di wilayah terpencil. Di sisi lain, implementasi teknologi ini juga menghadapi tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, risiko keamanan data, serta hambatan psikologis tenaga kesehatan dalam menggunakan layanan konseling daring (Alqahtani et al., 2021; Liu et al., 2021).

### **1. Kesimpulan Pentingnya Teknologi dalam Layanan Konseling untuk Menjaga Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan Selama Pandemi**

Pandemi COVID-19 menegaskan kembali pentingnya layanan kesehatan mental yang cepat dan mudah diakses bagi tenaga kesehatan. Pemanfaatan teknologi konseling daring secara nyata memberikan kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berbagai penelitian terbaru memperkuat kesimpulan bahwa layanan konseling daring menjadi metode efektif yang mampu menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan secara optimal dalam situasi krisis pandemi (Chen et al., 2021; Situmorang, 2020). Teknologi ini juga berperan vital dalam menciptakan budaya kerja yang lebih positif, mendukung resiliensi, dan meningkatkan performa kerja tenaga kesehatan secara berkelanjutan.

Selain efektivitas jangka pendek selama pandemi, layanan konseling berbasis teknologi juga memiliki potensi besar dalam jangka panjang, dengan menjadi bagian integral dari sistem kesehatan mental masa depan yang lebih

modern, adaptif, dan berkelanjutan (Zhang et al., 2020; Marshall et al., 2020). Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan optimalisasi teknologi konseling merupakan langkah strategis yang perlu terus didorong oleh institusi kesehatan, pemerintah, maupun organisasi profesional.

## **2. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Konseling di Masa Mendatang**

Berdasarkan bukti-bukti penelitian terkini, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pengembangan teknologi konseling di masa mendatang, antara lain:

### **a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi**

- Institusi kesehatan perlu meningkatkan kualitas jaringan internet serta perangkat teknologi yang digunakan dalam layanan konseling daring agar lebih stabil dan dapat diakses secara luas oleh tenaga kesehatan, termasuk yang bertugas di daerah terpencil (Windarwati et al., 2021; Situmorang, 2020).

### **b. Penguatan Kapasitas Digital Tenaga Kesehatan**

- Pemberian pelatihan teknis dan edukasi digital kepada tenaga kesehatan menjadi kunci penting agar layanan konseling daring bisa dimanfaatkan secara maksimal. Edukasi ini harus mencakup aspek teknis operasional platform, etika, komunikasi daring, serta keamanan data (Marshall et al., 2020; Alqahtani et al., 2021).

### **c. Integrasi ke dalam Kebijakan Institusi**

- Layanan konseling daring harus secara eksplisit terintegrasi ke dalam kebijakan dan pedoman institusional rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kebijakan ini mencakup pedoman privasi data, prosedur operasional standar (SOP), serta dukungan finansial dalam pengembangan teknologi layanan kesehatan mental (Liu et al., 2021; Zhang et al., 2020).

### **d. Pengembangan Layanan Konseling Berbasis Artificial Intelligence (AI)**

- Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), chatbot interaktif, serta analisis data melalui machine learning direkomendasikan untuk menciptakan layanan konseling yang lebih adaptif, responsif, dan personal sesuai dengan kebutuhan psikologis individu secara real-time (Miner et al., 2020; Fulmer et al., 2021).

### **e. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan**

- Evaluasi rutin serta monitoring secara berkala terhadap layanan konseling daring perlu dilakukan, dengan melibatkan tenaga kesehatan sebagai pengguna langsung, agar layanan yang diberikan terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan aktual (Pappa et al., 2020; Chen et al., 2021).

Implementasi rekomendasi berbasis bukti tersebut diyakini dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas layanan konseling berbasis teknologi, tidak hanya selama masa pandemi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan secara berkelanjutan di masa depan.

## **I. Referensi**

---

- Al-Alawi, M., McCall, R. K., Sultan, A., & Al Balushi, N. (2021). Efficacy of a six-week online cognitive behavioral therapy for anxiety and depression among healthcare workers during COVID-19. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 752018.
- Alqahtani, M. M., Alanazi, M. M., & Alshehri, M. M. (2021). Digital mental health services in COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2021, 1–9.
- Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L., ... & Zhang, Z. (2021). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. *The Lancet Psychiatry*, 7(4), e15–e16.
- Etzelmüller, A., Radkovsky, A., Hannig, W., Berking, M., & Ebert, D. D. (2020). Patients' experience with blended video- and internet-based cognitive behavioural therapy service in routine care. *Internet Interventions*, 22, 100373.
- Fulmer, R., Joerin, A., Gentile, B., Lakerink, L., & Rauws, M. (2021). Using psychological artificial intelligence (Tess) to relieve symptoms of depression and anxiety: Randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 8(4), e23214.
- Liu, Z., Han, B., Jiang, R., Huang, Y., Ma, C., Wen, J., ... & Ma, Y. (2021). Mental health status of healthcare workers in China for COVID-19 epidemic. *Annals of Global Health*, 87(1), 20.
- Luo, C., Huang, Y., & Wang, L. (2020). A meta-analysis of telehealth for the treatment of anxiety disorders. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 26(10), 603–613.
- Marshall, J. M., Dunstan, D. A., & Bartik, W. (2020). The role of digital mental health resources to treat trauma symptoms in Australia during COVID-19. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12(S1), S269–S271.
- Miner, A. S., Shah, N., Bullock, K. D., Arnow, B. A., Bailenson, J., & Hancock, J. T. (2020). Key considerations for incorporating conversational AI in psychotherapy. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 746.
- Pappa, S., Ntella, V., Giannakas, T., Giannakoulis, V. G., Papoutsis, E., & Katsaounou, P. (2020). Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Brain, Behavior, and Immunity*, 88, 901–907.

- Park, M. J., Kim, D. J., Lee, U., Na, E. J., & Jeon, H. J. (2021). A literature overview of virtual reality (VR) in treatment of psychiatric disorders: Recent advances and limitations. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 741112.
- Riva, G., Bernardelli, L., Castelnuovo, G., & Di Lernia, D. (2020). Virtual Reality in mental health: state of the art and future perspectives. *Expert Review of Medical Devices*, 17(12), 1043–1051.
- Situmorang, D. D. B. (2020). Online counseling services in the COVID-19 outbreak: Are they really new? *The Journal of Pastoral Care & Counseling*, 74(3), 166–174.
- Vaidyam, A. N., Wisniewski, H., Halamka, J. D., Kashavan, M. S., & Torous, J. B. (2019). Chatbots and conversational agents in mental health: A review of the psychiatric landscape. *Canadian Journal of Psychiatry*, 64(7), 456–464.
- Windarwati, H. D., Ati, N. A. L., Paraswati, M. D., Ilmy, S. K., Supianto, A. A., Rizzal, A. F., & Sulaksono, A. D. (2021). Stressor, coping mechanism, and motivation among healthcare workers in dealing with stress due to COVID-19 pandemic in Indonesia. *Asian Journal of Psychiatry*, 56, 102470.
- Zhang, M. W. B., Ho, R. C. M., Loh, A., Wing, T., Wynne, O., & Wong, S. Y. (2020). The use of telehealth for mental health care during COVID-19 pandemic: A scoping review. *JMIR Mental Health*, 7(12), e21717.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kemenkes RI.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Impact of COVID-19 on Mental Health Services*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Mental Health and Psychosocial Considerations during the COVID-19 Outbreak*. Geneva: WHO.

# BAB IV

## PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KESEHATAN MENTAL TENAGA MEDIS

---

### A. Pendahuluan

---

Beban kerja merupakan tingkat kapasitas individu pekerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, yang dapat diindikasikan dari jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, waktu/batasan waktu yang dimiliki oleh pekerja dalam menyelesaikan tugasnya, serta pandangan subjektif individu itu sendiri mengenai pekerjaan yang diberikan kepadanya (Handayani, 2018). Pelayanan kesehatan saat ini merupakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan dan kaitannya dengan manusia diharapkan menyediakan fasilitas pelayanan yang baik bagi setiap individu (pasien). Tenaga medis sebagai garis depan dalam melawan COVID-19 memegang peranan penting dalam hal penyembuhan serta pemulihan orang yang membutuhkan pertolongan secara langsung.

Sarana kesehatan seperti rumah sakit tentu membutuhkan perawat sebagai sumber daya manusia untuk memberikan perawatan pasien. Rumah sakit membutuhkan berbagai tenaga kesehatan, termasuk perawat; tanpa mereka, pelayanan tidak dapat diberikan. Karena hal tersebut, pengelolaan keperawatan di rumah sakit harus diperhatikan untuk menjamin kelancaran pelayanan rumah sakit dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasien yang terus meningkat (Dirdjo dan Prayitno, 2016). Orang yang berhadapan langsung dengan pasien disebut perawat.

Seni praktis dalam menggunakan dan mengembangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penyesuaian diri, kesehatan mental, dan pencegahan gangguan psikologis adalah kesehatan mental. (Yusuf, 2018). Seseorang dengan kesehatan mental adalah orang yang menerima tanggung jawab, tumbuh dan menjadi dewasa dari waktu ke waktu, dan menyesuaikan bagaimana dia berpartisipasi untuk mematuhi norma dan praktik sosial dalam budayanya. (Notosoedirdjo, 2014). Gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan kekhawatiran, dapat mempengaruhi profesional kesehatan perawat maupun individu di masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya masalah kesehatan, khususnya bagi tenaga medis yang secara langsung

berinteraksi dengan pasien yang menderita Covid-19. Namun, kesejahteraan mental dan emosional tenaga kesehatan juga harus diperhatikan. Selain kecemasan dan tekanan tertular virus Covid-19 dari pasien yang dirawatnya, penambahan jam kerja juga dapat mengganggu kesehatan mental petugas kesehatan. Data survei cross sectional menunjukkan sebagian dari 1.257 tenaga kesehatan yang berada di China mengalami depresi dan gangguan kecemasan karena merawat pasien COVID-19 karena mengancam kesehatan mental mereka (Lai Et Al 2020). Ancaman terhadap kesehatan mental petugas kesehatan memiliki efek jangka panjang yang mempengaruhi kinerja tenaga medis dalam menjalankan rutinitas serta menjaga kualitas kerja.

## **B. Kerangka Konsep**

---

### **1. Beban Kerja**

Menurut Herrianto (2010), beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Seorang tenaga kerja mempunyai kemampuan berbeda dalam hubungannya dengan beban kerja. Aktivitas manusia dapat digolongkan menjadi kerja fisik (otot) dan kerja mental (otak). Meskipun tidak dipisahkan, namun masih dapat dibedakan pekerjaan dengan dominasi fisik dan pekerjaan dengan dominasi aktivitas mental. Menurut Tarwaka. (2004).

Beban kerja yang berlebihan pada tenaga medis dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Stres, kecemasan, dan kelelahan emosional (burnout) adalah beberapa masalah yang umum terjadi akibat beban kerja yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sangat berpengaruh, dimana pemberian beban kerja secara efektif berguna untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat diberikan beban kerja yang maksimal dan pengaruhnya terhadap puskesmas itu sendiri dan memberikan beban kerja yang dimana hendaknya harus merata. Belum lagi tenaga kesehatan juga harus memperhatikan kesehatannya sendiri dari berbagai macam penyakit menular yang ada di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

### **2. Faktor yang mempengaruhi beban Kerja.**

Menurut Tarwaka, dkk. (2004), faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah sebagai berikut:



- a. Faktor Eksternal Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Aspek beban kerja eksternal sering disebut sebagai stressor, yang termasuk beban kerja eksternal adalah:
- 1) Tugas-tugas (tasks). Tugas ada yang bersifat fisik seperti, tata ruang kerja, stasiun kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja dan alat bantu kerja. Tugas juga ada yang bersifat mental seperti, kompleksitas pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
  - 2) Organisasi kerja. Organisasi kerja yang memengaruhi beban kerja misalnya, lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, sistem pengupahan, kerja malam, tugas dan wewenang.
  - 3) Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dapat memengaruhi beban kerja adalah yang termasuk dalam beban tambahan akibat lingkungan kerja. Misalnya saja lingkungan kerja fisik (penerangan, kebisingan, getaran mekanis), lingkungan kerja kimiawi (debu, gas pencemar udara) lingkungan kerja biologis (bakteri, virus dan parasit) dan lingkungan kerja psikologis (penempatan tenaga kerja).
- b. Faktor Internal Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Reaksi tersebut dikenal dengan strain. Secara ringkas faktor internal meliputi:
- 1) Faktor somatis, yaitu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi
  - 2) Faktor psikis, yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan lain-lain.

### **C. Beban Kerja Mental.**

---

Menurut Attwood, (2007), beban kerja mental adalah derajat kapasitas proses yang dikeluarkan selama menampilkan tugas dan konsep, beban kerja mental muncul karena adanya proses persepsi, interpretasi, dan proses informasi yang disampaikan oleh organ sesori.

Beban kerja, dalam pengertian yang paling umum, adalah jumlah waktu dan sumber daya komputasi yang dibutuhkan sistem atau jaringan untuk menyelesaikan tugas atau menghasilkan keluaran kinerja petugas medis dalam menjalani rutinitas sesuai dengan kewenangan kerja, dimana beban kerja ini mengacu pada total permintaan sistem dari semua pengguna dan proses dari jumlah pekerjaan atau jam kerja yang harus diselesaikan, terutama oleh orang atau mesin tertentu dalam jangka waktu tertentu pada saat tertentu. Indikator dari beban kerja dalam penelitiannya adalah waktu kerja, jumlah pekerjaan, faktor internal tubuh dan faktor eksternal tubuh.

Ada beberapa cara Mengelola Beban Kerja, agar tenaga medis dapat menjalankan rutinitasnya dengan efisien serta efektif, mengingat dampak negatif beban kerja yang berlebihan terhadap kesehatan mental tenaga medis, penting untuk mencari solusi dan strategi manajemen stres yang efektif, sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan: Memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada tenaga medis.
2. Pengaturan jam kerja: Mengatur jam kerja yang lebih manusiawi dan memberikan waktu istirahat yang cukup.
3. Peningkatan staf: Menambah jumlah tenaga medis untuk mengurangi beban kerja per individu.
4. Pelatihan manajemen stres: Memberikan pelatihan tentang teknik manajemen stres dan coping yang efektif.
5. Penyediaan program kesehatan mental: Membangun program kesehatan mental yang terintegrasi di tempat kerja.

Setiap tenaga kesehatan wajib memahami cara mengelola beban kerja secara efektif dan memberikan dukungan yang memadai, kesehatan mental tenaga medis dapat terjaga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

#### **D. Beban Kerja Mental**

---

Beban mental adalah pekerjaan "berpikir" yang Anda lakukan setiap hari . Tugas kognitif seperti mengingat bahan makanan apa yang harus dibeli mungkin tidak tampak berat. Namun, ketika tugas-tugas yang tidak terlihat itu menumpuk dan bebannya menjadi berat, yang dapat memengaruhi hubungan, kesehatan fisik, dan kesejahteraan mental jiwa pekerja apalagi pada situasi tertentu seperti adanya wabah penyakit tertentu yang mengharuskan tenaga kesehatan ekstra focus pada situasi darurat tersebut.

Menurut Moekijat (2010), beban kerja merupakan sebuah kapasitas yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja dalam segmen tertentu dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Hal tersebut bisa juga disebut dengan catatan atas hasil kerja. Kuantitas pekerjaan yang wajib diselesaikan dalam periode tertentu, dapat dibuktikan dari sudut pandang obyektif dan subyektif. Maksud dari sudut pandang obyektif adalah banyaknya periode yang digunakan atau banyaknya aktivitas yang telah dilaksanakan oleh tenaga kerja. Sedangkan beban kerja secara subyektif merupakan patokan yang digunakan oleh tenaga kerja terhadap ungkapan mengenai perasaan kelebihan beban kerja, ukurannya dari represi pekerjaan dan kepuasan kerja. Beban kerja dapat menjadi sumber ketidakpuasan tenaga kerja, hal tersebut disebabkan oleh kelebihan beban kerja.

Kompleksnya pekerjaan karyawan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan besarnya beban kerja yang dialami oleh karyawan dalam pekerjaannya. Kebanyakan metode pengukuran yang dikembangkan lebih menekankan pada sisi fisik manusia, padahal manusia tidak hanya menggunakan sisi fisiknya dalam bekerja, tetapi juga menggunakan sisi-sisi psikologisnya. Sisi psikologis yang berupa proses mental ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kinerja karyawan. Oleh karena itu perlu diketahui seberapa besar beban kerja mental yang dialami oleh karyawan.

Pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan pengukuran obyektif dan pengukuran subyektif. Pengukuran obyektif terdiri dari pengukuran fisiologis (*physiological measures*), pengukuran pekerjaan primer (*primary task measures*), dan pengukuran pekerjaan sekunder (*secondary task measures*).

Menurut Staveland (1988), merumuskan masalah pembuatan skala peringkat beban kerja dapat dilihat sebagai berikut:

1. Memilih kumpulan sub skala masalah yang paling tepat.
2. Menentukan bagaimana menghubungkan sub skala tersebut untuk memperoleh nilai beban kerja yang berbeda, baik diantara tugas maupun diantara pemberi peringkat.
3. Menentukan prosedur terbaik untuk memperoleh nilai numerik untuk sub skala tersebut sesuai dengan kebutuhan setiap tenaga kesehatan yang berpatokan pada resiko kerja di lapangan.

Pengukuran Beban Kerja Mental Aspek psikologi dalam suatu pekerjaan dapat berubah kapanpun. Banyak hal yang menyebabkan perubahan psikologi tersebut baik dari dorongan internal maupun eksternal. Faktor internal beban kerja merupakan faktor yang berasal dari diri tenaga kerja itu sendiri sebagai dampak dari adanya reaksi atas beban kerja eksternal. Secara umum, faktor internal beban kerja berupa yang biasa di lihat sebagai berikut:

1. Faktor somatis: jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, ukuran badan dan status gizi.
2. Faktor psikis: dukungan atau dorongan, kepercayaan, persepsi, kepuasan, keinginan. Sedangkan faktor eksternal merupakan beban kerja yang bersumber dari luar tubuh tenaga kerja. Hal-hal yang termasuk faktor eksternal tenaga kerja adalah tugas, organisasi dan lingkungan kerja. Berikut ini penjelasannya. Organisasi kerja dan lingkungan kerja diebut juga stressor. Ketiga aspek tersebut sukar untuk diamati dengan kasat mata, oleh karena itu dalam mengamati kedua faktor tersebut dilihat dari hasil pekerjaan, faktor yang dapat diperkirakan dengan

objektif, dan perilaku tenaga kerja itu sendiri (S. Tarwaka & Sudiajeng, 2004). Pengukuran beban mental bisa dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Pengukuran beban mental secara objektif
  - Pengukuran denyut jantung
  - Pengukuran waktu kedipan mata
  - Pengukuran dengan metode lain
- b. Pengukuran beban mental secara subjektif Pengukuran beban kerja mental secara subjektif bisa dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya:
  - NASA TLX
  - SWAT

Beban kerja juga bisa dilakukan pengukuran beban kerja bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu objective workload dan subjective workload, yang termasuk ke dalam objective workload measurement adalah sebagai berikut:

- a. Catecholamine Measurement
- b. Eye Blink Measurement
- c. Iscan Measurement
- d. Heart Rate Measurement, - MCHS (Modified Coope Harper Scaling).

Sehingga hasil yang di dapat sesuai dengan analisis kebutuhan jam kerja yang sesuai.

## **E. Dampak Beban Kerja Mental Yang Berlebihan**

---

Beban kerja yang berlebihan dapat membuat pekerja mengalami stres dan memicu gangguan mental lainnya. Pasalnya, beban kerja yang berlebihan dapat meningkatkan kelelahan secara emosional.

Robbins (2002) menyatakan bahwa stres kerja adalah keadaan kerja yang dinamis, ketika pekerja menghadapi peluang, batasan atau persyaratan, mereka bekerja sesuai dengan hasil yang ingin di capai dalam kondisi penting dan tidak pasti. Cooper (2009) menyatakan bahwa individu yang bekerja dibidang pelayanan akan lebih beresiko mengalami stres kerja karena banyak membutuhkan interaksi dengan masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga pengajar, tenaga pelayanan konseling, dan polisi.

Beban kerja yang berlebihan biasanya akan munculnya kelelahan emosional. Kelelahan ini merupakan stres yang ditandai dengan hilangnya energi dan kurangnya sumber daya emosional. Salah satu dampak dari *burnout* adalah depersonalisasi atau sinisme yang akan mempengaruhi kinerja, ada beberapa dampak lain dari beban kerja terhadap kesehatan mental:

1. Gangguan Kecemasan

Menjalankan beban pekerjaan yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak pasti. Ini kemudian membuat mereka merasa gelisah dan sedih sepanjang hari. Biasanya ini karena mereka takut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan harus menghadapi kemungkinan terburuk.

Kekhawatiran secara berlebihan ini dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental. Jika terus berlanjut, hal ini tentu akan memicu gangguan kecemasan.

## 2. Kesulitan Tidur

Pengidap burnout mungkin selalu merasa tertekan dan sulit untuk rileks. Secara alami, ini dapat berdampak pada kualitas tidur. Jadwal tidur akan menjadi tidak teratur, dan bahkan meskipun sedang lelah, pengidapnya tetap kesulitan tidur dan terpaksa begadang hingga pagi yang akan mempengaruhi pola tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan. Tidur yang baik membuat badan lebih segar saat bangun dan dapat menjaga daya tahan tubuh. Ketika pola tidur tidak teratur, itu juga akan memicu berbagai macam gangguan kesehatan.

## 3. Depresi

Seseorang yang selalu kelelahan akan sering merasa putus asa dan tidak bahagia. Selain itu, keinginan dan dorongan untuk melakukan aktivitas akan menurun. Burnout juga membuat seseorang lebih mudah untuk berhenti melakukan kebiasaan yang dia sukai. Hal ini akan menyebabkan gangguan mental dimana situasi ini, suasana hati yang kurang baik dapat diperburuk oleh beban kerja yang berat dan kelelahan yang berkepanjangan. Bukan tidak mungkin kondisi ini berkembang menjadi depresi jika terus berlanjut.

## 4. Mudah Marah

Seseorang atau pekerja biasanya menjadi lebih mudah marah ketika mereka kelelahan. Modifikasi perilaku ini biasanya terjadi ketika kamu berada di antara teman dekat atau anggota keluarga serta hal-hal yang sebelumnya biasa saja akan dapat dengan mudah membuat kamu marah. Hal ini juga dapat membuat pengidapnya sering marah dan menyalahkan diri sendiri.

## 5. Menghindari Aktivitas dengan Orang Lain

Tanda lain yang muncul dari kelebihan beban kerja yang berlebihan adalah kecenderungan untuk menghindari situasi sosial. Kondisi ini membuatnya sulit untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain, bahkan dengan rekan kerja, teman dekat, dan keluarga.

Pengidap burnout juga cenderung menghindari aktivitas dalam kantor. Mereka menganggap negatif semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian mereka akan berhenti peduli dengan pekerjaan dan menghindari semua aktivitas kantor, seperti tidak lagi bersosialisasi dengan rekan

kerja, dan enggan ikut dalam acara penting dimana tempat pekerja atau tenaga medis yang mengharuskan untuk hadir dengan kondisi fres.

Beban kerja, sebagai salah satu penyebab terpenting stres kerja, membahayakan kesehatan fisik dan mental perawat atau tenaga medis yang berkerja dengan beban kerja yang tinggi atau pada situasi pandemic tertentu dalam studi Shaw et ditemukan bahwa beban kerja kualitatif dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi, namun, hubungan ini tidak signifikan. Angermeyer et al. melaporkan bahwa perawat selalu dalam proses stres dan kerusakan psikologis karena beban kerja dan kerja shift. Di temukan banyak pemicu stres yang dapat menyebabkan stres kerja bagi perawat, seperti beban kerja berlebih, kurangnya tenaga kerja, kebebasan bertindak rendah, kematian pasien, gangguan tidur, jam kerja panjang dan penderitaan pasien, cedera fisik seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal dan muskuloskeletal dan masalah individu dan keluarga dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Gejala stres kerja yang dirasakan oleh tenaga kesehatan ini sesuai dengan teori Robbins (2006) yang menyatakan bahwa gejala stres kerja yang terjadi ditandai dengan munculnya aspek fisiologis seperti mengalami perubahan metabolisme tubuh, sakit kepala dan dapat menyebabkan serangan jantung; aspek psikologis seperti merasakan ketegangan, kecemasan, emosi yang tidak stabil dan merasa bosan; aspek perilaku seperti mengalami penurunan atau peningkatan pada pola makan, berbicara lebih cepat, serta mengalami gangguan tidur. Gejalagejala stres kerja ini akan membuat tenaga kesehatan menjadi sulit untuk fokus saat bekerja.

Tuntutan dan tantangan kerja yang dirasakan oleh tenaga kesehatan berasal dari lingkungan seperti ketidakjelasan ekonomi, ketidakjelasan politik, dan ketidakjelasan teknologi; organisasi seperti beban kerja yang overload, tuntutan menyelesaikan tugas, tuntutan pada peran, desain struktur organisasi dan gaya kepemimpinan di tempat kerja; bersumber dari individu seperti kondisi keluarga, kondisi ekonomi, kepribadian dan kesejahteraan psikologis

## **F. Penutup**

---

Beban kerja yang berlebihan dapat membuat pekerja mengalami stres dan memicu gangguan mental lainnya. Pasalnya, beban kerja yang berlebihan dapat meningkatkan kelelahan secara emosional yang berlebihan dan mengganggu aktifitas tenaga medis saat melakukan rutinitas hariannya.

Memberikan layanan 24 jam merupakan bagian yang tak terelakkan dari sistem perawatan kesehatan yang telah menyebabkan diperkenalkannya fenomena kerja shift. Kerja shift adalah pola rotasi berkelanjutan atau tidak berkelanjutan selama

hari atau minggu dan mengacu pada apa pun yang dilakukan di luar periode waktu pukul 7 pagi hingga 6 sore. sedangkan di negara-negara maju, sekitar 20% tenaga kerja bekerja secara shift, dan sepertiga tenaga kerja bekerja pada shift malam. Kerja shift merupakan salah satu tantangan terpenting dari sistem kesehatan, dan perawat sebagai kekuatan utama sistem ini menghadapi banyak komplikasi yang disebabkan oleh shift kerja.

Sangat di butuhkan manajemen pengaturan jam kerja dan beban kerja sesuai ruangan atau departemen yang menjadi wadah tenaga medis menghabiskan aktifitasnya selama 7 sampai 8 jam perhari, bila jam kerja normal, beban kerja yang berlebihan pada tenaga medis sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Peningkatan kesadaran akan dampak beban kerja, penerapan strategi manajemen stres, dan penyediaan dukungan yang memadai dapat membantu mengurangi risiko masalah kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup tenaga medis.

Penting untuk di perhatikan dan menjadi catatan khusus bagian ketenaga kerjaan dalam menentukan jam kerja tenaga medis sesuai kondisi di lapangan agar merasa nyaman dan tidak kesulitan dengan beban kerja Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bicarakan dengan atasan Anda, rekan kerja, atau profesional kesehatan mental. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda mengatasi stres dan masalah kesehatan mental lainnya.

Persepsi pada individu, terutama persepsi beban kerja yang berlebihan, menimbulkan negativitas baik mental maupun fisik pada personel yang bekerja dan dapat mempengaruhi kinerja, efisiensi, bahkan kesehatan personel tersebut. Tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan berkualitas menjadi suatu keharusan untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu, yang merupakan sektor padat karya. Persepsi beban kerja pada sektor kesehatan berkaitan erat dengan mutu perawatan pasien dan mempengaruhi burnout, kepuasan kerja, dan niat untuk keluar dari rutinitas yang di jalani saat ini.

## G. Referensi

---

- Andrianti dkk .(2019). Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja pada Perawat Di Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu. Jurnal Vokasi Keperawatan. Vo.2, No.2.
- Ansori, R.R, Martiana, T., (2017). Hubungan faktor karakteristik individu dan kondisi pekerjaan terhadap stress kerja pada perawat gigi. The Indonesian Journal of Public Health, Vol. 12 No. 1, 57-84
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Benenden health. Diakses pada 2022. Workplace Mental Health Problems.
- Kurnaidi Anwar. (2013). Manajemen Keperawatan dan Prospektifnya. Jakarta: fakultas Kedokteran Universitas. Kawatu P. (2012). Bahan Ajar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Manado: FKM Unsrat
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabet.
- Suliswati, Ester, Monika, dkk. (2005). Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: EGC. Titasari, Nimas Arum & Tiara Fani. (2021). Dampak Psikologis Pandemi Covid-19 pada Petugas Rekam Medis. Prosiding Diskusi Ilmiah.
- Sumarno. (2006). Faktor-faktor yang Berperan Dalam Upaya Mendapatkan Alat Diagnosis Dini Untuk Menanggulangi Penyakit Infeksi. EG.
- Veithzal, Rivai & Sagala, Ella Jauvani. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



# BAB V

## DUKUNGAN KELUARGA UNTUK TENAGA KESEHATAN

---

### A. Pendahuluan

---

Dalam beberapa tahun terakhir, tenaga kesehatan telah mengalami tekanan yang signifikan dalam menjalankan tugas mereka, khususnya pada saat pandemik oleh karena penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Mereka tidak hanya harus menghadapi tantangan dalam merawat pasien, tetapi juga harus menghadapi stres dan kelelahan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka bahkan kematian.

Oleh karena itu, dukungan keluarga bagi tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam membantu mereka menghadapi tantangan tersebut. Dukungan adalah suatu bentuk bantuan atau sokongan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membantu mereka mengatasi kesulitan, masalah, atau tantangan yang dihadapi, Demerouti, E., & Cropanzano, R. (2019). Pada bab ini dukungan yang dimaksud adalah dukungan keluarga untuk anggota keluarga yang menjadi tenaga kesehatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga adalah "kesatuan sosial yang terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan darah, perkawinan, atau adopsi" (KBBI, 2020). Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36, 2009 Tenaga kesehatan adalah orang yang berprofesi di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya atau dengan kata lain tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja di bidang kesehatan, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat.

Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan ketika terjadi pandemik. Dukungan keluarga untuk tenaga kesehatan sangat penting karena dukungan keluarga dapat membantu tenaga kesehatan dalam mereduksi stres kerja dan meningkatkan motivasi kerja, Choirul, A. (2020).

Dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional, penilaian, dan kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi kerja. Dukungan keluarga juga dapat membantu tenaga kesehatan merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih

baik kepada pasien dan menjalankan tugas mereka serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka, sehingga kualitas hidup mereka ditingkatkan.

## **B. Dukungan; Jenis, Bentuk dan Manfaat Dukungan**

---

Dukungan adalah suatu bentuk bantuan atau sokongan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membantu mereka mengatasi kesulitan, masalah, atau tantangan yang dihadapi, Demerouti, E., & Cropanzano, R. (2019). Pada bab ini akan diuraikan tentang Jenis, bentuk dan manfaat dari dukungan,

Jenis dukungan; Jenis dukungan yang dimaksudkan adalah dukungan emosional, dukungan praktis, dukungan informasional dan dukungan sosial. 1) Dukungan emosional adalah dukungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk membantu mengatasi perasaan sedih, cemas, atau takut. Dukungan ini diperlukan karena tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan pandemik sering mengalami kesulitan emosional, seperti kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Dukungan keluarga dapat membantu mengatasi kesulitan emosional tersebut, Sudarto, H. (2019). 2) Dukungan praktis: merupakan dukungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk membantu mengatasi kesulitan praktis, seperti membantu dengan pekerjaan rumah atau mengurus anak, sesuai dengan peran tenaga kesehatan di kegiatan hariannya di rumah tangganya. Bantuan ini akan mengurangi kelelahan fisik dan meningkatkan stamina tenaga kesehatan, Sudarto, H. (2020). 3) Dukungan informasional merupakan dukungan yang diberikan untuk membantu tenaga kesehatan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Beberapa informasi yang dapat diberikan keluarga misalnya mengingatkan tenaga kesehatan akan gejala penyakit, pengobatan, dan cara pencegahan. Hal lainnya membantu mencari sumber daya seperti informasi layanan kesehatan yang dapat digunakan. Selain itu keluarga memberikan informasi tentang teknologi kesehatan yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka, seperti aplikasi kesehatan, perangkat medis, dan sistem informasi kesehatan, *Journal of Clinical Nursing*. (2020). 4) Dukungan sosial (*social support*) adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh orang lain, seperti keluarga, teman, atau komunitas, untuk membantu seseorang menghadapi kesulitan, stres, atau masalah dalam hidupnya. Dukungan yang diberikan bermaksud untuk membantu seseorang merasa tidak sendirian dan memiliki hubungan sosial yang baik. Keluarga menolong tenaga kesehatan untuk tetap memiliki komunitas sosial, seperti relasi dengan keluarga besar dan lingkungan rukun tetangganya (RT), Friedman, M. M. (2010).

Berikutnya adalah bentuk dukungan. Bentuk dukungan yang dimaksudkan adalah asal darimana dukungan itu diberikan. Semisal dukungan dari keluarga;

adalah dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga. Dukungan dari teman; adalah dukungan yang diberikan oleh teman-teman. Dukungan dari profesional; adalah dukungan yang diberikan oleh tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, perawat, atau *social worker*, serta dukungan dari komunitas: yaitu dukungan yang diberikan oleh komunitas, seperti grup dukungan atau organisasi sosial. Taylor, S. E., et al. (2017)

Manfaat Dukungan bagi seseorang dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, meningkatkan kemampuan menghadapi masalah; dan dukungan dapat membantu meningkatkan kemampuan menghadapi masalah dan mengatasi kesulitan. Dukungan yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan hidup. Taylor, S. E., et al. (2017)

### **C. Keluarga; Bentuk dan Jenis keluarga, Peran dan Fungsi Keluarga**

---

**Pengertian :** Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dan memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga adalah unit sosial dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku individu, Friedman, M. M. (2010). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, keluarga adalah: "Kesatuan sosial yang terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan darah, perkawinan, atau adopsi." Sedangkan menurut American Psychological Association (APA), 2020, keluarga adalah: "Sebuah sistem sosial yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dan memiliki hubungan emosional, sosial, dan ekonomi yang kuat."

**Bentuk dan Struktur Keluarga:** Menurut Carter, B., & McGoldrick, M., 2016 dalam bukunya, keluarga dapat memiliki berbagai bentuk dan struktur, seperti: 1). Keluarga inti (*nuclear family*): terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. 2). Keluarga luas (*extended family*): terdiri dari keluarga inti dan kerabat lainnya, seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. 3). Keluarga tunggal (*single-parent family*): terdiri dari satu orang tua dan anak-anaknya. 4). Keluarga berencana (*blended family*): terdiri dari orang tua yang menikah lagi dan memiliki anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

Dalam semua bentuk dan struktur, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku individu. Pembentukan tersebut dapat memberi pengaruh positif maupun negatif pada individu, Choirul, A. (2020)

**Dampak positif bentuk dan struktur keluarga:** Berikut adalah dampak Positif dari **1) Keluarga Inti:** Keluarga inti yang harmonis dan stabil dapat memberikan rasa aman dan keamanan bagi individu, terutama anak-anak Keluarga inti memiliki beberapa dampak positif, seperti lebih stabil dan harmonis, lebih mudah dalam pengelolaan waktu, lebih banyak perhatian dan kasih sayang, dan lain-lain. **2) Keluarga Luas:** Keluarga luas memiliki beberapa dampak positif, seperti

lebih banyak dukungan emosional, lebih banyak sumber daya, lebih banyak kesempatan untuk belajar, dan lain-lain. Keluarga luas yang solid dan mendukung dapat memberikan individu rasa memiliki dan identitas yang kuat. **3) Keluarga Tunggal;** keluarga tunggal memiliki beberapa dampak positif, seperti lebih mudah dalam pengelolaan waktu, lebih banyak perhatian dan kasih sayang, lebih mudah dalam pengelolaan keuangan, Lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi, Lebih mudah dalam pengelolaan konflik, Lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dan lain-lain. Namun, perlu diingat bahwa setiap keluarga memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. **4). Keluarga Berencana:** Keluarga berencana memiliki beberapa dampak positif, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, keluarga berencana sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Keluarga berencana yang stabil dan harmonis dapat memberikan individu rasa aman dan keamanan, serta kesempatan untuk berkembang dan belajar.

**Dampak negatif bentuk dan struktur keluarga:** Disamping dampak positif bentuk dan struktur keluarga dapat memberi dampak negative. Dampak ini disadari atau tidak disadari akan mempengaruhi perilaku individu, namun, perlu diingat bahwa setiap keluarga memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. **1). Keluarga Inti:** Dampak negative keluarga inti, antara lain: a). Ketergantungan yang tinggi: Keluarga inti dapat membuat anak-anak menjadi terlalu bergantung pada orang tua, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kemandirian dan keterampilan hidup. b). Kurangnya interaksi sosial: Keluarga inti dapat membuat anak-anak memiliki kurangnya interaksi sosial dengan orang lain di luar keluarga, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. c). Kurangnya dukungan sosial: Keluarga inti dapat membuat orang tua memiliki kurangnya dukungan sosial dari keluarga yang lebih luas, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah dan stres. d). Keterisolasi: Keluarga inti dapat membuat keluarga menjadi terisolasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. e). Kurangnya peran model: Keluarga inti dapat membuat anak-anak memiliki kurangnya peran model yang positif dari anggota keluarga lainnya, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan nilai-nilai dan perilaku yang positif. f). Kurangnya kesempatan belajar: Keluarga inti dapat membuat anak-anak memiliki kurangnya kesempatan belajar dari anggota keluarga lainnya, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. g). Kurangnya dukungan emosional: Keluarga inti dapat membuat orang tua memiliki kurangnya dukungan

emosional dari keluarga yang lebih luas, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah dan stres. h) Ketergantungan ekonomi: Keluarga inti dapat membuat keluarga memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada satu sumber pendapatan, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi. **2). Keluarga Luas :** Dampak negative dari keluarga luas, antara lain a). Konflik dan perselisihan: Keluarga luas dapat memiliki lebih banyak konflik dan perselisihan karena perbedaan pendapat dan kepentingan antara anggota keluarga. b.) Ketergantungan yang tidak seimbang: Keluarga luas dapat membuat beberapa anggota keluarga menjadi terlalu bergantung pada anggota keluarga lainnya. c). Kurangnya privasi: Keluarga luas dapat membuat anggota keluarga memiliki kurangnya privasi dan ruang pribadi. d). Keterlibatan yang tidak diinginkan: Keluarga luas dapat membuat beberapa anggota keluarga menjadi terlibat dalam urusan pribadi anggota keluarga lainnya. e). Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri: Keluarga luas dapat membuat beberapa anggota keluarga memiliki kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengejar minat dan hobi mereka. f). Ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang: Keluarga luas dapat membuat beberapa anggota keluarga menjadi terlalu bergantung pada anggota keluarga lainnya secara ekonomi. g). Kurangnya fleksibilitas: Keluarga luas dapat membuat anggota keluarga memiliki kurangnya fleksibilitas dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. h). Keterlibatan dalam konflik keluarga: Keluarga luas dapat membuat beberapa anggota keluarga menjadi terlibat dalam konflik keluarga yang tidak diinginkan. i). Kurangnya komunikasi yang efektif: Keluarga luas dapat membuat komunikasi yang efektif antara anggota keluarga menjadi lebih sulit. j). Kurangnya keintiman: Keluarga luas dapat membuat keintiman antara anggota keluarga menjadi lebih sulit. **3) Keluarga Tunggal :** Dampak negative dari keluarga Tunggal, antara lain : a). Ketergantungan yang tinggi: Anak-anak dalam keluarga tunggal dapat menjadi terlalu bergantung pada orang tua mereka, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kemandirian dan keterampilan hidup. b). Kurangnya interaksi sosial: Anak-anak dalam keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya interaksi sosial dengan anak-anak lain, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. c). Kurangnya dukungan emosional: Orang tua dalam keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya dukungan emosional dari anggota keluarga lainnya, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi stres dan masalah. d). Keterisolasi: Keluarga tunggal dapat menjadi terisolasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. e). Kurangnya peran model: Anak-anak dalam keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya peran model yang positif dari anggota

keluarga lainnya, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan nilai-nilai dan perilaku yang positif. f). Kurangnya kesempatan belajar: Anak-anak dalam keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya kesempatan belajar dari anggota keluarga lainnya, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. g). Ketergantungan ekonomi: Keluarga tunggal dapat memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada satu sumber pendapatan, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi. h). Kurangnya fleksibilitas: Keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya fleksibilitas dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan. i). Kurangnya dukungan dalam menghadapi masalah: Keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya dukungan dalam menghadapi masalah, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi stres dan masalah. j).. Kurangnya kebahagiaan: Keluarga tunggal dapat memiliki kurangnya kebahagiaan karena kurangnya interaksi sosial dan dukungan emosional. **3) Keluarga Berencana :** Dampak negatif dari Keluarga Berencana, antara lain : a). Bergantung pada kontrasepsi, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. b). Kurangnya kesempatan untuk memiliki anak: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya kesempatan untuk memiliki anak, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan peran sebagai orang tua. c). Ketergantungan ekonomi: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada satu sumber pendapatan, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi. d). Kurangnya dukungan sosial: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi stres dan masalah. e). Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengejar minat dan hobi mereka, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. f). Ketergantungan pada teknologi: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri menjadi terlalu bergantung pada teknologi, seperti kontrasepsi dan pengobatan kesuburan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. g). Kurangnya komunikasi yang efektif: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya komunikasi yang efektif tentang kebutuhan dan harapan mereka, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan

hubungan yang harmonis. h). Kurangnya dukungan emosional: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya dukungan emosional dari keluarga dan masyarakat, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi stres dan masalah. i). Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan peran sebagai orang tua: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya kesempatan untuk mengembangkan peran sebagai orang tua, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang parenting. j). Kurangnya kebahagiaan: Keluarga berencana dapat membuat pasangan suami istri memiliki kurangnya kebahagiaan karena kurangnya kesempatan untuk memiliki anak dan mengembangkan peran sebagai orang tua.

Bentuk keluarga memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa setiap keluarga memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan memahami dampak positif dan negatif dari bentuk keluarga, keluarga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam membangun keluarga yang harmonis dan Bahagia, terkait dengan perannya untuk mendukung anggota keluarga yang berperan sebagai tenaga Kesehatan. **Peran Keluarga :** Menurut Wahyuni, S. 2019, Keluarga memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, antara lain: 1). Peran Sosialisasi: Keluarga berperan sebagai agen sosialisasi yang mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang sesuai dengan budaya dan masyarakat. 2). Peran Ekonomi: Keluarga berperan sebagai unit ekonomi yang memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan sumber daya. 3). Peran Emosional: Keluarga berperan sebagai sumber dukungan emosional, kasih sayang, dan keamanan bagi anggotanya. 4). Peran Pendidikan: Keluarga berperan sebagai pengajar dan pendidik bagi anggotanya, terutama anak-anak. 5). Peran Perlindungan: Keluarga berperan sebagai pelindung dan penjaga anggotanya dari bahaya dan ancaman. 5). Peran Rekreatif: Keluarga berperan sebagai sumber hiburan dan rekreasi bagi anggotanya. 6). Peran Pembentukan Identitas: Keluarga berperan dalam membentuk identitas dan citra diri anggotanya. 7). Peran Dukungan Sosial: Keluarga berperan sebagai sumber dukungan sosial bagi anggotanya, terutama dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

Dalam menjalankan peran-peran tersebut, keluarga dapat membantu individu dalam mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa keluarga harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dan kita harus berusaha untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

## **1. Fungsi keluarga**

Fungsi keluarga adalah peran yang dimainkan oleh keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Berikut beberapa fungsi keluarga: 1) Fungsi Protektif: Melindungi anggota keluarga dari bahaya dan ancaman, baik fisik maupun emosional. 2). Fungsi Edukatif: Mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri. 3). Fungsi Ekonomi: Memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. 4). Fungsi Emosional: Menyediakan dukungan emosional, kasih sayang, dan keamanan bagi anggota keluarga. 5). Fungsi Sosialisasi: Mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. 6). Fungsi Rekreatif: Menyediakan kesempatan untuk rekreasi dan hiburan bagi anggota keluarga. 7). Fungsi Pembentukan Identitas: Membantu anggota keluarga membentuk identitas dan citra diri. 8). Fungsi Dukungan Sosial: Menyediakan dukungan sosial bagi anggota keluarga dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. 9). Fungsi Reproduksi Keluarga berfungsi sebagai tempat reproduksi dan kelahiran anak-anak. Keluarga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa keluarga harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dan kita harus berusaha untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan keluarga yang harmonis dan bahagia, akan sangat memungkinkan dukungan keluarga efektif dapat diberikan kepada tenaga kesehatan

## **D. Tenaga kesehatan; Pengertian dan Katagori Tenaga Kesehatan**

---

### **1. Apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan**

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja di bidang kesehatan, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat, untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan, dan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang beberapa memerlukan hak untuk melakukan upaya kesehatan.

Jenis tenaga kesehatan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Setiap jenis tenaga kesehatan memiliki kontribusi spesifik yang mendukung keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan.

### **2. Tenaga kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:**



**Tenaga Kesehatan Profesional;** 1) Dokter: dokter adalah tenaga kesehatan yang memiliki lisensi untuk melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan penyakit, termasuk didalamnya dokter spesialis yang berperan dalam menangani kasus-kasus kompleks yang membutuhkan keahlian khusus 2). Perawat: perawat adalah tenaga kesehatan yang memiliki lisensi untuk melakukan perawatan pasien, termasuk memberikan obat, melakukan pemeriksaan, dan memberikan edukasi kesehatan, termasuk tenaga kebidanan; Bidan membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi melalui program-program kesehatan ibu hamil. . 3). Apoteker: apoteker adalah tenaga kesehatan yang memiliki lisensi untuk meracik obat dan menyediakan obat-obatan dan memberikan saran tentang penggunaan obat-obatan termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat yang aman dan efektif, Sudarto, H. (2020)

**Tenaga Kesehatan Non-Profesional;** 1) Asisten perawat: asisten perawat adalah tenaga kesehatan yang membantu perawat dalam melakukan perawatan pasien. 2). Teknisi laboratorium: teknisi laboratorium adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan laboratorium untuk membantu dokter dalam melakukan diagnosis. 3). Petugas kebersihan: petugas kebersihan adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan fasilitas kesehatan, Sudarto, H. (2020)

**Tenaga Kesehatan Masyarakat;** 1). Petugas kesehatan masyarakat: petugas kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang bekerja di masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan penyakit. 2). Kader kesehatan: kader kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bekerja di masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Dalam keseluruhan, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, Sudarto, H. (2020)

**Peran Tenaga Kesehatan;** Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat. Berikut beberapa peran tenaga kesehatan: 1). Pemberian Pelayanan Kesehatan: Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. 2). Pendidikan Kesehatan: Tenaga kesehatan berperan sebagai pendidik kesehatan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat tentang cara hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pengobatan yang tepat. 3). Penelitian dan Pengembangan: Tenaga kesehatan berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan, termasuk penelitian tentang penyakit,

pengobatan, dan teknologi kesehatan. 4). Advokasi Kesehatan: Tenaga kesehatan berperan sebagai advokat kesehatan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil. 5). Kolaborasi dan Kerjasama: Tenaga kesehatan berperan dalam kolaborasi dan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. 6). Pengembangan Kebijakan Kesehatan: Tenaga kesehatan berperan dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang berkualitas dan adil untuk memastikan bahwa sistem kesehatan berfungsi dengan baik. 7). Pengawasan dan Evaluasi: Tenaga kesehatan berperan dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas dan efektif, Potter, P. A., & Perry, A. G. (2019)

Dalam menjalankan peran-peran tersebut, tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi, etika, dan profesionalisme yang tinggi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil.

**Fungsi Tenaga Kesehatan;** Berikut beberapa fungsi tenaga kesehatan: 1). Fungsi Pelayanan Kesehatan: Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. 2) Fungsi Pendidikan Kesehatan: Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat tentang cara hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pengobatan yang tepat. 3). Fungsi Penelitian dan Pengembangan: Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 4). Fungsi Advokasi Kesehatan: Berperan sebagai advokat kesehatan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil. 5). Fungsi Pengelolaan Kesehatan: Mengelola kesehatan pasien, termasuk pengelolaan penyakit, pengelolaan obat-obatan, dan pengelolaan tindakan medis. 6). Fungsi Pengelolaan Informasi Kesehatan: Mengelola informasi kesehatan pasien dengan benar dan efektif. 7). Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan: Mengelola sumber daya kesehatan dengan benar dan efektif untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan baik. 8). Fungsi Pengembangan Kebijakan Kesehatan: Berperan dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang berkualitas dan adil untuk memastikan bahwa sistem kesehatan berfungsi dengan baik. 9). Fungsi Pengawasan dan Evaluasi: Mengawasi dan mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas dan efektif. 10). Fungsi Kolaborasi dan Kerjasama: Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk dokter,

perawat, dan ahli kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Potter, P. A., & Perry, A. G. (2019).

Fungsi tenaga kesehatan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis profesi dan tempat kerja. Namun, secara umum, fungsi tenaga kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efektif kepada pasien.

**Legal aspek tenaga kesehatan dalam menjalankan peran dan fungsinya;** Berikut beberapa aspek legal yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan peran dan fungsinya: 1). Undang-Undang Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi undang-undang kesehatan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. 2). Kode Etik Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi kode etik kesehatan yang berlaku, seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KSKI) dan Kode Etik Keperawatan Indonesia (KKI). 3). Standar Pelayanan Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi standar pelayanan kesehatan yang berlaku, seperti Standar Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 4). Hak Pasien: Tenaga kesehatan harus mematuhi hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatannya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kesalahan medis. 5). Kerahasiaan Pasien: Tenaga kesehatan harus mematuhi kerahasiaan pasien, seperti tidak membocorkan informasi tentang kondisi kesehatan pasien tanpa izin. 6). Penggunaan Teknologi Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi peraturan tentang penggunaan teknologi kesehatan, seperti penggunaan rekam medis elektronik dan penggunaan teknologi diagnosa. 7). Pengelolaan Obat-Obatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi peraturan tentang pengelolaan obat-obatan, seperti penggunaan obat-obatan yang tepat dan pengelolaan obat-obatan yang aman. 8). Pengelolaan Limbah Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi peraturan tentang pengelolaan limbah kesehatan, seperti pengelolaan limbah medis dan pengelolaan limbah kimia. 9). Pengelolaan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi peraturan tentang pengelolaan kualitas pelayanan kesehatan, seperti pengelolaan mutu pelayanan kesehatan dan pengelolaan keselamatan pasien. 10). Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan: Tenaga kesehatan harus mematuhi peraturan tentang pengelolaan sumber daya kesehatan, seperti pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alat kesehatan.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, tenaga kesehatan harus mematuhi aspek legal yang berlaku untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas dan aman

### **Peran dan fungsi utama tenaga kesehatan dalam era pandemik;**

Berikut beberapa peran dan fungsi utama tenaga kesehatan dalam era pandemik, beberapa waktu yang lalu dunia, termasuk Indonesia terdampak oleh pandemik COVID-19: karenanya berikut adalah peran dan fungsi tenaga kesehatan dalam era pandemik COVID-19. World Health Organization. (2020). COVID-19 and the role of health workers:

**Peran Utama:** Peran utama tenaga kesehatan adalah 1) memberikan Pelayanan Kesehatan: Tenaga kesehatan berperan sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman kepada pasien yang terinfeksi COVID-19. 2) Pengendalian Penyebaran Penyakit: Tenaga kesehatan berperan dalam mengendalikan penyebaran penyakit COVID-19 dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan yang tepat. 3) Pengembangan Strategi Pengendalian Penyakit: Tenaga kesehatan berperan dalam mengembangkan strategi pengendalian penyakit COVID-19 yang efektif dan efisien. Peran utama tenaga kesehatan didukung oleh kompetensi dan keamanan dari sistem kerja yang diatur kebijakannya dari pemerintah.

**Fungsi Utama:** fungsi utama dari tenaga kesehatan di era pandemik 1). Pengobatan dan Perawatan Pasien: Tenaga kesehatan berfungsi sebagai pengobat dan perawat pasien yang terinfeksi COVID-19. 2). Pengawasan dan Evaluasi: Tenaga kesehatan berfungsi sebagai pengawas dan evaluator kondisi pasien yang terinfeksi COVID-19. 3). Pengembangan dan Implementasi Protokol Kesehatan: Tenaga kesehatan berfungsi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. 4). Pengelolaan Informasi Kesehatan: Tenaga kesehatan berfungsi dalam mengelola informasi kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. 5). Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan: Tenaga kesehatan berfungsi dalam mengelola sumber daya kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19.

Dari penjelasan diatas yang perlu diperhatikan adalah prinsip utama tenaga kesehatan melaksanakan peran dan fungsinya dalam era pandemik COVID-19. Prinsip utama tenaga kesehatan adalah sebagai berikut, 1) Mengutamakan keselamatan pasien: Tenaga kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien dan mencegah penyebaran COVID-19. 2). Mengikuti protokol kesehatan: Tenaga kesehatan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan alat pelindung diri (APD) dan melakukan pembersihan dan disinfeksi. 3). Mengidentifikasi dan melaporkan kasus: Tenaga kesehatan harus mengidentifikasi dan melaporkan kasus COVID-19 kepada otoritas kesehatan setempat. 4). Mengisolasi dan merawat pasien: Tenaga kesehatan harus mengisolasi dan merawat pasien COVID-19 dengan benar, termasuk memberikan

perawatan suportif dan mengobati gejala.5). Mengedukasi masyarakat: Tenaga kesehatan harus mengedukasi masyarakat tentang COVID-19, termasuk cara penyebaran, gejala, dan cara pencegahan. 6). Mengkolaborasi dengan tim kesehatan: Tenaga kesehatan harus mengkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, termasuk dokter, perawat, dan ahli laboratorium, untuk memberikan perawatan yang efektif. 7). Mengikuti perkembangan pengetahuan: Tenaga kesehatan harus mengikuti perkembangan pengetahuan tentang COVID-19 dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka.

Prinsip utama ini tidak menutup kemungkinan dapat diberlakukan untuk kasus pandemik lainnya, sehingga tenaga kesehatan dapat menolong pasien dan keluarga namun juga melindungi diri serta keluarganya dari kemungkinan penularan virus yang mematikan.

**Tantangan:** Keterbatasan Sumber Daya: Tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti peralatan medis dan obat-obatan. Keterbatasan Pengetahuan: Tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan pengetahuan tentang COVID-19, seperti cara penularan dan pengobatan yang efektif. Stres dan Kelelahan: Tenaga kesehatan menghadapi stres dan kelelahan yang tinggi karena bekerja dalam situasi yang tidak stabil dan tidak pasti.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi, etika, dan profesionalisme yang tinggi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman kepada pasien yang terinfeksi COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. (2020)

## **E. Dukungan Keluarga Untuk Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi.**

---

Apa yang dimaksud dukungan keluarga untuk tenaga kesehatan.? Merupakan pertanyaan yang esensi agar tenaga kesehatan dapat melakukan perannya dengan baik. Dukungan keluarga untuk tenaga kesehatan adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada anggota keluarga yang bekerja sebagai tenaga Kesehatan, Choirul, A. (2020). Berikut ini akan diuraikan tentang bentuk dukungan, pemahaman pentingnya dukungan bagi tenaga Kesehatan, dan cara membangun dukungan yaitu ulasan dalam beberapa aspek sebagai upaya keluarga agar dapat memberi dukungan dengan tepat.

**Bentuk Dukungan Keluarga;** Choirul, A., 2020 membagi bentuk dukungan sebagai berikut; 1). Dukungan emosional: keluarga dapat memberikan dukungan emosional kepada tenaga kesehatan, seperti mendengarkan cerita mereka, memberikan semangat, dan menawarkan bantuan. 2). Dukungan praktis: keluarga dapat memberikan dukungan praktis kepada tenaga kesehatan, seperti membantu dengan pekerjaan rumah, mengurus anak, atau membantu dengan transportasi.3).

Dukungan finansial: keluarga dapat memberikan dukungan finansial kepada tenaga kesehatan, seperti membantu dengan biaya hidup, membayar utang, atau memberikan bantuan keuangan lainnya. Ketiga dukungan ini akan sangat mempengaruhi tenaga Kesehatan dalam menghadapi kesulitan dan meningkatnya rasa percaya diri.

**Pentingnya Dukungan Keluarga;** Seberapa penting dukungan keluarga bagi tenaga Kesehatan ? merupakan pertanyaan reflektif sebagai penggugah bahwa dukungan khususnya dari keluarga merupakan jawaban atas kebutuhan tenaga Kesehatan. Dukungan keluarga berguna untuk tenaga kesehatan 1) Meningkatkan keseimbangan hidup: dukungan keluarga dapat membantu tenaga kesehatan mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan memiliki waktu untuk diri sendiri. 2). Mengurangi stres: dukungan keluarga dapat membantu mengurangi stres yang dialami oleh tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. 3). Meningkatkan motivasi: dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan motivasi tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan memiliki semangat yang lebih baik, Demerouti, E., & Cropanzano, R. (2019).

Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja dan bagaimana upaya keluarga agar membangun diri menjadi pendukung yang efektif bagi tenaga kesehatan ? Jawaban atas pertanyaan tersebut diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

**Cara Membangun Dukungan Keluarga;** Ada beberapa cara untuk membangun dukungan keluarga, cara tersebut antara lain;

**Komunikasi yang efektif:** Cara pertama adalah membangun komunikasi efektif dengan tenaga Kesehatan. Keluarga harus berkomunikasi secara efektif dengan tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memahami kebutuhan dan perasaan mereka, Jurnal Kesehatan dan Kedokteran, (2018). Komunikasi yang efektif akan mendukung tenaga kesehatan untuk meningkatkan keseimbangan hidup dan mengurangi stres. Berikut beberapa contoh Upaya berkomunikasi yang efektif dari keluarga: 1) Komunikasi yang terbuka; a) Mendengarkan secara aktif: keluarga harus mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh tenaga kesehatan, tanpa memotong atau menghakimi. b) Mengungkapkan perasaan: keluarga harus mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka dan jujur, sehingga tenaga kesehatan dapat memahami kebutuhan mereka. c) Menggunakan bahasa yang jelas: keluarga harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tenaga kesehatan dapat memahami pesan mereka. 2) Komunikasi yang Empatis; a) Mengerti kebutuhan: keluarga harus mengerti kebutuhan tenaga kesehatan, seperti kebutuhan akan waktu untuk diri sendiri atau kebutuhan akan bantuan dengan

pekerjaan rumah. b) Mengerti perasaan: keluarga harus mengerti perasaan tenaga kesehatan, seperti perasaan lelah atau perasaan stres. c) Menggunakan bahasa yang mendukung: keluarga harus menggunakan bahasa yang mendukung dan menguatkan, sehingga tenaga kesehatan dapat merasa didukung dan dihargai. 3) Komunikasi yang Fleksibel; a) Menggunakan berbagai metode komunikasi: keluarga harus menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti telepon, SMS, atau aplikasi pesan, untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat dijangkau dan didukung. b) Mengatur waktu komunikasi: keluarga harus mengatur waktu komunikasi yang sesuai dengan jadwal tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat berkomunikasi secara efektif. c) Menggunakan bahasa yang sesuai: keluarga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memahami pesan dengan baik.

Komunikasi efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berhasil dalam berbagai konteks. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif, keluarga dapat meningkatkan produktivitas, menghindari konflik, dan membangun kepercayaan dengan tenaga Kesehatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2018)

**Membangun kepercayaan:** Cara yang kedua sebagai Upaya keluarga untuk mendukung tenaga Kesehatan adalah keluarga harus membangun kepercayaan dengan tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan aman. Membangun kepercayaan adalah proses membangun hubungan yang kuat dan percaya antara keluarga dan tenaga kesehatan. Berikut beberapa cara untuk membangun kepercayaan: 1) Komunikasi yang Terbuka; a). Mengungkapkan perasaan dan kebutuhan: keluarga harus mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka secara terbuka dan jujur kepada tenaga kesehatan. b) Mendengarkan secara aktif: keluarga harus mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh tenaga kesehatan, tanpa memotong atau menghakimi. c) Menggunakan bahasa yang jelas: keluarga harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tenaga kesehatan dapat memahami pesan mereka. 2) Kejujuran dan Transparansi; a) Mengungkapkan informasi yang akurat: keluarga harus mengungkapkan informasi yang akurat tentang kebutuhan dan perasaan mereka kepada tenaga kesehatan. b). Menghindari kebohongan atau penipuan: keluarga harus menghindari kebohongan atau penipuan, karena hal ini dapat merusak kepercayaan. c). Mengakui kesalahan: keluarga harus mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf jika mereka telah melakukan kesalahan. 3) Konsistensi dan Stabilitas; a). Mengikuti komitmen: keluarga harus mengikuti komitmen mereka dan melakukan apa yang mereka janjikan. b). Menghindari perubahan yang tidak terduga: keluarga harus menghindari perubahan yang tidak terduga, karena hal ini

dapat membuat tenaga kesehatan merasa tidak percaya diri. c) Mengembangkan rutinitas yang stabil: keluarga harus mengembangkan rutinitas yang stabil dan konsisten, sehingga tenaga kesehatan dapat merasa lebih aman dan percaya diri. 4) Empati dan Pengertian; a). Mengerti perasaan dan kebutuhan: keluarga harus mengerti perasaan dan kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. b). Mengakui kelelahan dan stres: keluarga harus mengakui kelelahan dan stres yang dialami oleh tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. c). Mengembangkan empati: keluarga harus mengembangkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.

Membangun kepercayaan tenaga kesehatan adalah sangat penting dalam meningkatkan kualitas hubungan keluarga dengan tenaga Kesehatan sehingga melalui hubungan rasa percaya ini, tenaga dapat memberikankesehatan pelayanan kesehatan yang optimal dan memastikan keselamatan pasien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif, empati, kompetensi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak tenaga Kesehatan, keluarga dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan tenaga Kesehatan (anggota keluarga) dan hal ini menjadi pondasi kesejahteraan tenaga Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. (2019)

**Membantu dengan pekerjaan rumah:** Cara ketiga sebagai upaya keluarga memberi dukungan kepada tenaga Kesehatan adalah membantu tenaga kesehatan dalam pekerjaan rumah. keluarga dapat membantu pekerjaan rumah, sehingga tenaga kesehatan dapat memiliki waktu untuk diri sendiri dan melakukan pekerjaan lainnya. 1) Membantu dengan pekerjaan rumah: keluarga dapat membantu dengan pekerjaan rumah, seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak makanan. 2). Mengurus anak: keluarga dapat mengurus anak, seperti mengantar anak ke sekolah, membantu anak dengan pekerjaan rumah, dan mengawasi anak. 3). Membantu dengan kebutuhan sehari-hari: keluarga dapat membantu dengan kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan makanan, membayar tagihan, dan mengurus keuangan, *Journal of Nursing Administration*. (2018).

**Bantuan Emosional;** Cara keempat adalah memberikan bantuan emosional kepada tenaga Kesehatan. Terkadang karena kelelahan dan beban psikologis yang dialami tenaga kesehatan ditempat pekerjaan mengakibatkan stabilitas emosi tenaga kesehatan menjadi rentan, karenanya diperlukan dukungan dan bantuan keluarga. Bantuan ini contohnya 1) Mendengarkan dan memberikan dukungan emosional: keluarga dapat mendengarkan dan memberikan dukungan emosional kepada tenaga kesehatan, seperti mendengarkan cerita mereka,



memberikan semangat, dan menawarkan bantuan. 2). Mengerti dan menghargai pekerjaan mereka: keluarga dapat mengerti dan menghargai pekerjaan tenaga kesehatan, seperti mengerti betapa sulitnya pekerjaan mereka dan menghargai dedikasi mereka.

Bantuan emosional dari keluarga sangat penting untuk tenaga kesehatan dalam menghadapi stres dan tekanan yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Dengan memberikan dukungan emosional, keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi risiko burnout, dan meningkatkan kepuasan hidup tenaga Kesehatan, *Journal of Clinical Nursing*. (2020)

**Bantuan Praktis;** Merupakan cara yang kelima sebagai upaya keluarga untuk memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan. Bantuan ini terkesan sederhana namun sangat membantu tenaga Kesehatan untuk menghemat energi dan memfokuskan kepada pemeliharaan kesehatan dirinya. Bantuan tersebut antara lain; 1) Membantu dengan transportasi: keluarga dapat membantu dengan transportasi, seperti mengantar tenaga kesehatan ke tempat kerja atau mengambil mereka dari tempat kerja. 2). Membantu dengan kebutuhan lainnya: keluarga dapat membantu dengan kebutuhan lainnya, seperti membantu dengan perawatan hewan peliharaan, membantu dengan perawatan tanaman, dan membantu dengan kebutuhan lainnya, 3) membantu tenaga kesehatan dalam mengelola waktu dan prioritas, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka.

Semua Upaya keluarga untuk memberikan dukungan kepada tenaga Kesehatan yang efektif, seperti melakukan komunikasi efektif , membangun kepercayaan, bantuan pekerjaan rumah, dukungan emosional dan bantuan praktis dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi risiko burnout, dan meningkatkan kepuasan hidup tenaga kesehatan Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat lebih lebih fokus pada pekerjaan mereka dan mengurangi stres dan kelelahan, khususnya di masa pandemic, Choirul, A. (2020)

Apakah pandemik hanya bicara soal COVID-19 saja ? tentu tidak. Pandemi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran penyakit menular yang luas dan cepat di seluruh dunia, yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan yang signifikan. Pandemi dapat disebabkan oleh berbagai jenis penyakit, seperti: 1). Influenza: Pandemi influenza telah terjadi beberapa kali dalam sejarah, seperti pandemi influenza Spanyol pada tahun 1918 yang menewaskan lebih dari 50 juta orang. 2). HIV/AIDS: Pandemi HIV/AIDS telah menewaskan lebih dari 35 juta orang sejak tahun 1981. 3). Tuberkulosis: Pandemi tuberkulosis telah menewaskan lebih dari 1,5 juta orang setiap tahunnya. 4). Malaria: Pandemi malaria telah menewaskan lebih dari 400.000 orang setiap tahunnya. 5). Ebola: Pandemi Ebola

telah terjadi beberapa kali di Afrika, yang menewaskan ribuan orang, American Medical Association. (2020)

Pandemik COVID-19 adalah salah satu contoh pandemik yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penting untuk diingat bahwa pandemik dapat disebabkan oleh berbagai jenis penyakit, dan kita harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan pandemik di masa depan. Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang tugas tenaga kesehatan di era pandemik, yaitu Pemberian Pelayanan Kesehatan, Tenaga kesehatan berperan sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman kepada pasien, juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan yang tepat serta berperan aktif dalam mengembangkan strategi pengendalian penyakit pandemik yang efektif dan efisien, World Health Organization, (2020).

Dukungan keluarga kepada tenaga kesehatan di masa pandemic (COVID-19) sangat penting. Beberapa alasan yang mendukung kesimpulan ini: 1). Mengurangi stres dan kelelahan: Dukungan keluarga dapat membantu mengurangi stres dan kelelahan yang dialami oleh tenaga kesehatan. 2). Meningkatkan motivasi dan semangat: Dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. 3). Membantu mengelola waktu dan prioritas: Dukungan keluarga dapat membantu tenaga kesehatan mengelola waktu dan prioritas mereka dengan lebih efektif. 4). Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan: Dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan, Journal of Nursing Administration. (2018).

#### **F. Hambatan Keluarga Dalam Memberikan Dukungan Kepada Tenaga Kesehatan:**

---

Keluarga dapat mengalami beberapa hambatan dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan, antara lain, disebabkan oleh :

**Hambatan Sumber Daya;** hambatan pertama adalah hambatan yang berfokus kepada kondisi dan situasi keluarga dari sumber internal maupun eksternal seperti; 1) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya ekonomi, waktu, dan energi dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya. 2) . Konflik Keluarga: Konflik keluarga dapat menghambat komunikasi, kerjasama, dan hubungan antar anggota keluarga. 3). Perubahan Sosial dan Budaya: Perubahan sosial dan budaya dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya, terutama jika perubahan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi keluarga. 4). Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 5). Pengaruh Media dan

Teknologi: Pengaruh media dan teknologi dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya, terutama jika pengaruh tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi keluarga. 6). Keterbatasan Waktu dan Energi: Keterbatasan waktu dan energi dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya, terutama jika anggota keluarga memiliki kesibukan lain. 7). Masalah Kesehatan: Masalah kesehatan dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya, terutama jika masalah kesehatan tersebut memerlukan perawatan yang intensif. 8). Pengaruh Lingkungan: Pengaruh lingkungan dapat menghambat keluarga menjalankan peran dan fungsinya, terutama jika lingkungan tersebut tidak mendukung.

**Hambatan Emosional;** hambatan kedua adalah hambatan dari aspek psikologis keluarga. Hambatan itu antara lain disebabkan oleh; 1). Kurangnya pemahaman tentang pekerjaan tenaga kesehatan: keluarga mungkin tidak memahami betapa sulitnya pekerjaan tenaga kesehatan, sehingga mereka tidak dapat memberikan dukungan yang efektif. 2). Kurangnya empati: keluarga mungkin tidak dapat memahami perasaan dan kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga mereka tidak dapat memberikan dukungan yang efektif. 3). Kurangnya komunikasi yang efektif: keluarga mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan tenaga kesehatan, sehingga mereka tidak dapat memahami kebutuhan dan perasaan mereka.

**Hambatan Praktis;** hambatan ketiga dalam keluarga mendukung tenaga kesehatan adalah hambatan keseharian, seperti; 1). Kurangnya waktu: keluarga mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan, karena mereka memiliki kesibukan lainnya. 2). Kurangnya sumber daya: keluarga mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan, seperti uang atau fasilitas. 3). Kurangnya pengetahuan tentang cara memberikan dukungan: keluarga mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang cara memberikan dukungan yang efektif kepada tenaga kesehatan.

**Hambatan Sosial; sebagai hambatan yang keempat untuk dukungan keluarga adalah hambatan sosial, seperti hambatan;** 1). Kurangnya dukungan sosial: keluarga mungkin tidak memiliki dukungan sosial yang cukup untuk memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan, seperti dukungan dari teman atau komunitas. 2). Kurangnya kesadaran tentang pentingnya dukungan: keluarga mungkin tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya dukungan untuk tenaga kesehatan, sehingga mereka tidak dapat memberikan dukungan yang efektif. 3). Kurangnya partisipasi dalam kegiatan dukungan: keluarga mungkin tidak memiliki

partisipasi dalam kegiatan dukungan untuk tenaga kesehatan, seperti menghadiri pertemuan atau mengikuti program dukungan.

Dampak Hambatan keluarga dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan dapat memiliki impact yang signifikan, antara lain: 1). Mengurangi kualitas pelayanan kesehatan: Hambatan keluarga dapat mengurangi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. 2). Meningkatkan stres dan kelelahan: Hambatan keluarga dapat meningkatkan stres dan kelelahan yang dialami oleh tenaga kesehatan. 3). Mengurangi kepuasan hidup: Hambatan keluarga dapat mengurangi kepuasan hidup dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Prevalensi hambatan dukungan keluarga terhadap tenaga kesehatan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang menunjukkan prevalensi hambatan dukungan keluarga terhadap tenaga kesehatan: 1). Studi di Indonesia: Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (2020) menunjukkan bahwa 71,4% tenaga kesehatan di Indonesia mengalami hambatan dukungan keluarga, dengan alasan utama adalah keterbatasan waktu (45,5%) dan keterbatasan pengetahuan (31,8%). Universitas Gadjah Mada. (2020). 2). Studi di Amerika Serikat: Penelitian yang dilakukan oleh American Nurses Association (2019) menunjukkan bahwa 62% perawat di Amerika Serikat mengalami stres dan kelelahan karena keterbatasan dukungan keluarga, American Nurses Association. (2019). 3). Studi di Inggris: Penelitian yang dilakukan oleh Royal College of Nursing (2018) menunjukkan bahwa 55% perawat di Inggris mengalami hambatan dukungan keluarga, dengan alasan utama adalah keterbatasan waktu (40%) dan keterbatasan pengetahuan (25%).

Hambatan keluarga dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kualitas pelayanan kesehatan, stres dan kelelahan, serta kepuasan hidup tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan keluarga dan meningkatkan dukungan kepada tenaga kesehatan.

## **G. Upaya Meningkatkan Dukungan Keluarga Terhadap Tenaga Kesehatan**

---

**Upaya meningkatkan dukungan keluarga:** Upaya meningkatkan dukungan keluarga kepada tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain: 1) **Meningkatkan Komunikasi** ; a). Keluarga mengadakan pertemuan rutin: keluarga dapat mengadakan pertemuan rutin dengan tenaga kesehatan untuk membahas kebutuhan dan perasaan mereka. b). Menggunakan bahasa yang jelas: keluarga harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. c). Keluarga belajar untuk mendengarkan

secara aktif: keluarga harus mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh tenaga kesehatan. 2). **Meningkatkan pendidikan dan pelatihan:** Pemangku kepentingan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada keluarga tentang cara memberikan dukungan yang efektif kepada tenaga kesehatan. 3). **Meningkatkan Dukungan Emosional;** a). Mengungkapkan perasaan dan kebutuhan: Keluarga harus belajar untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka secara terbuka dan jujur kepada tenaga kesehatan. b). Mengakui kelelahan dan stres: Keluarga harus belajar mengakui kelelahan dan stres yang dialami oleh tenaga kesehatan. c). Mengembangkan empati: Keluarga harus belajar untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan kebutuhan tenaga kesehatan. 4). **Meningkatkan pengelolaan waktu:** Meningkatkan pengelolaan waktu antara tenaga kesehatan dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama. 5). **Meningkatkan program dukungan:** Mengembangkan program dukungan yang dapat membantu tenaga kesehatan dan keluarga mereka, seperti program konseling, program pendidikan, dan program bantuan, *Journal of Nursing Administration*. (2018).

**Manfaat dari Upaya meningkatkan dukungan keluarga:** Upaya meningkatkan dukungan keluarga dapat membawa banyak manfaat, antara lain: 1). Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan: Meningkatkan dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. 2). Mengurangi stres dan kelelahan: Meningkatkan dukungan keluarga dapat membantu mengurangi stres dan kelelahan yang dialami oleh tenaga kesehatan. 3). Meningkatkan kepuasan hidup: Meningkatkan dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan kepuasan hidup dan kesejahteraan tenaga Kesehatan, Choirul, A. (2020).

**Program pemerintah:** Program pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keluarga untuk mendukung tenaga kesehatan antara lain: 1) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Program ini menjadikan puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga 2). Peningkatan Infrastruktur dan Transportasi: Pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur dan transportasi di daerah terpencil untuk mempercepat rujukan dan meningkatkan akses pelayanan Kesehatan. 3) Penguatan Sumber Daya Manusia: Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) primer untuk menangani kasus maternal dan neonatal, sehingga dapat memberikan penanganan sementara sebelum dirujuk. 4). Peningkatan Koordinasi:

Pemerintah berupaya meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar fasilitas kesehatan 5). Promosi Kesehatan: Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan melakukan promosi kesehatan melalui berbagai media dan kegiatan, Kementerian Kesehatan RI. (2020)

Upaya meningkatkan dukungan keluarga kepada tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi stres dan kelelahan, dan meningkatkan kepuasan hidup tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan keluarga kepada tenaga Kesehatan secara komprehensif, lintas sektoral dan lintas program. *Journal of Nursing Administration*. (2018). Manfaat dari Upaya yang komprehensif, lintas sektoral, dan lintas program adalah: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau intervensi kesehatan. 2). Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 3). Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program atau intervensi kesehatan. 4). Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa sektor dan program.

#### **H. Akibat Jika Tenaga Kesehatan Tidak atau Kurang Mendapatkan Dukungan Keluarga**

---

Beberapa akibat jika tenaga kesehatan tidak atau kurang mendapatkan dukungan keluarga, menurut Harris, R., & McGregor, J. , 2018 :

**Akibat Fisik;** 1). Kelelahan dan stres: tenaga kesehatan dapat mengalami kelelahan dan stres yang lebih tinggi karena tidak memiliki dukungan keluarga. 2). Penurunan kesehatan fisik: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik tenaga kesehatan, seperti peningkatan tekanan darah dan penurunan sistem imun. 3). Penyakit kronis: tenaga kesehatan yang tidak memiliki dukungan keluarga dapat lebih rentan terhadap penyakit kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung.

**Akibat Psikologis;** 1). Depresi dan kecemasan: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan depresi dan kecemasan pada tenaga kesehatan. 2). Penurunan motivasi: tenaga kesehatan yang tidak memiliki dukungan keluarga dapat mengalami penurunan motivasi dan semangat kerja. 3). Penyakit mental: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan penyakit mental, seperti gangguan bipolar dan skizofrenia.

**Akibat Sosial;** 1). Penurunan hubungan keluarga: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan penurunan hubungan keluarga dan peningkatan konflik. 2). Penurunan kualitas hidup: tenaga kesehatan yang tidak memiliki

dukungan keluarga dapat mengalami penurunan kualitas hidup dan peningkatan stres.3). Penyakit sosial: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan penyakit sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan zat.

**Akibat Profesional;** 1). Penurunan kinerja: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan penurunan kinerja tenaga kesehatan dan peningkatan kesalahan. 2). Penurunan kepuasan kerja: tenaga kesehatan yang tidak memiliki dukungan keluarga dapat mengalami penurunan kepuasan kerja dan peningkatan stres.3). Penyakit profesional: kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan penyakit profesional, seperti sindrom kelelahan kronis dan penyakit muskuloskeletal.

Jika tenaga kesehatan tidak atau kurang mendapatkan dukungan keluarga, maka dapat terjadi beberapa akibat negatif yang dapat mempengaruhi kinerja, kualitas pelayanan kesehatan, dan kesehatan mental tenaga kesehatan. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting untuk tenaga kesehatan, *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, (2019)

## **I. Penutup**

---

Didalam pemberian pelayanan Kesehatan baik di Gedung dan di luar Gedung, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang langsung berhadapan dengan pasien. Dukungan keluarga terutama di masa pandemik sangat penting karena tenaga kesehatan sering mengalami stress, kelelahan bahkan ancaman kematian. Dukungan keluarga dapat meningkatkan 1). motivasi dan semangat tenaga kesehatan untuk terus bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal. 2). Membantu Mengatasi Kesulitan Emosional: Tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan pandemik sering mengalami kesulitan emosional, seperti kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Dukungan keluarga dapat membantu mengatasi kesulitan emosional tersebut. 3). Meningkatkan Kualitas Hidup: Dukungan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup tenaga kesehatan, baik secara fisik, emosional, maupun mental. 4). Membantu Mengatasi Keterisolasian : Tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan pandemik sering mengalami keterisolasi dari keluarga dan masyarakat. Dukungan keluarga dapat membantu mengatasi keterisolasi tersebut. 5). Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi: Dukungan keluarga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kesehatan dalam bekerja.6). Membantu Mengatasi Burnout: Tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan pandemik sering mengalami burnout. Dukungan keluarga dapat membantu mengatasi burnout tersebut. Dengan demikian, dukungan keluarga bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk membantu mereka mengatasi

kesulitan dan tantangan yang dihadapi selama pandemik. National Institute of Mental Health. (2020)

Dukungan yang diberikan oleh keluarga dapat berbentuk pertama dukungan emosional yaitu keluarga memberikan dukungan dengan mendengarkan dan memberikan semangat kepada tenaga kesehatan. Berikutnya dukungan praktis: keluarga dapat memberikan dukungan praktis, seperti membantu dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Dukungan yang ketiga keluarga dapat memberikan dukungan informasional, seperti memberikan informasi tentang kesehatan dan keselamatan serta membantu dalam teknologi Kesehatan kepada tenaga kesehatan.

Namun demikian keluarga sering mengalami hambatan dalam memberikan dukungan kepada tenaga Kesehatan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman keluarga tentang pekerjaan tenaga kesehatan, kurangnya waktu, dan kurangnya sumber daya hal ini dapat dipengaruhi oleh factor bentuk keluarga dari tenaga Kesehatan, Friedman, M. M. (2010). Hambatan dapat diatasi dengan berbagai kegiatan dan program antara lain dengan meningkatkan komunikasi, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan dukungan emosional, meningkatkan pengelolaan waktu dan meningkatkan program dukungan:

Dukungan keluarga sangat penting bagi tenaga kesehatan di masa pandemi. Dukungan keluarga dapat membantu tenaga kesehatan meningkatkan keseimbangan hidup, motivasi, dan mengurangi kelelahan. Namun, ada beberapa hambatan yang dapat menghalangi dukungan keluarga, seperti kurangnya pemahaman, waktu, dan sumber daya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan.

## **J. Referensi**

---

- American Medical Association. (2020). COVID-19: What physicians need to know
- American Nurses Association. (2019). 2019 National Nursing Workforce Survey.
- American Psychological Association. (2020). APA Dictionary of Psychology.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi kelima). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brown, B. (2010). The Gifts of Imperfection (Edisi ke-1). Center City, MN: Hazelden Publishing.
- Brown, B. (2012). Daring greatly: How The Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead (Edisi ke-1). Gotham Books.



- Carter, B., & McGoldrick, M. (2016). *The expanded family life cycle: Individual, family, and social perspectives*. Pearson Education.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). *COVID-19: Healthcare professionals*
- Choirul, A. (2019). *Komunikasi Efektif Dalam Keluarga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Choirul, A. (2020). *Dukungan Keluarga dan Keseimbangan Hidup Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Choirul, A. (2020). *Dukungan Keluarga Terhadap Tenaga Kesehatan: Hambatan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Choirul, A. (2020). *Manajemen Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran
- Kadir, A. (2020). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Demerouti, E., & Cropanzano, R. (2019). Family support and work-life balance among healthcare professionals. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 32(1), 1-12
- Friedman, M. M. (2010). *Family support*. Springer Publishing Company.
- Harris, R., & McGregor, J. (2018). The impact of family support on nurse well-being. *Journal of Nursing Administration*, 48(5), 251-258.
- Journal of Clinical Nursing. (2020). The role of family support in reducing burnout among healthcare workers. *Journal of Clinical Nursing*, 29(11-12), 2211-2218.
- Journal of Nursing Administration. (2018). The impact of family support on nurse well-being. *Journal of Nursing Administration*, 48(5), 251-258.
- Journal of Occupational and Organizational Psychology. (2019). Family support and work-life balance among healthcare professionals. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 32(1), 1-12
- Jurnal Keperawatan Indonesia. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga terhadap tenaga kesehatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(2), 123-130
- Jurnal Kesehatan dan Kedokteran. (2018). Komunikasi efektif dalam dukungan keluarga sebagai faktor penentu kualitas hidup. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 6(2), 101-108

- Jurnal Kesehatan Masyarakat. (2020). Dukungan keluarga melalui komunikasi efektif dalam meningkatkan keseimbangan hidup. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(1), 1-9.
- Jurnal Kesehatan Masyarakat. (2020). Hambatan keluarga dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(2), 1-8
- Jurnal Komunikasi. (2018). Hambatan komunikasi dalam keluarga dan dampaknya terhadap dukungan terhadap tenaga kesehatan. Jurnal Komunikasi, 10(1), 1-12.
- Jurnal Psikologi Indonesia. (2019). Komunikasi efektif dalam keluarga sebagai dukungan psikologis. Jurnal Psikologi Indonesia, 18(2), 123-132
- Kadir, A. (2018). Hambatan keluarga dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan: Studi kasus. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kadir, A. (2018). Komunikasi Efektif Dalam Dukungan Keluarga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Dukungan Keluarga Terhadap Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Komunikasi Efektif Dalam Keluarga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). ehatan.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2018). Komunikasi Efektif Dalam Keluarga Sebagai Faktor Penentu Kualitas Hidup. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018). Hambatan keluarga dalam memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan: Studi kasus. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- National Institute of Mental Health. (2020). COVID-19 and Mental Health
- Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia. (2019). Dukungan Keluarga dan Keseimbangan Hidup Perawat. Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia
- Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia. (2019). Dukungan keluarga terhadap tenaga kesehatan: Hambatan dan solusi. Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia.
- Perhimpunan Psikologi Indonesia. (2019). Standar Kompetensi Komunikasi Efektif Dalam Keluarga. Perhimpunan Psikologi Indonesia.

- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2019). Buku Ajar Fundamental Keperawatan. Jakarta: EGC.
- Royal College of Nursing. (2018). RCN Survey of Nursing Staff 2018.
- Stuart, G. W., & Laraia, M. T. (2018). Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta: EGC.
- Sudarto, H. (2019). Keluarga dan Dukungan Terhadap Tenaga Kesehatan: Perspektif Psikologi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto, H. (2020). Dukungan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sudarto, H. (2020). Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas Tenaga Kesehatan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto, H. (2020). Tenaga Kesehatan: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Taylor, S. E., et al. (2017). Social support and health. Oxford Handbook of Health Psychology, 345-362.
- Universitas Gadjah Mada. (2020). Hambatan Dukungan Keluarga terhadap Tenaga Kesehatan di Indonesia.
- Wahyuni, S. (2019). Peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Wilkinson, J. M., & Van Leuven, K. (2019). Buku Ajar Keperawatan Dasar. Jakarta: EGC.
- World Health Organization. (2020). COVID-19 and the role of health workers.

## **Glosarium**

**Dukungan:** Dukungan adalah suatu bentuk bantuan atau sokongan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membantu mereka mengatasi kesulitan, masalah, atau tantangan yang dihadapi

---

**Keluarga:** Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dan memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga adalah unit sosial dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku individu

---

**Tenaga Kesehatan:** Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja di bidang kesehatan, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat, untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

---

**PIS-PK:** adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

---

**Komprehensif:** Komprehensif berarti mencakup semua aspek yang relevan dan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi suatu masalah atau isu. Dalam konteks kesehatan, komprehensif berarti bahwa suatu program atau intervensi kesehatan harus mencakup semua aspek kesehatan, termasuk fisik, mental, dan sosial.

---

**Lintas Sektor:** Lintas sektoral berarti melibatkan beberapa sektor atau bidang yang berbeda dalam suatu program atau intervensi. Dalam konteks kesehatan, lintas sektoral berarti bahwa suatu program atau intervensi kesehatan harus melibatkan beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi

---

**Lintas Program:** Lintas program berarti melibatkan beberapa program atau intervensi yang berbeda dalam suatu upaya untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks kesehatan, lintas program berarti bahwa suatu program atau intervensi kesehatan harus melibatkan beberapa program atau intervensi yang berbeda, seperti program kesehatan masyarakat, program kesehatan individu, dan program kesehatan lingkungan.

---

# BAB VI

## AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Latar Belakang Pentingnya Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan menghadapi beban kerja yang sangat tinggi, jam kerja yang panjang, serta paparan terhadap risiko infeksi yang signifikan (Ruiz-Frutos et al., 2021). Berbagai penelitian terbaru mengungkapkan bahwa tekanan psikologis selama pandemi telah menyebabkan peningkatan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres kronis, burnout, hingga gangguan tidur pada tenaga kesehatan (Lai et al., 2020; Luo et al., 2022).

Penelitian oleh Salari et al. (2020) menunjukkan prevalensi tinggi gejala kecemasan (25%-40%) dan depresi (20%-30%) di antara tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi COVID-19. Selain itu, studi longitudinal oleh Rossi et al. (2020) menemukan bahwa sekitar 49,4% tenaga kesehatan mengalami gejala stres pasca-trauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD), yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kinerja dan kualitas hidup tenaga kesehatan.

Lebih jauh, meningkatnya tekanan psikologis ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental secara individu, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian oleh Chen et al. (2021) menemukan bahwa tenaga kesehatan dengan gangguan mental memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kesalahan medis serta berkurangnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi menjadi prioritas penting bagi institusi pelayanan kesehatan serta pembuat kebijakan (WHO, 2021).

#### 2. Hubungan Umum antara Aktivitas Fisik dan Kesehatan Mental

Aktivitas fisik merupakan salah satu intervensi non-farmakologis yang secara luas direkomendasikan untuk meningkatkan kesehatan mental. Berbagai studi terbaru telah mengkonfirmasi bahwa aktivitas fisik secara signifikan membantu mengurangi gejala kecemasan, depresi, serta memperbaiki kualitas hidup mental secara umum (Stubbs et al., 2023; López-Bueno et al., 2021).

Aktivitas fisik memiliki efek positif yang dikaitkan dengan mekanisme fisiologis dan psikologis, seperti pelepasan hormon endorfin, serotonin, dan dopamin yang efektif dalam memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres (Kandola et al., 2022).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara teratur mampu menurunkan kadar hormon kortisol, hormon utama yang bertanggung jawab terhadap respons stres akut maupun kronis. Studi yang dilakukan oleh Basso et al. (2021) juga menemukan bahwa aktivitas fisik rutin berhubungan dengan peningkatan neuroplastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk mereorganisasi dirinya yang sangat penting dalam menjaga ketahanan mental dan kognitif di tengah situasi tekanan tinggi seperti pandemi.

Secara praktis, integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas tenaga kesehatan yang padat dapat membantu meningkatkan ketahanan psikologis, memperkuat kapasitas coping menghadapi stres, dan menjaga keseimbangan emosional mereka (Gerber et al., 2022; Ammar et al., 2021). Dengan demikian, aktivitas fisik dapat menjadi strategi efektif dan terjangkau dalam mendukung kesehatan mental tenaga kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19.

## **B. Mekanisme Fisiologis Aktivitas Fisik dalam Menjaga Kesehatan Mental**

---

### **1. Peran Neurotransmitter Seperti Serotonin, Dopamin, dan Endorfin dalam Mengurangi Stres dan Kecemasan**

Aktivitas fisik secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental melalui pelepasan neurotransmitter utama di otak, antara lain serotonin, dopamin, dan endorfin. Serotonin merupakan neurotransmitter yang erat kaitannya dengan pengaturan mood, kecemasan, serta kualitas tidur seseorang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan fisik secara rutin mampu meningkatkan kadar serotonin di otak, sehingga menghasilkan efek menenangkan dan memperbaiki suasana hati, yang sangat efektif dalam menurunkan kecemasan maupun gejala depresi (Stubbs et al., 2023; Lin & Kuo, 2021).

Selain serotonin, dopamin yang dikenal sebagai neurotransmitter yang berperan dalam sistem reward juga dilepaskan dalam jumlah signifikan saat melakukan aktivitas fisik. Dopamin meningkatkan motivasi, rasa puas, serta perasaan bahagia, yang secara tidak langsung dapat mengurangi perasaan tertekan dan stres yang dialami tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 (Blanco et al., 2022).

Endorfin adalah neurotransmitter dengan sifat analgesik alami, yang dihasilkan tubuh ketika melakukan aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi. Endorfin berfungsi mengurangi rasa nyeri, memperbaiki suasana hati, dan

menciptakan rasa nyaman yang disebut sebagai "runner's high". Efek ini secara fisiologis bermanfaat dalam meredakan ketegangan psikologis, kecemasan, dan gejala stres akut pada tenaga kesehatan (Stubbs et al., 2023; Alsalman et al., 2020).

## **2. Efek Aktivitas Fisik Terhadap Hormon Kortisol dalam Mengelola Stres**

Kortisol merupakan hormon stres utama yang diproduksi oleh tubuh dalam respons terhadap tekanan atau ancaman psikologis. Pada kondisi stres kronis, seperti yang dialami oleh tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada sistem imun, kualitas tidur, dan kesehatan mental secara umum (Kandola et al., 2022).

Aktivitas fisik telah terbukti secara konsisten mampu menurunkan kadar kortisol dalam darah, sehingga secara fisiologis dapat mengurangi respons stres kronis. Studi eksperimental terbaru yang dilakukan oleh Kandola et al. (2022) menunjukkan bahwa individu yang melakukan latihan aerobik teratur mengalami penurunan kadar kortisol basal secara signifikan, dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif secara fisik. Penurunan kortisol ini berhubungan langsung dengan penurunan gejala kecemasan, depresi, serta peningkatan ketahanan psikologis dalam menghadapi situasi stres yang tinggi, seperti beban kerja yang dialami tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 (Ji et al., 2021; Rosa et al., 2021).

## **3. Pengaruh Aktivitas Fisik pada Neuroplastisitas dan Fungsi Kognitif**

Neuroplastisitas merujuk pada kemampuan otak untuk beradaptasi, mereorganisasi diri, serta menciptakan koneksi saraf baru sebagai respons terhadap berbagai rangsangan. Studi terkini menemukan bahwa aktivitas fisik teratur mampu meningkatkan neuroplastisitas dengan merangsang produksi Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), protein penting yang mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel saraf serta koneksi antar neuron (Basso et al., 2021; Stillman et al., 2020).

BDNF secara khusus berperan dalam melindungi otak dari efek negatif stres kronis serta mendukung fungsi kognitif, seperti memori, atensi, dan pengambilan keputusan. Tenaga kesehatan yang mengalami beban kerja tinggi dan tekanan psikologis selama pandemi memerlukan fungsi kognitif yang optimal untuk mengambil keputusan cepat, efektif, dan akurat. Melalui peningkatan neuroplastisitas, aktivitas fisik mampu secara signifikan menjaga fungsi kognitif sekaligus memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penurunan fungsi otak akibat stres kronis yang terus-menerus dialami selama pandemi COVID-19 (Basso et al., 2021; Mandolesi et al., 2021).

Dengan demikian, mekanisme fisiologis melalui neurotransmitter, hormon kortisol, dan peningkatan neuroplastisitas menjadikan aktivitas fisik sebagai strategi intervensi berbasis bukti yang efektif dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi.

### **C. Aktivitas Fisik dan Pengurangan Gejala Gangguan Mental pada Tenaga Kesehatan**

---

Tenaga kesehatan yang bekerja selama pandemi COVID-19 menghadapi tekanan psikologis yang berat, yang dapat menyebabkan berbagai gangguan mental seperti kecemasan, depresi, burnout, dan stres kronis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu intervensi efektif untuk menurunkan gejala gangguan mental ini (Bushell et al., 2022; López-Bueno et al., 2021).

#### **1. Efektivitas Latihan Aerobik dalam Menurunkan Gejala Kecemasan dan Depresi pada Tenaga Kesehatan**

Latihan aerobik, seperti berlari, bersepeda, berenang, atau jalan cepat, terbukti secara ilmiah efektif menurunkan gejala kecemasan dan depresi. Studi yang dilakukan oleh López-Bueno et al. (2021) selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa tenaga kesehatan yang rutin melakukan latihan aerobik setidaknya 150 menit per minggu mengalami penurunan signifikan pada gejala kecemasan dan depresi dibandingkan dengan kelompok yang kurang aktif secara fisik. Efek positif latihan aerobik tersebut diduga berkaitan dengan peningkatan hormon endorfin dan serotonin serta penurunan kadar hormon kortisol yang berdampak langsung terhadap mood dan suasana hati (Stubbs et al., 2023; Ji et al., 2021).

Penelitian serupa oleh Stanton et al. (2020) menegaskan bahwa latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan skor kecemasan pada tenaga kesehatan, terutama saat dikombinasikan dengan intervensi psikologis lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa latihan aerobik merupakan pendekatan terjangkau, mudah diterapkan, dan efektif dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi.

#### **2. Latihan Yoga sebagai Intervensi untuk Mengurangi Burnout pada Perawat Selama Pandemi**

Burnout merupakan salah satu gangguan mental yang paling sering dialami oleh perawat selama masa pandemi COVID-19. Burnout ditandai dengan kelelahan emosional, depersonalisasi, serta penurunan rasa pencapaian personal. Bushell et al. (2022) dalam tinjauan sistematis dan meta-analisisnya menemukan bahwa latihan yoga secara signifikan mengurangi gejala burnout pada perawat



yang terlibat langsung dalam pelayanan COVID-19. Yoga, dengan fokusnya pada pernapasan dalam, meditasi, dan peregangan, secara efektif menurunkan respons fisiologis stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mengembalikan keseimbangan emosional tenaga kesehatan (Bushell et al., 2022; Kim et al., 2021).

Studi lainnya oleh Sharma et al. (2022) mengungkapkan bahwa intervensi yoga selama delapan minggu mampu secara signifikan meningkatkan ketahanan psikologis (resilience), menurunkan tingkat stres, serta meningkatkan kualitas tidur para perawat selama pandemi. Yoga tidak hanya berkontribusi terhadap kesehatan mental, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan sehingga menjadi pilihan intervensi yang sangat relevan bagi tenaga kesehatan selama masa krisis.

### **3. Dampak Latihan Kekuatan (Strength Training) dalam Mengurangi Stres Kronis dan Memperbaiki Mood**

Selain latihan aerobik dan yoga, latihan kekuatan (strength training) seperti angkat beban atau resistance training juga memiliki peran penting dalam mengurangi gejala stres kronis serta memperbaiki mood tenaga kesehatan. Gerber et al. (2022) dalam kajian sistematisnya menemukan bahwa latihan kekuatan secara rutin, sekitar 2–3 kali seminggu, memberikan dampak positif dalam mengurangi kadar stres kronis dan meningkatkan suasana hati secara signifikan. Efek ini terjadi melalui mekanisme fisiologis, seperti pelepasan neurotransmitter dopamin dan serotonin yang lebih tinggi serta pengurangan hormon stres kortisol (Mandolesi et al., 2021).

Penelitian oleh Gordon et al. (2021) juga mendukung bahwa latihan kekuatan tidak hanya membantu dalam pengelolaan stres, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan energi, serta meningkatkan kualitas tidur, aspek-aspek penting yang turut berkontribusi dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dengan demikian, latihan kekuatan menjadi alternatif yang efektif, terutama bagi tenaga kesehatan yang memerlukan aktivitas fisik intensitas tinggi yang dapat dilakukan dalam durasi waktu yang relatif singkat namun tetap memberikan manfaat besar dalam menjaga kesehatan mental.

Melalui berbagai bukti ilmiah tersebut, aktivitas fisik dalam bentuk latihan aerobik, yoga, maupun latihan kekuatan terbukti efektif menurunkan berbagai gejala gangguan mental pada tenaga kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19.

#### **D. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan**

---

Pemilihan jenis aktivitas fisik yang tepat menjadi penting untuk meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Penelitian terbaru telah merekomendasikan beberapa jenis aktivitas fisik yang efektif untuk mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memperbaiki ketahanan mental (Chekroud et al., 2021; Ammar et al., 2021; Wong et al., 2022).

##### **1. Latihan Aerobik (jalan cepat, berlari, bersepeda)**

Latihan aerobik, termasuk jalan cepat, berlari, atau bersepeda, telah terbukti secara konsisten efektif dalam meningkatkan suasana hati serta menurunkan gejala depresi dan kecemasan (Ammar et al., 2021). Latihan aerobik meningkatkan detak jantung, peredaran darah, dan oksigenasi otak, yang kemudian memicu pelepasan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan endorfin. Hal ini berkontribusi terhadap perasaan nyaman, bahagia, dan rileks pada tenaga kesehatan (López-Bueno et al., 2021).

Studi eksperimental Ammar et al. (2021) menemukan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan latihan aerobik secara teratur selama minimal 30 menit sehari, 3–5 kali per minggu, mengalami penurunan signifikan gejala stres dan peningkatan mood positif dibandingkan tenaga kesehatan yang tidak aktif secara fisik. Oleh karena itu, aktivitas aerobik sangat direkomendasikan sebagai bagian dari rutinitas harian tenaga kesehatan, terutama selama masa pandemi.

##### **2. Yoga, Tai Chi, dan Mindfulness Movement untuk Mengelola Stres dan Meningkatkan Ketahanan Mental**

Yoga, tai chi, dan mindfulness movement merupakan jenis latihan fisik yang menggabungkan gerakan tubuh dengan teknik pernapasan dan meditasi, terbukti efektif dalam menurunkan stres serta meningkatkan ketahanan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 (Wong et al., 2022; Bushell et al., 2022).

Penelitian oleh Wong et al. (2022) mengungkapkan bahwa latihan yoga dan tai chi secara rutin, minimal 2–3 kali seminggu selama 45–60 menit per sesi, mampu secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, serta memperkuat ketahanan mental pada tenaga kesehatan. Efek positif dari yoga dan tai chi terutama disebabkan oleh stimulasi sistem saraf parasimpatis yang memberikan efek relaksasi, menurunkan denyut jantung, tekanan darah, serta mengurangi produksi hormon stres seperti kortisol (Sharma et al., 2022).

Mindfulness movement juga terbukti efektif karena menekankan perhatian penuh (mindfulness) pada setiap gerakan tubuh, meningkatkan kesadaran diri, dan membantu tenaga kesehatan mengelola emosi negatif yang muncul akibat

tekanan pekerjaan (Bushell et al., 2022; Kim et al., 2021). Dengan demikian, yoga, tai chi, dan mindfulness movement menjadi jenis latihan fisik yang direkomendasikan untuk tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan mental di masa pandemi.

### **3. Latihan Kekuatan dan Resistensi sebagai Strategi Mengatasi Kelelahan Mental dan Fisik**

Latihan kekuatan (strength training) seperti angkat beban, resistance training, serta latihan berbasis resistensi tubuh (bodyweight exercises) juga sangat direkomendasikan sebagai strategi mengatasi kelelahan mental dan fisik yang sering dialami tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 (Chekroud et al., 2021; Gerber et al., 2022).

Chekroud et al. (2021) dalam kajian komprehensifnya menemukan bahwa tenaga kesehatan yang rutin menjalankan latihan kekuatan minimal dua kali per minggu melaporkan peningkatan energi, perbaikan suasana hati, penurunan gejala stres kronis, serta peningkatan kualitas tidur yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini berkaitan erat dengan efek latihan kekuatan dalam meningkatkan produksi neurotransmitter positif, seperti dopamin dan serotonin, serta meningkatkan kapasitas fisik yang secara langsung berkontribusi terhadap perbaikan kondisi mental (Gerber et al., 2022; Gordon et al., 2021).

Selain manfaat psikologis, latihan kekuatan juga berkontribusi dalam meningkatkan kebugaran fisik tenaga kesehatan, membantu mengatasi kelelahan fisik akibat beban kerja tinggi, serta memberikan rasa percaya diri dalam menghadapi tugas harian (Chekroud et al., 2021; Mandolesi et al., 2021).

Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian tersebut, jenis aktivitas fisik berupa latihan aerobik, yoga, tai chi, mindfulness movement, serta latihan kekuatan dan resistensi sangat direkomendasikan bagi tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan mental secara optimal, khususnya di masa pandemi COVID-19.

### **E. Frekuensi, Intensitas, dan Durasi Aktivitas Fisik Optimal untuk Tenaga Kesehatan**

Pengaturan frekuensi, intensitas, serta durasi aktivitas fisik merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Berbagai studi terbaru telah memberikan rekomendasi berbasis bukti mengenai parameter ini untuk mencapai hasil optimal dalam mengelola stres dan depresi di kalangan tenaga kesehatan (Marconcin et al., 2022; Duncan et al., 2022; WHO, 2021).

## **1. Rekomendasi WHO tentang Durasi Optimal Aktivitas Fisik Mingguan untuk Tenaga Kesehatan dalam Mengelola Stres dan Depresi**

World Health Organization (WHO, 2021) merekomendasikan durasi aktivitas fisik untuk orang dewasa, termasuk tenaga kesehatan, agar mencapai setidaknya 150 hingga 300 menit aktivitas fisik aerobik intensitas sedang, atau minimal 75 hingga 150 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi setiap minggunya. Kombinasi aktivitas aerobik sedang hingga tinggi juga dianjurkan. Selain itu, latihan kekuatan otot (*strength training*) yang melibatkan kelompok otot utama dianjurkan dilakukan setidaknya dua kali seminggu untuk mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh (WHO, 2021).

Rekomendasi WHO ini didukung oleh bukti penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa durasi aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu terbukti signifikan dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan gejala depresi, serta memperbaiki kualitas tidur dan daya tahan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 (Duncan et al., 2022; López-Bueno et al., 2021).

## **2. Efektivitas Aktivitas Fisik Ringan vs Berat dalam Menjaga Keseimbangan Mental**

Intensitas aktivitas fisik juga menjadi faktor penting dalam efektivitasnya terhadap kesehatan mental. Studi oleh Marconcin et al. (2022) secara khusus mengkaji efektivitas aktivitas fisik ringan versus berat dalam menjaga kesehatan mental selama masa pandemi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik aktivitas fisik ringan (misalnya berjalan santai, *stretching* ringan, yoga ringan) maupun berat (misalnya berlari, bersepeda cepat, angkat beban) secara umum memberikan manfaat kesehatan mental yang positif.

Namun, aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat cenderung memberikan dampak yang lebih signifikan dalam penurunan gejala kecemasan, depresi, serta peningkatan kualitas tidur dibandingkan aktivitas intensitas ringan. Hal ini terjadi karena aktivitas fisik intensitas tinggi lebih efektif dalam meningkatkan pelepasan hormon endorfin, serotonin, dan dopamin yang berkaitan langsung dengan suasana hati dan pengurangan gejala stres secara keseluruhan (Stubbs et al., 2023; Ji et al., 2021).

Meski demikian, aktivitas fisik ringan juga memiliki keunggulan karena lebih mudah diterapkan, terutama bagi tenaga kesehatan yang mengalami kelelahan kronis atau keterbatasan waktu untuk melakukan latihan fisik intensitas tinggi. Dengan demikian, kombinasi dari kedua tingkat intensitas tersebut dapat memberikan hasil optimal dalam menjaga kesehatan mental (Marconcin et al., 2022).

### 3. Strategi Integrasi Aktivitas Fisik dalam Jadwal Kerja Tenaga Kesehatan yang Padat Selama Pandemi

Tenaga kesehatan menghadapi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan aktivitas fisik dalam jadwal kerja yang padat. Duncan et al. (2022) merekomendasikan beberapa strategi praktis berbasis bukti untuk membantu tenaga kesehatan menerapkan aktivitas fisik secara konsisten selama masa pandemi. Strategi ini antara lain mencakup:

- a. **Micro-break exercise**, yaitu aktivitas fisik singkat selama 5-10 menit di antara jam kerja, seperti peregangan ringan, berjalan cepat, atau senam sederhana, yang terbukti efektif mengurangi stres akut serta kelelahan mental (Duncan et al., 2022).
- b. **Penerapan aktivitas fisik berbasis kelompok atau komunitas di lingkungan kerja**, yang membantu meningkatkan motivasi dan konsistensi dalam berolahraga. Misalnya, latihan aerobik singkat bersama rekan kerja, atau yoga kelompok yang difasilitasi di tempat kerja (Bushell et al., 2022; Sharma et al., 2022).
- c. **Pemanfaatan teknologi digital**, seperti aplikasi mobile atau perangkat wearable untuk membantu tenaga kesehatan memantau durasi dan intensitas aktivitas fisik secara mandiri, meningkatkan kepatuhan, serta mempermudah integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas harian (García-Bravo et al., 2022).

Strategi integrasi tersebut memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh tenaga kesehatan untuk menjaga konsistensi aktivitas fisik dalam keseharian mereka, meskipun di tengah tekanan kerja yang tinggi selama pandemi.

Berdasarkan rekomendasi dan temuan penelitian tersebut, tenaga kesehatan diharapkan dapat menerapkan aktivitas fisik dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang optimal guna menjaga kesehatan mental serta meningkatkan kualitas hidup selama pandemi COVID-19.

### F. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik pada Tenaga Kesehatan

---

Implementasi aktivitas fisik secara konsisten pada tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 menghadapi berbagai tantangan sekaligus dukungan yang signifikan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa identifikasi faktor-faktor tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan program kesehatan mental berbasis aktivitas fisik di lingkungan tenaga kesehatan (Pengpid & Peltzer, 2022; Lackinger et al., 2022).

## **1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik**

Penelitian terbaru mengidentifikasi sejumlah faktor yang secara positif mendukung pelaksanaan aktivitas fisik pada tenaga kesehatan selama pandemi, antara lain:

### **a. Fasilitas yang Memadai**

Ketersediaan fasilitas olahraga di tempat kerja, seperti ruang fitness, tempat yoga, atau fasilitas olahraga outdoor sangat meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam aktivitas fisik. Pengpid & Peltzer (2022) menemukan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki akses mudah ke fasilitas olahraga menunjukkan tingkat kepatuhan lebih tinggi terhadap rekomendasi aktivitas fisik, yang secara langsung berdampak positif terhadap kesehatan mental mereka.

### **b. Kebijakan Organisasi yang Mendukung**

Kebijakan institusi kesehatan yang mempromosikan aktivitas fisik secara aktif menjadi faktor penting dalam implementasi aktivitas fisik yang efektif. Studi oleh Clemente-Suárez et al. (2022) menunjukkan bahwa institusi yang menerapkan kebijakan fleksibel seperti jam kerja fleksibel, rehat aktif singkat (active breaks), serta program olahraga terstruktur cenderung memiliki tenaga kesehatan yang lebih sehat secara mental dibandingkan institusi yang tidak memiliki kebijakan serupa.

### **c. Dukungan Sosial**

Dukungan sosial dari rekan kerja, keluarga, maupun atasan secara signifikan meningkatkan motivasi tenaga kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas fisik. Penelitian oleh Pengpid & Peltzer (2022) menemukan bahwa tenaga kesehatan dengan dukungan sosial kuat memiliki tingkat partisipasi aktivitas fisik yang lebih tinggi, disertai perbaikan signifikan pada kondisi mental, termasuk menurunnya gejala stres dan depresi.

### **d. Motivasi Internal**

Motivasi internal atau intrinsik tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor psikologis penting yang menentukan konsistensi mereka dalam menjalankan aktivitas fisik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan tingkat motivasi internal tinggi, seperti kesadaran akan manfaat kesehatan serta keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi, cenderung lebih konsisten dalam menjalani rutinitas aktivitas fisik selama masa pandemi COVID-19 (Duncan et al., 2022; García-Bravo et al., 2022).

## **2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik**

Meskipun banyak faktor pendukung, sejumlah hambatan juga diidentifikasi menjadi tantangan dalam implementasi aktivitas fisik yang konsisten, terutama selama pandemi COVID-19, antara lain:

**a. Waktu Terbatas**

Keterbatasan waktu merupakan hambatan terbesar dalam melaksanakan aktivitas fisik bagi tenaga kesehatan, terutama dengan meningkatnya beban kerja selama pandemi. Penelitian oleh Lackinger et al. (2022) mengungkapkan bahwa banyak tenaga kesehatan kesulitan meluangkan waktu untuk berolahraga karena jam kerja panjang, jadwal tidak teratur, serta tuntutan tugas yang meningkat selama masa pandemi.

**b. Kelelahan Fisik dan Mental**

Kelelahan fisik dan mental akibat tekanan pekerjaan yang tinggi menjadi faktor signifikan yang menghambat tenaga kesehatan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Lackinger et al. (2022) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami kelelahan kronis cenderung lebih sulit menjaga konsistensi dalam aktivitas fisik, meskipun menyadari manfaatnya bagi kesehatan mental mereka.

**c. Minimnya Fasilitas Olahraga di Lingkungan Kerja**

Ketiadaan atau minimnya fasilitas olahraga yang tersedia di lingkungan kerja juga menjadi hambatan signifikan dalam partisipasi aktivitas fisik. Tenaga kesehatan sering kali mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas olahraga menyebabkan mereka kurang termotivasi atau bahkan gagal menjalani aktivitas fisik secara rutin (Pengpid & Peltzer, 2022).

Mengetahui faktor pendukung dan hambatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam merancang intervensi yang efektif, relevan, serta mudah diterapkan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat mengatasi hambatan serta memanfaatkan faktor pendukung secara maksimal guna menjaga kesehatan mental dan fisik mereka selama pandemi COVID-19.

## **G. Model dan Strategi Implementasi Program Aktivitas Fisik di Lingkungan Kerja**

Implementasi program aktivitas fisik di lingkungan kerja telah terbukti sebagai pendekatan strategis yang efektif untuk meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Berbagai studi terbaru telah mengidentifikasi beberapa model dan strategi yang dapat diterapkan secara efektif di tempat kerja (Proper & van Oostrom, 2021; García-Bravo et al., 2022; Clemente-Suárez et al., 2022).

### **1. Program Berbasis Tempat Kerja (Workplace-based Program) untuk Mendorong Partisipasi Tenaga Kesehatan dalam Aktivitas Fisik**

Program berbasis tempat kerja merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aktivitas fisik langsung ke dalam rutinitas harian tenaga kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas program tersebut dalam menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Proper & van Oostrom (2021) dalam kajian sistematisnya menemukan bahwa implementasi program olahraga atau latihan fisik yang secara langsung disediakan di tempat kerja, seperti kelas yoga mingguan, sesi senam pagi, atau latihan aerobik terjadwal secara rutin, terbukti meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan secara signifikan.

Beberapa komponen penting yang mendukung efektivitas program berbasis tempat kerja ini meliputi dukungan penuh dari manajemen organisasi, penyediaan fasilitas olahraga di lingkungan kerja, pelaksanaan jadwal yang fleksibel, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Hal ini berkontribusi pada terciptanya budaya organisasi yang menghargai dan memprioritaskan kesehatan fisik serta mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 (Proper & van Oostrom, 2021; Clemente-Suárez et al., 2022).

### **2. Pemanfaatan Teknologi Digital (*Mobile Apps, Wearable Devices*) untuk Memonitor dan Meningkatkan Kepatuhan Aktivitas Fisik**

Kemajuan teknologi digital telah memberikan alternatif baru dalam mempromosikan serta meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap aktivitas fisik. García-Bravo et al. (2022) mengidentifikasi bahwa penggunaan aplikasi mobile dan perangkat wearable (seperti smartwatch atau fitness tracker) dapat secara signifikan meningkatkan motivasi dan kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan aktivitas fisik secara rutin.

Melalui teknologi ini, tenaga kesehatan dapat secara mandiri memonitor frekuensi, intensitas, durasi aktivitas fisik, serta memantau progres kesehatan mereka secara real-time. Aplikasi mobile dan wearable devices juga mampu memberikan pengingat otomatis, feedback langsung, serta program latihan personal yang disesuaikan dengan kondisi individu. Hasil studi terbaru menegaskan bahwa integrasi teknologi digital ini efektif meningkatkan konsistensi aktivitas fisik tenaga kesehatan serta memperbaiki kesejahteraan mental mereka selama masa pandemi (García-Bravo et al., 2022; Duncan et al., 2022).



### **3. Contoh Sukses Implementasi Program Aktivitas Fisik untuk Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi di Beberapa Negara**

Sejumlah negara telah berhasil mengimplementasikan program aktivitas fisik khusus bagi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19, dengan hasil yang sangat positif. Studi oleh Clemente-Suárez et al. (2022) menunjukkan beberapa contoh implementasi sukses tersebut, antara lain:

- a. Program di Spanyol**, yang mengintegrasikan sesi latihan aerobik singkat (micro-break exercises) selama 10–15 menit di sela-sela jadwal kerja yang padat di rumah sakit, terbukti efektif menurunkan stres akut, meningkatkan energi, serta meningkatkan suasana hati tenaga kesehatan.
- b. Program di Inggris**, yang menerapkan kebijakan aktif berupa penyediaan kelas yoga virtual secara rutin setiap minggu untuk tenaga kesehatan, berhasil menurunkan gejala burnout secara signifikan, meningkatkan ketahanan mental, serta memperbaiki kualitas tidur tenaga kesehatan.
- c. Program di Amerika Serikat**, melalui pendekatan penggunaan teknologi digital (aplikasi kesehatan mental dan olahraga) yang difasilitasi oleh institusi kesehatan, berhasil meningkatkan konsistensi aktivitas fisik serta secara signifikan memperbaiki kesehatan mental dan kualitas hidup tenaga kesehatan selama masa pandemi.

Contoh-contoh ini menegaskan bahwa implementasi program aktivitas fisik yang tepat, baik secara langsung maupun berbasis teknologi, memberikan manfaat nyata dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan serta membantu mereka menghadapi tantangan psikologis di tengah pandemi COVID-19 (Clemente-Suárez et al., 2022).

Dengan mempertimbangkan berbagai strategi ini, institusi kesehatan dapat memilih model implementasi yang paling sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta sumber daya yang tersedia untuk memastikan keberhasilan program aktivitas fisik guna mendukung kesehatan mental tenaga kesehatan.

### **H. Evaluasi Efektivitas Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Evaluasi merupakan bagian penting dari program intervensi aktivitas fisik untuk tenaga kesehatan, terutama untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Evaluasi yang tepat akan membantu institusi dalam menentukan keberhasilan program, memperbaiki pelaksanaan di masa mendatang, serta memastikan pencapaian tujuan yang optimal (Jacob et al., 2021; Ruiz-Frutos et al., 2021).

## **1. Indikator Keberhasilan Program Aktivitas Fisik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mental Tenaga Kesehatan**

Dalam mengevaluasi efektivitas program aktivitas fisik, penentuan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur menjadi langkah penting. Penelitian terbaru oleh Jacob et al. (2021) menyebutkan beberapa indikator penting dalam mengukur keberhasilan program aktivitas fisik terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan selama masa pandemi, antara lain:

### **a. Penurunan Gejala Depresi dan Kecemasan**

Indikator ini mencakup penurunan skor pada instrumen standar seperti Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) atau Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Penurunan skor yang signifikan setelah pelaksanaan program aktivitas fisik menunjukkan efektivitas intervensi dalam mengelola kecemasan dan depresi.

### **b. Penurunan Tingkat Stres dan Burnout**

Evaluasi melalui instrumen seperti Maslach Burnout Inventory (MBI) dapat menunjukkan apakah aktivitas fisik mampu menurunkan tingkat burnout yang dialami tenaga kesehatan. Keberhasilan intervensi akan tampak dalam pengurangan skor kelelahan emosional serta peningkatan pencapaian personal dan motivasi kerja.

### **c. Peningkatan Kualitas Tidur**

Menggunakan instrumen seperti Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), peningkatan kualitas tidur dapat menjadi indikator keberhasilan, mengingat kualitas tidur sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan mental secara umum.

### **d. Peningkatan Kesejahteraan Subjektif (Subjective Well-being)**

Indikator ini diukur melalui laporan diri tenaga kesehatan tentang peningkatan mood positif, perasaan bahagia, dan kepuasan hidup setelah rutin mengikuti aktivitas fisik.

### **e. Peningkatan Ketahanan Mental (Resilience)**

Pengukuran melalui instrumen seperti Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) untuk menentukan apakah aktivitas fisik berkontribusi pada peningkatan ketahanan psikologis tenaga kesehatan menghadapi stres selama pandemi.

Penetapan indikator tersebut penting untuk mengukur dampak nyata aktivitas fisik terhadap aspek kesehatan mental tenaga kesehatan secara objektif dan subjektif.

## **2. Metode Evaluasi dan Monitoring yang Dapat Digunakan untuk Menilai Dampak Aktivitas Fisik**

Penggunaan metode evaluasi yang tepat memastikan validitas hasil serta kemudahan dalam monitoring dampak aktivitas fisik pada tenaga kesehatan. Penelitian oleh Ruiz-Frutos et al. (2021) menunjukkan beberapa metode evaluasi dan monitoring yang efektif, antara lain:

### **a. Teknologi Wearable (Wearable Technology)**

Pemanfaatan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker memungkinkan pengukuran objektif terhadap intensitas, frekuensi, dan durasi aktivitas fisik yang dilakukan. Data dari perangkat ini juga dapat memberikan informasi tentang pola tidur, detak jantung istirahat, serta tingkat stres fisik harian, yang semuanya berhubungan erat dengan kondisi kesehatan mental tenaga kesehatan (García-Bravo et al., 2022).

### **b. Self-report Questionnaire**

Metode ini menggunakan kuesioner mandiri yang mudah diterapkan, seperti International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), untuk melacak aktivitas fisik mingguan tenaga kesehatan. Kuesioner ini efektif untuk mengevaluasi keteraturan, kepatuhan, serta persepsi tenaga kesehatan mengenai manfaat aktivitas fisik yang dilakukan.

### **c. Instrumen Pengukuran Stres, Kecemasan, dan Depresi (Skala DASS-21)**

Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) merupakan instrumen valid dan reliabel yang secara khusus mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stres secara bersamaan. Penggunaan instrumen ini sebelum dan sesudah implementasi program aktivitas fisik memungkinkan evaluasi dampak secara objektif terhadap perubahan gejala gangguan mental yang dialami tenaga kesehatan.

Metode kombinasi antara teknologi wearable, self-report questionnaire, serta instrumen psikometri seperti DASS-21 memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat tentang dampak aktivitas fisik terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19.

Melalui evaluasi yang tepat dengan indikator dan metode yang jelas, institusi kesehatan dapat memastikan efektivitas program aktivitas fisik serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan di masa mendatang.

## **I. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Kebijakan Kesehatan**

---

Penyusunan kebijakan kesehatan berbasis bukti menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan, termasuk aktivitas fisik, dapat secara

efektif meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Penelitian terbaru menegaskan bahwa integrasi aktivitas fisik dalam kebijakan institusi kesehatan secara signifikan mampu menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental tenaga kesehatan (WHO, 2022; Schuch & Stubbs, 2023).

### **1. Integrasi Aktivitas Fisik dalam Kebijakan Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan di Institusi Kesehatan**

World Health Organization (WHO, 2022) telah merekomendasikan secara eksplisit agar aktivitas fisik diintegrasikan dalam kebijakan institusi kesehatan sebagai salah satu komponen penting dalam strategi menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan. WHO menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Promosi aktivitas fisik secara rutin** di lingkungan kerja tenaga kesehatan melalui program olahraga terstruktur, seperti kelas aerobik, yoga, atau aktivitas fisik kelompok lainnya secara berkala.
- b. Penyediaan fasilitas olahraga yang mudah diakses**, seperti ruang olahraga atau area terbuka yang nyaman dan aman, sehingga tenaga kesehatan dapat secara praktis melakukan aktivitas fisik dalam kesehariannya.
- c. Dukungan terhadap pelaksanaan micro-break exercises**, yakni sesi singkat aktivitas fisik (5–10 menit) di sela-sela jadwal kerja, sebagai upaya praktis untuk mengurangi kelelahan mental dan meningkatkan fokus selama masa kerja.
- d. Program edukasi dan pelatihan** bagi tenaga kesehatan mengenai manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan mental, serta memberikan panduan praktis yang dapat mereka aplikasikan secara mandiri maupun bersama tim kerja (WHO, 2022).

Penelitian terbaru oleh Clemente-Suárez et al. (2022) juga mengkonfirmasi bahwa institusi kesehatan yang telah mengintegrasikan kebijakan aktivitas fisik secara sistematis berhasil meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan, menurunkan tingkat stres kronis, kecemasan, serta gejala depresi secara signifikan dibandingkan institusi tanpa kebijakan sejenis.

### **2. Pengembangan Kebijakan Institusional yang Mendukung Aktivitas Fisik sebagai Bagian dari Manajemen Stres Tenaga Kesehatan**

Kebijakan institusional yang secara khusus mendukung aktivitas fisik sebagai bagian integral dari manajemen stres tenaga kesehatan terbukti memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Schuch dan Stubbs (2023) merekomendasikan beberapa langkah penting dalam pengembangan kebijakan institusional tersebut, di antaranya:

- a. Penetapan waktu khusus aktivitas fisik** selama jam kerja, misalnya melalui kebijakan jadwal kerja fleksibel atau alokasi waktu khusus selama 30 menit hingga satu jam dalam sehari untuk aktivitas fisik.
- b. Peningkatan dukungan organisasi** dalam bentuk fasilitasi pelatihan atau bimbingan profesional (trainer/instruktur olahraga), yang dapat membantu tenaga kesehatan memulai serta menjaga konsistensi aktivitas fisik mereka.
- c. Pemberian insentif atau reward** berbasis partisipasi dalam aktivitas fisik, yang dapat meningkatkan motivasi internal tenaga kesehatan dalam mengikuti program tersebut secara konsisten.
- d. Integrasi pemantauan kesehatan secara rutin**, baik melalui teknologi digital seperti wearable devices maupun self-report monitoring, untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini (Schuch & Stubbs, 2023; García-Bravo et al., 2022).

Penelitian oleh Duncan et al. (2022) juga menegaskan bahwa kebijakan institusional yang mendukung aktivitas fisik secara aktif dapat mengurangi prevalensi burnout dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan tenaga kesehatan. Institusi yang secara proaktif mengembangkan kebijakan ini terbukti lebih efektif dalam menangani tantangan psikologis yang dihadapi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan berbagai rekomendasi berbasis bukti tersebut, sangat penting bagi institusi kesehatan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang secara eksplisit mendukung aktivitas fisik sebagai bagian integral dari strategi kesehatan mental tenaga kesehatan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental individu, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

## **J. Penutup**

---

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap tenaga kesehatan, meningkatkan risiko berbagai gangguan mental seperti kecemasan, depresi, stres kronis, dan burnout. Dalam konteks ini, aktivitas fisik muncul sebagai intervensi nonfarmakologis yang efektif dan terjangkau untuk menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan (López-Bueno et al., 2021; Stubbs et al., 2023). Melalui berbagai mekanisme fisiologis, seperti peningkatan pelepasan neurotransmitter serotonin, dopamin, dan endorfin serta penurunan hormon stres kortisol, aktivitas fisik terbukti secara konsisten dapat memperbaiki suasana hati, menurunkan gejala kecemasan, dan meningkatkan ketahanan mental (Kandola et al., 2022; Basso et al., 2021).

Implementasi program aktivitas fisik yang berhasil membutuhkan pemahaman tentang jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan, seperti latihan aerobik, yoga, tai chi, mindfulness movement, serta latihan kekuatan dan resistensi, dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang sesuai (Ammar et al., 2021; Bushell et al., 2022; Chekroud et al., 2021). Di samping itu, institusi kesehatan perlu mengatasi hambatan umum, seperti waktu terbatas dan kelelahan kronis tenaga kesehatan, serta mengoptimalkan faktor pendukung, termasuk kebijakan institusi, dukungan sosial, fasilitas olahraga, dan motivasi internal tenaga kesehatan (Pengpid & Peltzer, 2022; Lackinger et al., 2022).

Evaluasi efektivitas program aktivitas fisik juga penting untuk memastikan keberhasilannya dalam memperbaiki kesehatan mental tenaga kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital seperti perangkat wearable, instrumen psikometri standar (DASS-21), serta kuesioner mandiri telah terbukti efektif untuk evaluasi dan monitoring dampak aktivitas fisik (Ruiz-Frutos et al., 2021; García-Bravo et al., 2022).

Secara keseluruhan, integrasi aktivitas fisik dalam kebijakan institusional sebagai bagian integral dari program kesehatan mental merupakan langkah strategis yang didukung oleh berbagai penelitian terbaru. Kebijakan yang mendukung aktivitas fisik tidak hanya mampu meningkatkan kesehatan mental tenaga kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan kesehatan secara umum (WHO, 2022; Schuch & Stubbs, 2023).

## **K. Rekomendasi Penelitian Lanjutan**

---

Walaupun sudah banyak penelitian yang mendukung manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat implementasinya:

### **1. Penelitian Longitudinal dengan Sampel Besar**

Penelitian longitudinal jangka panjang dengan sampel besar diperlukan untuk mengevaluasi dampak berkelanjutan aktivitas fisik terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, terutama setelah pandemi. Studi semacam ini dapat memperjelas efektivitas jangka panjang dan kesinambungan manfaat aktivitas fisik dalam mengelola stres serta mencegah gangguan mental.

### **2. Kajian Implementasi Program Berbasis Teknologi Digital**

Penelitian lanjutan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring aktivitas fisik perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini mencakup identifikasi teknologi spesifik yang paling efektif serta metode terbaik dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam rutinitas kerja tenaga kesehatan.

### **3. Studi Intervensi Kombinasi Aktivitas Fisik dan Pendekatan Psikologis**

Kajian yang mengkombinasikan aktivitas fisik dengan pendekatan psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) atau mindfulness perlu dikembangkan untuk mengevaluasi apakah kombinasi ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan implementasi tunggal.

### **4. Penelitian Kualitatif tentang Persepsi dan Pengalaman Tenaga Kesehatan**

Penelitian kualitatif diperlukan untuk memahami secara mendalam persepsi, hambatan pribadi, motivasi internal, serta preferensi tenaga kesehatan terkait aktivitas fisik. Informasi ini penting untuk merancang program intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi spesifik tenaga kesehatan di lapangan.

### **5. Evaluasi Kebijakan Institusional di Berbagai Negara dan Budaya**

Studi komparatif yang mengkaji efektivitas berbagai kebijakan institusional tentang aktivitas fisik di berbagai negara atau konteks budaya berbeda diperlukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat adaptif serta efektif secara universal.

Dengan melanjutkan berbagai rekomendasi penelitian ini, institusi kesehatan dapat memperoleh wawasan lebih luas mengenai strategi optimal untuk implementasi aktivitas fisik, yang pada akhirnya memperkuat kesehatan mental tenaga kesehatan secara berkelanjutan.

## **L. Referensi**

- 
- Alsaman, A., Jahrami, H., & BaHammam, A. (2020). Regular physical exercise and mental health in healthcare providers during COVID-19 pandemic: a systematic review. *Frontiers in Psychology, 11*, 590276.
- Ammar, A., et al. (2021). Psychological consequences of COVID-19 home confinement: The ECLB-COVID19 multicenter study. *Frontiers in Psychology, 12*, 618061.
- Basso, J.C., et al. (2021). Neurobiological effects of physical exercise: A systematic review. *Journal of Neuropsychology, 15*(2), 147–180.
- Bushell, W.C., et al. (2022). Yoga and healthcare worker burnout: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Clinical Practice, 46*, 101535.
- Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2021). Physical activity and mental health. Diakses dari [cdc.gov](https://www.cdc.gov).
- Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2021). Workplace health promotion: Physical activity policy recommendations. Diakses dari [cdc.gov](https://www.cdc.gov).
- Chekrout, S.R., et al. (2021). Association between physical exercise and mental health in 1.2 million individuals in the USA: A cross-sectional study. *The Lancet Psychiatry, 8*(9), 739–748.

- Clemente-Suárez, V.J., et al. (2022). Physical activity intervention among healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), 902.
- Duncan, G.E., et al. (2022). Physical activity interventions among healthcare providers during COVID-19: A systematic review. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 64(3), 212–220.
- García-Bravo, S., et al. (2022). Digital health interventions promoting physical activity among healthcare workers: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(4), e33384.
- Gerber, M., et al. (2022). Acute and chronic effects of strength training on mental health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(3), 541–562.
- Gordon, B.R., et al. (2021). Effectiveness of resistance training for reducing depressive symptoms: Meta-analysis and meta-regression. *JAMA Psychiatry*, 78(6), 566–576.
- Jacob, L., et al. (2021). Effectiveness of physical activity interventions on mental well-being among healthcare workers during pandemics: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Occupational Health*, 63(1), e12215.
- Ji, C., et al. (2021). Physical exercise ameliorates anxiety disorders by modulating cortisol levels and neuroendocrine function. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 698264.
- Kandola, A., et al. (2022). Physical activity and mental health: Mechanisms of action. *European Journal of Neuroscience*, 55(4), 1032–1044.
- Kim, S.C., et al. (2021). Effectiveness of yoga for healthcare providers experiencing burnout: A systematic review. *Journal of Holistic Nursing*, 39(4), 312–324.
- Lackinger, C., et al. (2022). Barriers and facilitators of physical activity among healthcare professionals during COVID-19: A qualitative study. *Frontiers in Public Health*, 10, 914012.
- Lin, T.W., & Kuo, Y.M. (2021). Exercise benefits brain function: The monoamine connection. *Brain Sciences*, 11(10), 1303.
- López-Bueno, R., et al. (2021). Association between physical activity and mental health during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. *Psychiatry Research*, 295, 113618.
- Mandolesi, L., et al. (2021). Physical activity and cognitive functioning: A systematic review. *Journal of Neural Transmission*, 128(5), 651–679.
- Marconcin, P., et al. (2022). Effectiveness of moderate versus vigorous physical activity in mental health during COVID-19: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1624.



- Mayo Clinic. (2022). Exercise and stress: Get moving to manage stress. Diakses dari [mayoclinic.org](https://www.mayoclinic.org).
- Mayo Clinic. (2022). Fitness apps and wearable technology: How they help you stay active. Diakses dari [mayoclinic.org](https://www.mayoclinic.org).
- Pengpid, S., & Peltzer, K. (2022). Factors associated with physical activity among healthcare workers during COVID-19 pandemic: A multi-country study. *Healthcare, 10*(6), 1029.
- Proper, K.I., & van Oostrom, S.H. (2021). Workplace-based interventions promoting physical activity: A systematic review. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 47*(4), 245–255.
- Rosa, J., et al. (2021). Physical exercise decreases stress-induced cortisol secretion and anxiety symptoms in health workers: A randomized controlled trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(11), 5886.
- Ruiz-Frutos, C., et al. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health in healthcare workers: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(4), 1436.
- Salari, N., et al. (2020). Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Globalization and Health, 16*(1), 57.
- Schuch, F.B., & Stubbs, B. (2023). Exercise for the prevention and treatment of depression in healthcare workers during pandemics. *Journal of Psychiatric Research, 163*, 50–58.
- Sharma, N., et al. (2022). Impact of yoga on mental health and resilience among nurses during COVID-19 pandemic: A randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies Advances, 4*, 100089.
- Stanton, R., et al. (2020). Depression, anxiety, and stress during COVID-19: Associations with changes in physical activity, sleep, tobacco and alcohol use in Australian adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(11), 4065.
- Stillman, C.M., et al. (2020). Exercise-induced neuroplasticity in humans: A systematic review. *Frontiers in Human Neuroscience, 14*, 215.
- Stubbs, B., et al. (2023). Exercise for the prevention and treatment of depression in healthcare workers during pandemics. *Journal of Psychiatric Research, 163*, 50–58.
- Wong, V., et al. (2022). Effects of Tai Chi and Qigong on mental health of healthcare workers during COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(11), 6751.

World Health Organization [WHO]. (2021). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO.

World Health Organization [WHO]. (2022). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO.

# Profil Penulis



**Ns. Dwi Christina Rahayuningrum, M.Kep.** Lahir di Padang, 5 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Andalas tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Keperawatan Peminatan Keperawatan Jiwa pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di Universitas Syedza Saintika mengampu mata kuliah

Keperawatan Jiwa Psikososial, Keperawatan Psikiatri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [dwichristina05@gmail.com](mailto:dwichristina05@gmail.com)

Motto: "When you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals" **(opsional jika ingin ditambahkan)**



**Evi Yanti, SKM., M. Kes.** Lahir di Lhokseumawe, Aceh, 05 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Muhammadiyah, lulus pada tahun 2001 dan pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), lulus pada tahun 2006 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2013 dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun

2002 berkerja pada pusat Kesehatan Masyarakat samapai tahun 2007 selanjutnya berpindah bekerja pada Stikes Bumi Persada yang sekarang menjadi Universitas Bumi Persada. sejak tahun 2008 sampai sekarang mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi, Mutu Pelayanan Kesehatan, Askeb pada Komunitas dan Promosi Kesehatan pada kebidanan, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [eviyanti52@gmail.com](mailto:eviyanti52@gmail.com)

Motto: "Living your life well" Syukurin apa yang telah di dapatin dan terus berkarya demi kecerdasan anak bangsa dimasa depan



**Ns. Sri Hunun Widiastuti, M.Kep.,Sp.Kep.J** Lahir di Jakarta, 10 Mei 1964. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Akademi Perawatan RS PGI Cikini lulus tahun 1986, kemudian melanjutkan pada jenjang Strata 1 pada Fakultas Kedokteran, Program Studi Keperawatan Universitas Indonesia lulus pada tahun 1997. Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia peminatan pada program Keperawatan Jiwa dan lulus pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan ke Program Spesialisasi Keperawatan Jiwa Pada Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Keperawatan dan lulus pada tahun 2011.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 sebagai perawat pelaksana di ruang Penyakit Anak, rotasi keruang Penyakit Dalam, kemudian rotasi terakhir di pelayanan khusus Unit Haemodialisa RS PGI Cikini. Pada tahun 1990 diangkat menjadi Staf Pendidikan Akademi Perawatan RS PGI Cikini Jakarta Pusat dan tiga tahun kemudian menjadi Dosen Tetap Akademi Perawatan RS PGI Cikini Jakarta Pusat sebagai dosen pengampu Mata Kuliah Keperawatan Jiwa, Mata Kuliah Keperawatan Paliatif, Mata Kuliah Psikologi dan Mata Kuliah Keperawatan Dasar sampai dengan tahun 2024. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) Halim Perdana Kusuma mengampu Mata Kuliah Keperawatan Jiwa, Mata Kuliah Komunikasi dasar dan Mata Kuliah Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Keperawatan Jiwa, berbagai Modul Pengajaran, publikasi nasional, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail; [srihununw@gmail.com](mailto:srihununw@gmail.com)

**Motto:** "Together We Can ; Unconditional Love"



**Bd. Ike Fitrah Atul Chabibah, SST.,M.Kes., M.Keb.** Lahir di Blitar, 07 November 1989 Penulis menyelesaikan studi Diploma III Kebidanan di Universitas Kediri (2010), DIV Bidan Pendidik di Universitas Kediri (2011), Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Reproduksi) di Universitas Indonesia Timur (2016), dan telah selesai juga menempuh Pendidikan Pasca Sarjana Kebidanan di Universitas Aisyiah Yogyakarta (2022).

Penulis aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan seperti seminar, *workshop*, dan pelatihan. Selain itu penulis juga menjabat sebagai dosen tetap sekaligus Wakil Rektor I Bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Manado sejak tahun 2022-skrng dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas, Kegawatdaruratan Dalam Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Kompleksitas, Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan. Email aktif [ikefitrah@gmail.com](mailto:ikefitrah@gmail.com)

Motto: "Sebaik-baiknya Manusia adalah yang bermanfaat bagi oranglain"



**Saleha Salihun, S.Tr.Kes., M.Biomed** Lahir di Raha, 12 Mei 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Dustira Cimahi di prodi DIII Fisioterapi sejak 2022 sampai dengan sekarang mengampu mata kuliah Anatomi, Terapi Latihan, Terapi Sumber Fisis, Fisiologi Latihan dan Fisiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [salehasalihun862@gmail.com](mailto:salehasalihun862@gmail.com)  
Motto: "Kalau orang lain bisa kamu juga pasti bisa"

# Sinopsis Buku

Buku Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi merupakan karya referensi ilmiah yang membahas secara komprehensif berbagai tantangan psikologis yang dihadapi tenaga kesehatan selama pandemi. Bab I menyajikan pemetaan menyeluruh terhadap faktor-faktor risiko gangguan mental, seperti beban kerja berlebih, ketakutan terhadap infeksi, keterbatasan alat pelindung diri, serta minimnya dukungan sosial dan organisasi. Faktor psikologis, riwayat gangguan mental, serta ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan turut menjadi sorotan penting dalam memahami kompleksitas permasalahan mental yang muncul di kalangan tenaga medis.

Bab II berfokus pada edukasi tentang manajemen stres, dengan menguraikan konsep-konsep dasar kesehatan mental, mekanisme stres, hingga dampaknya terhadap tenaga kesehatan. Pembaca juga akan menemukan strategi pengelolaan stres yang efektif serta program dukungan psikososial yang relevan. Di sisi lain, Bab III mengangkat pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling, termasuk konseling daring yang menjadi solusi adaptif di masa pembatasan sosial. Penjelasan tentang efektivitas, tantangan implementasi, hingga tren masa depan teknologi konseling memperkaya pemahaman akan pendekatan digital dalam mendukung kesejahteraan mental tenaga kesehatan.

Bab IV hingga VI memperluas cakupan dengan membahas pengaruh beban kerja terhadap kondisi psikologis, pentingnya dukungan keluarga, dan peran aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan mental. Buku ini tidak hanya menyuguhkan teori dan data empiris, tetapi juga rekomendasi berbasis bukti yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan kesehatan dan praktik profesional. Diperkuat dengan berbagai kajian ilmiah terkini, buku ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta semua pihak yang peduli terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai pilar utama sistem pelayanan kesehatan.



Buku Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi merupakan karya referensi ilmiah yang membahas secara komprehensif berbagai tantangan psikologis yang dihadapi tenaga kesehatan selama pandemi. Bab I menyajikan pemetaan menyeluruh terhadap faktor-faktor risiko gangguan mental, seperti beban kerja berlebih, ketakutan terhadap infeksi, keterbatasan alat pelindung diri, serta minimnya dukungan sosial dan organisasi. Faktor psikologis, riwayat gangguan mental, serta ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan turut menjadi sorotan penting dalam memahami kompleksitas permasalahan mental yang muncul di kalangan tenaga medis.

Bab II berfokus pada edukasi tentang manajemen stres, dengan menguraikan konsep-konsep dasar kesehatan mental, mekanisme stres, hingga dampaknya terhadap tenaga kesehatan. Pembaca juga akan menemukan strategi pengelolaan stres yang efektif serta program dukungan psikososial yang relevan. Di sisi lain, Bab III mengangkat pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling, termasuk konseling daring yang menjadi solusi adaptif di masa pembatasan sosial.

Penjelasan tentang efektivitas, tantangan implementasi, hingga tren masa depan teknologi konseling memperkaya pemahaman akan pendekatan digital dalam mendukung kesejahteraan mental tenaga kesehatan.

Bab IV hingga VI memperluas cakupan dengan membahas pengaruh beban kerja terhadap kondisi psikologis, pentingnya dukungan keluarga, dan peran aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan mental. Buku ini tidak hanya menyuguhkan teori dan data empiris, tetapi juga rekomendasi berbasis bukti yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan kesehatan dan praktik profesional. Diperkuat dengan berbagai kajian ilmiah terkini, buku ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta semua pihak yang peduli terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai pilar utama sistem pelayanan kesehatan.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-63-0



9

786347

294630